TRANSCRIÇÕES DA 36ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

ADC 81

AUTORIZAÇÃO PARA NOVOS CURSOS DE MEDICINA

Ministro-Relator Gilmar Mendes



SUPEMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

SECRETARIA JUDICIÁRIA – SEJ

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO FINAL/GERÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO

DIA 17/10/2022 – MANHÃ

ABERTURA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Bom dia a todas e a todos que se fazem presentes!

Cumprimento inicialmente, em nossa Mesa, o Advogado-Geral da União, Doutor Bruno Bianco; o Subprocurador-Geral da União, Doutor Luiz Augusto Santos Lima; nosso Chefe de Gabinete, Doutor Paulo Sávio Maia; nosso Juiz Auxiliar, Doutor Lucas Faber, que vem acompanhando essa questão desde o início.

Cumprimento a todos os senhores expositores nas pessoas dos Ministros Marcelo Queiroga e Victor Godoy, que também se fazem presentes.

Cumprimento a todos os que se habilitaram para esta primeira parte da exposição e a todos os *experts* que também estão aqui representados, e faço um cumprimento especial na pessoa da Doutora Ludhmila Hajjar.

Senhores Ministros de Estado, Senhores Representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Senhor Subprocurador-Geral da República, Senhores Advogados, Senhores e Senhoras representantes da sociedade civil, caros servidores desta Casa.

De modo geral, a audiência pública consiste em instrumento que permite ao Supremo Tribunal Federal abertura às contribuições da sociedade civil,

alargando e aprofundando o conhecimento técnico necessário para adequar a solução da questão controvertida. Para além do aspecto técnico, portanto, ressalto o caráter democrático do instrumento.

Esta audiência não foge à regra e, quero crer, irá além porque tem por objetivo angariar subsídios técnicos e fáticos acerca da política pública instituída pela Lei nº 12.830/2013, mormente no que concerne aos impactos que a política de chamamento público acarreta na oferta, distribuição e qualidade dos médicos do Brasil. O tema, como sabemos, vem sendo constantemente discutido.

O tema reveste-se de relevância ímpar e envolve aspectos essenciais da materialização do comando explicitado no art. 196 da Constituição Federal em relação ao efetivo provimento de serviços de saúde a todos, bem como no que tange a sua qualidade. Um tema de complexidade evidente, que não se deixa abordar a partir de simples cotejo cego entre o dispositivo legal questionado e a letra fria do art. 196 da Constituição.

Aqui o objeto determina o método. A reflexão em torno da adequação constitucional da norma impõe esclarecimentos administrativos relativos à gestão e execução dessa política pública - bem como os concernentes ao ensino da Medicina - e econômicos, considerados os reflexos da intervenção estatal no respectivo mercado.

Se formos bem-sucedidos, os argumentos tecnicamente qualificados e especializados permitirão que esta Corte se debruce com maior segurança sobre os fatos que conformam a aplicação da norma impositiva do chamamento público e de outros requisitos para a instalação de novos cursos de graduação em Medicina à luz dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da isonomia, assim como do direito à saúde.

Com base nesse contexto, a presente audiência pública será norteada pelas seguintes questões: oferta de médicos no Brasil, sua evolução e distribuição no território nacional; recursos essenciais para o funcionamento adequado de cursos de graduação em Medicina; impacto da política pública estruturada pelo art. 3º da Lei 12.850, especialmente do requisito prévio do chamamento público na distribuição regional de médicos e na formação médica brasileira; dinâmica do mercado de cursos de graduação em Medicina, estrutura concorrencial e barreiras à entrada; atuação da Advocacia-Geral da União no enfrentamento de provimentos liminares em sentido amplo no âmbito temático em exame.

De acordo com programação previamente divulgada, teremos a contribuição de especialistas indicados por órgãos públicos e entidades privadas, que propiciarão ao Tribunal olhar plural condizente com problema multifacetado.

Considerando o significativo número de expositores, a brevidade do tempo e a paridade a ser observada na participação de cada um dos inscritos, é importante reforçar a necessidade de observância do tempo conferido a cada um dos senhores, que será rigorosamente fiscalizado, para garantir o cumprimento do cronograma e o bom andamento dos trabalhos, como já foi apontado de início aqui.

Por fim, ressalto que a realização de intervenções ou esclarecimento de dúvidas apenas serão permitidos, por intermédio da Presidência desta audiência, ao final de cada bloco ou período de exposições, sendo destinado exclusivamente às questões de interesse do processo e do Tribunal a serem definidas pelo Relator. Solicito a todos que observem essas e as demais regras estabelecidas, de modo que possamos ter um dia profícuo de trabalho

Como já foi apontado, esta é uma iniciativa pioneira, creio, pelo menos em tribunais da América do Sul e, talvez, da própria América Latina. Isso foi incorporado na nossa legislação a partir de 1999, retirando o caráter puramente abstrato do chamado controle abstrato de normas e permitindo que o Tribunal, em temas cada vez mais complexos que lhe são submetidos, busque haurir-se de informações todos os setores, dos setores públicos, dos setores privados, dos setores técnicos.

Em outro momento, discutimos aqui questões complexas do sistema prisional, discutimos a questão, por exemplo, de células-tronco - até hoje uma audiência pública muito lembrada - e, hoje, estamos submetendo ao Tribunal, trazendo à presença dos senhores, uma discussão também complexa, que se tornou um grande impasse, como se vê, com embates que se realizam em várias instâncias.

Com essas considerações, declaro aberta a audiência e desejo um bom trabalho a todos!

Inicio, desde logo, então, nossa primeira chamada de exposições, chamando a Doutora Professora Elizabeth Guedes, que disporá de dez minutos para sua exposição.

A SENHORA ELIZABETH GUEDES (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP) - Bom dia! Bom dia a Vossa Excelência, Ministro Gilmar Mendes!

Esta audiência pública é um momento muito importante para nós também, porque, em uma matéria tão controversa, todos teremos oportunidade de colocar nossas posições e explicar por que elas estão dessa forma e não de outra. Como Presidente da Anup, penso que devo começar explicando aos senhores a razão do nosso posicionamento e a razão pela qual entramos com a ADC 81.

Pareceu-nos, ao longo do ano de 2020, que alguma coisa estava começando a ocorrer no campo das liminares e da concessão de cursos de Medicina

por medidas judiciais. Vínhamos, em 2018, 2019, com 6, 7, 8 pedidos de liminares, passamos para 36 em 2020, fomos para 98 em 2021 e já estamos perto de 100 em 2022, com 8 cursos sendo aprovados no último ano, agora, em 2022, com um número de vagas muito acima das vagas normalmente concedidas, segundo a Lei do Mais Médicos, a nº 12.871/2013.

Chegamos à conclusão, Ministro Gilmar e demais autoridades, de que precisamos fazer a defesa institucional do marco legal. Havia uma controvérsia judicial que caracterizava uma enorme diferença de opinião entre juízes de várias partes do país, muitos concedendo, outros não concedendo, e isso trazia uma insegurança jurídica enorme para o setor.

Não podemos deixar de pensar que os cursos de graduação em Medicina são os cursos que mais possuem resiliência na questão da inadimplência e do abandono, e a pandemia trouxe uma redução drástica do número de alunos para várias instituições de ensino. Não posso só pensar que o curso de Medicina vai dar-me uma mensalidade alta, que me permitirá fazer caixa. É o contrário: você tem que ter recursos para montar um curso de Medicina. A Professora Patrícia Tempski vai falar sobre os recursos essenciais.

Estamos procurando, Ministro Gilmar, seguir suas perguntas e estou no item 4.

A Constituição diz que a educação é livre à iniciativa privada, mas também determina que isso acontecerá mediante autorização e avaliação do poder público. Isso me garante liberdade para empreender, mas não me garante o direito de empreender de qualquer forma, onde quiser, do jeito que quiser e onde me aprouver, para o meu planejamento estratégico, para o meu planejamento de negócios.

O art. 170, parágrafo único, diz justamente:

> "Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

Estamos falando da Lei nº 12.871/2013, que, durante quase 10 anos, vigorou e foi obedecida por sucessivos ministros. De repente, tivemos uma chuva, um festival de pedidos liminares. O que isso traz pra nós? A certeza de que não estou tentando burlar os critérios de seleção de mantenedores instituídos por portaria, nem tampouco por decreto. Estou tentando burlar critérios que foram mantidos plenamente durante nove, oito anos. Agora, só através de medidas judiciais, o Ministério está reconhecendo a necessidade de fazer essas portarias, depois que uma lei foi votada por senadores e deputados, no Congresso Nacional. Pensar que uma lei pode simplesmente ser destruída, que uma política de Estado pode ser negada por medidas liminares, é uma insegurança jurídica que não gostaríamos de ter no setor.

Quanto à questão dos grandes grupos econômicos, gostaria de dizer aos senhores que, das 5800 instituições de ensino que temos no Brasil, segundo o censo de 2020, temos mais de 54% delas com até 500 alunos - são pequenas instituições de ensino. Acima de 100 mil alunos, que hoje podemos considerar grandes grupos, não temos nem 2% das 2 mil.

Estou dizendo aos senhores que a concentração não ocorre no curso de Medicina. Os grandes são grandes porque lograram planos de trabalho, planejamento estratégico e competência para sobreviver no mercado concorrencial; crescendo, e não decrescendo. Temos 16% dos cursos de Medicina? É verdade, mas os grandes grupos também têm 16% dos cursos de engenharia e quase 19% dos cursos de educação. A concentração não se dá em função do Mais Médicos, ela se dá em função de aspectos regulatórios próprios da educação brasileira, que fez essa conformação de mercado, tanto que todas as aquisições precisam antes passar pelo Cade para que não haja nem controle nem concentração em determinada região de determinado ente econômico.

Quando misturamos todos esses assuntos em uma sopa só, renasce um protocolo que está fechado, renasce uma forma de autorização não permitida por lei, renasce uma conversa de que existe concentração de mercado quando o Cade analisa todos os aspectos das nossas operações. Digo "nossas" porque presido uma associação de universidades particulares. As universidades

particulares, 8, 9%, do número de instituições de educação superior, têm mais de 54% das matrículas. São as estruturas acadêmicas mais complexas e reúnem pesquisa e cursos de doutorado e mestrado. Essas são as estruturas próprias onde cursos da importância que um curso de Medicina, de formação médica, tem serão tratados com recursos de laboratório, com recursos de campo de prática que precisam.

Ministro Gilmar e Ministro Lucas, algumas vezes acontecerão barreiras de entrada sim, por impossibilidade de a rede local oferecer campo de prática para aquele curso. Se não há campo de prática, se não há estrutura pública, não podemos ter entrada de novos cursos, e isso é um requisito de qualidade. E qualidade é a única coisa que pretendemos obter aqui quando pedimos uma liminar. A liminar é importante porque vai dar tempo ao Estado de formular as melhorias que a Lei do Mais Médicos precisa para continuarmos oferecendo cursos que tenham garantia de conclusão e garantia de entrega de alunos bem formados na outra ponta.

É muito importante que os senhores prestem atenção nas contrapartidas que a Lei do Mais Médicos exige em relação ao curso de Medicina, e que não são exigidas na velhíssima Portaria nº 20, cujo instrumento de avaliação não deve ser utilizado.

Além das contrapartidas que visam a devolver valor à sociedade e garantir formação médica de qualidade, temos também a segurança da saúde e o desenvolvimento social da população que está ali.

Levar cursos de Medicina para o interior é levar para lá preceptores que não iriam, alunos que talvez não fossem. O objetivo não é fazer crescer a cidade; o objetivo é levar saúde e melhoria para a estrutura local do SUS.

Não querendo estourar nem ultrapassar meu tempo, agradecendo de novo, Ministro Gilmar, essa oportunidade, venho, em nome da Anup, pedir que a liminar seja concedida, que as questões de concentração de mercado sejam entendidas como traços da nossa regulação e não aspectos oriundos da Lei dos Mais Médicos e que possamos ter segurança institucional para continuar trabalhando de forma a obedecer a lei.

Agradeço muito, e contamos com os senhores para nos ajudar a salvar a educação médica no Brasil.

Obrigada!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado à Doutora Professora Elizabeth Guedes.

Eu passo, em seguida, a palavra ao Doutor Milton de Arruda Martins.

O SENHOR MILTON DE ARRUDA MARTINS (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP) - Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, cumprimento também todas as autoridades presentes, senhoras e senhores.

Sou professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador do seu curso de Medicina. Sou também assessor da Presidência do Conselho Federal de Medicina como coordenador executivo do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, do SAEM, criado em 2015, que já visitou 65 cursos de Medicina. Fui Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde do Ministério da Saúde de 2011 a 2012. E fui também Presidente da Associação Brasileira de Educação Médica de 2004 a 2008. Entendo que posso contribuir para essa discussão com uma visão bastante ampla.

A formação de médicos em número suficiente com formação de elevada qualidade e adequadamente distribuídos pelo território brasileiro é de grande importância para a sociedade.

A autorização de novos cursos de Medicina por medidas judiciais, sem respeitar a Lei nº 12.871 - Lei do Mais Médicos -, contribui para desorganizar o ensino médico no país, pode comprometer a qualidade da formação médica e trazer prejuízos para a sociedade.

Para autorização de novos cursos de medicina privados, a Lei nº 12.871 determinou, pela primeira vez no país, que haveria compromissos por parte do município e por parte da instituição selecionada para ter o curso de Medicina. Além disso, foi estabelecido um processo de acompanhamento desses cursos por uma comissão de especialistas. O município deve demonstrar necessidade e relevância social do curso de Medicina, infraestrutura de serviços de saúde adequada à formação de médicos e um projeto de melhoria dos equipamentos e programas da saúde.

As instituições privadas de ensino superior devem contribuir com a formação de profissionais do Sistema Único de Saúde, construir ou reformar serviços de saúde, adquirir equipamentos para o SUS local e pagar bolsas de residência médica.

Os cursos de Medicina selecionados a partir dos editais que seguiram a Lei do Mais Médicos são acompanhados por comissão de especialistas, com visitas periódicas, orientação aos gestores desses cursos e elaboração de relatórios ao MEC.

Nenhum desses compromissos é exigido quando um curso de Medicina é autorizado por decisão judicial. Esses cursos não são acompanhados de

perto, apenas haverá uma visita para reconhecimento do curso quando formar a primeira turma de médicos, após seis anos.

O novo curso de Medicina autorizado por meio de sentença judicial pode, inclusive, prejudicar a qualidade de curso já existente, se os dois estiverem localizados no mesmo município ou região de saúde. O sistema de saúde, que foi dimensionado para receber um curso, terá que receber dois. E as unidades de saúde preceptoras podem ser insuficientes nesse novo contexto.

Entretanto, é importante ressaltar que não há mais necessidade de cursos de medicina no Brasil.

No final de 2010, havia 186 cursos de Medicina. Entre 2011 e 2020, iniciaram suas atividades mais 167 cursos. Houve aumento de 90% em apenas 10 anos. Esse aumento, em tão curto espaço de tempo, não encontra paralelo em nenhuma época e em nenhum outro país.

Entre os 20 países com maior população, o Brasil, já em 2017, tinha a maior relação entre cursos de medicina e população: 1,67 cursos por milhão de habitantes.

Segundo o censo da educação superior de 2020, havia 204.279 estudantes matriculados em curso de medicina, o equivalente a quase 50% dos

médicos em atuação no país. É fácil prever que isso levará, em poucos anos, a grande aumento no número de médicos no Brasil.

Em 2019, a média de médicos formados por ano nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE foi de 13,5 médicos por 100.000 habitantes. Em 2026, o Brasil terá aproximadamente dezessete.

É importante reconhecer que é difícil estabelecer qual a relação ideal entre médicos e habitantes, quando há mudanças em grande velocidade na Medicina e na assistência da saúde a cada ano.

O grupo do Professor Mário Scheffer, da Universidade de São Paulo, estimou que o país vai chegar a 815.500 médicos no ano de 2030, atingindo a razão 3,63 médicos por 1000 habitantes. Essa razão será semelhante à média da Europa, que é de 3,66.

O maior problema em nosso país não será o número de médicos, mas sua distribuição, com concentração maior nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, nas capitais e cidades maiores e nas áreas centrais das grandes metrópoles, em detrimento das periferias.

É fundamental criar políticas públicas que distribuam melhor os médicos, oferecendo remuneração e condições de trabalho dignas, principalmente nas regiões com populações mais vulneráveis.

Um dos objetivos da Lei nº 12.871 foi promover redistribuição dos cursos para regiões do país com menos médicos. Houve um impacto muito positivo sobre o sistema de saúde local. No entanto, vários desses cursos estão com dificuldades em contratar docentes com preparo adequado. E, conforme estudo do Conselho Federal de Medicina, em várias dessas cidades, a rede de atenção à saúde não é suficiente para formação de estudantes de medicina.

Há, portanto, necessidade de avaliação do impacto das políticas decorrentes da Lei nº 12.871 na assistência à saúde das diferentes regiões do país, na formação de médicos e na fixação desses profissionais na região.

Mais importante do que o número de médicos, é sua competência, ética, responsabilidade profissional e social.

Formação médica depende da qualidade dos cursos de graduação, mas também da sua especialização e da sua educação continuada.

A prioridade em nosso país deve ser garantir e aprimorar a qualidade dos cursos existentes. Trata-se de processo complexo, que envolve professores qualificados e em número suficiente, projetos pedagógicos inovadores, infraestrutura adequada, compromisso da escola médica com a comunidade e rede regional do SUS, existência de rede de atenção à saúde suficiente para o ensino e o treinamento profissional, unidades de saúde, ambulatórios, leitos hospitalares, unidades de urgência.

Uma iniciativa que merece menção foi a criação do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, o SAEME, vinculado ao Conselho Federal de Medicina, o primeiro sistema de acreditação de cursos de Medicina da América do Sul reconhecido pela World Federation for Medical Education.

Um futuro necessário é avaliar rigorosamente os cursos de medicina existentes, não permitindo a continuidade dos que não tiverem condições de formar médicos de qualidade e só autorizar novos cursos que demonstrarem que oferecerão formação médica de excelência.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado Professor Milton de Arruda Martins.

Eu passo, de imediato, a palavra à Doutora Patrícia Tempski, que representa Associação Nacional das Universidades Particulares também.

A SENHORA PATRÍCIA TEMPSKI (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP) - Bom dia, Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes; bom dia, senhoras e senhores.

Eu sou Patrícia Tempski, médica pediatra, educadora e pesquisadora. Coordeno o Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou, atualmente, Secretária

Executiva do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas Brasileiras do Conselho Federal de Medicina, o Saeme.

Há 30 anos, eu abracei o propósito de contribuir com o ensino, a pesquisa e a formação de profissionais da saúde, tornando-me então a primeira médica livre-docente em educação na saúde no nosso país.

Assim como os senhores e senhoras, eu realmente acredito que a educação em saúde pode mudar o Brasil.

Todos aqui, sem dúvida nenhuma, querem bons médicos para cuidar de si e de suas famílias. Todos aqui querem que populações vulneráveis tenham acesso a cuidado à saúde de qualidade. Todos aqui querem também que mais jovens cheguem ao ensino superior e realizem os seus projetos de vida. Portanto, seria natural concordar com a expansão de cursos superiores no Brasil.

Após anos de estudo, leitura de centenas de páginas nos processos de acreditação do Saeme, eu pondero, sim, o fracasso que seria abrir escolas médicas de forma não responsável, respondendo a interesses econômicos, sem compromisso com o Sistema Único de Saúde, em locais com rede de serviços não completamente estabelecida, aplicando-se um projeto pedagógico padrão que não foi feito com a participação dos seus efetores, sustentando a aposta que infraestrutura, tecnologia e simulação sanarão a insuficiência de professores e cenários de prática.

Dessa forma, nós não teremos bons médicos. As populações vulneráveis continuarão desassistidas e haverá jovens frustrados pela péssima formação que receberam e com dívidas de financiamento estudantil que contraíram.

Anterior à discussão de quantidade, coloco, aqui, aos senhores e senhoras, a discussão da qualidade da formação, porque afirmação "médico ruim é melhor que nenhum" não é verdadeira, nem ética. Um médico malformado onera o sistema, atrapalha a equipe de saúde, coloca em risco os seus pacientes, causando e apressando sua morte ou deixando sequelas. E sobre isso, há extensos registros no Conselho Federal de Medicina e vocês sabem, também, na mídia.

A partir desse olhar da qualidade em prol da expansão responsável do ensino superior do Brasil, que ofereço aos senhores uma síntese sobre o que faz uma escolha médica ser boa o suficiente e merecer existir.

Uma escola médica boa o suficiente cumpre seu propósito de formar profissionais éticos e responsáveis, com competência técnica, emocional e moral, comprometidos com a transformação da realidade em que estão inseridos. Portanto, o desenvolvimento regional e da rede de saúde local representa um impacto da escola médica, não o seu principal propósito e objetivo.

Uma escola médica boa o suficiente tem infraestrutura, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas em boas condições de manutenção e acessibilidade,

além de áreas de convivência, que demonstram ao aluno que a escola está preparada e, mais que isso, quer recebê-lo.

A esse lugar que convida e motiva a permanência e convivência, tecnicamente, dá-se o nome de ambiência, termo frequentemente confundido com luxo e ostentação, tidos, pontualmente, como critérios de qualidade, quando, de fato, não são sinônimos de ensino eficaz.

Uma escola médica boa o suficiente que cumpre o seu propósito não se faz sem infraestrutura, mas seguramente só com ela também não se faz. O ensino médico, no século XXI, ocupa espaços extramuros da faculdade, integrando-se ao sistema de saúde e às comunidades, demonstrando a sua responsabilidade social, seu envolvimento com fortalecimento do Sistema Único de Saúde e as necessidades de saúde locais.

Essa é uma questão muito sensível, porque a maioria das novas escolas depende e paga por cenários de prática privados conveniados, e todas elas compartilham a rede pública, com contrapartidas nem sempre equivalentes entre esses dois tipos de contratualização.

A abertura de uma escola médica pede um prévio estudo de viabilidade da rede de serviço e a disponibilidade de profissionais que atuarão como preceptores, isso para além da carta de anuência normalmente solicitada às autoridades locais, pois a rede de serviço pode estar preparada para receber alunos

de uma escola, mas não de duas ou três mais que iniciem as suas atividades na mesma região.

Por outro lado, há locais onde a rede de saúde não está completamente estabelecida e se abre uma escola médica ali apostando que assim ela será desenvolvida, o que obriga professores e estudantes a cumprirem distâncias superiores a 250 km para os seus estudos, gerando desgaste físico, mental e dificultando a sua permanência e engajamento no curso.

Uma boa escola médica expressa a sua intencionalidade num projeto pedagógico coerente, que deve declarar o porquê dessa escola existir, para quem ela foi criada, a favor ou contra quais ideias.

Para além de um texto bem escrito, o projeto pedagógico descreve o programa educacional e como essa escola pretende fazer a coisa certa, do jeito certo, como ela considera o contexto regional, as evidências, as melhores práticas, integra conhecimentos, promove a educação interprofissional e se preocupa com os seus alunos.

Uma escola médica boa o suficiente inclui tecnologia ao processo educacional, possibilita a vivência do ensino híbrido e da comunicação digital, também utiliza estratégias e simulação, garantindo oportunidade para o desenvolvimento das mais diversas competências, e, mais que isso, promovendo, assim, a segurança do paciente.

No entanto, senhoras e senhores, é importante afirmar, com clareza: a simulação não substitui a prática junta ao paciente, mas a antecede, complementa. Outro dia ouvi de um aluno: "Professora, eu sinto falta de tocar em tecido humano, toco muito em plástico".

A falta de cenários de prática e os custos de se colocar estudantes em espaços sob supervisão fazem com que muitas escolas privilegiem estratégias de simulação na tentativa de suprir a pouca vivência e o cuidado real dos seus alunos.

Uma boa escola médica, ou uma escola médica boa o suficiente, acolhe os seus estudantes, aceita e respeita a sua diversidade, considera a sua cultura e características geracionais. Ela é socialmente responsável, tem políticas inclusivas de seleção de ingressantes, garantindo acesso a estudantes locais com bom desempenho e em desvantagem social.

Uma boa escola médica oferece espaço e possibilidade de os alunos terem vida para além do curso. É fácil e, com muita precisão, posso falar para os senhores que há índices alarmantes sobre ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e mesmo morte entre alunos de Medicina; e isso, principalmente, em grupos vulneráveis.

Uma escola médica boa o suficiente tem ambiência, integra-se de forma responsável ao sistema de saúde local, tem um projeto pedagógico

coerente, assimila tecnologia, acolhe e cuida dos seus alunos, mas não se constitui sem bons professores e preceptores. Um bom professor dribla a falta de recursos e estrutura e faz ainda com que o mau projeto pedagógico se torne bom. O mau professor e despreparado é um mau exemplo. Ele, inclusive, com toda a infraestrutura, não consegue levar a cabo um bom projeto pedagógico. Não estou falando, aqui, de excelência ou de critérios exigidos em processos de acreditação de escolas médicas no Brasil e no mundo, estou falando de escolas boas o suficiente.

Quem sabe, ao propor, aprovar ou negar abertura de novos cursos, pudéssemos perguntar, como Paulo Freire nos ensina: por quê, para quê, a favor de quem e contra quem. Porque essa é a narrativa em disputa aqui.

Concluo afirmando, independentemente de número de médicos, vagas ofertadas ou necessidade de médicos, que, no Brasil, para que tenhamos boa qualidade da saúde, só devem existir escolas médicas boas o suficiente.

Muito obrigada pela atenção de vocês.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado, Doutora Patrícia.

Agora, teremos a intervenção do Doutor Ingo Wolfgan Sarlet, representando o Conselho de Reitores das Universidades brasileiras.

O SENHOR INGO WOLFGANG SARLET (CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS) - Cumprimento e saúdo inicialmente o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator de ambas as ações, em nome das quais ora se realiza a presente audiência pública. Saúdo igualmente o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Luiz Augusto Santos e o Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União, Bruno Bianco, assim como os demais eminentes integrantes desta Corte, expositores, autoridades, advogados, servidores da justiça e público em geral.

A destacada controvérsia submetida a esta Corte compreende a definição da compatibilidade do art. 3º da Lei do Mais Médicos, que instituiu a política designada ao Programa Mais Médicos, com a nossa Constituição Federal.

Sobre a questão do nosso entendimento, na qualidade de representante do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, autor da ADI 7.187, a norma contida no art. 3º da referida Lei nº 12.871/2013, do Mais Médicos, representa uma afronta à Constituição Federal. Sendo inviável apresentar e discutir todas as teses que sustentam a referida inconstitucionalidade, selecionamos três.

A primeira e flagrante violação da Constituição Federal existe no fato de que a interpretação conforme a qual o art. 3º da Lei dos Mais Médicos estabelece procedimento exclusivo de chamamento público para a obtenção da autorização estatal para a abertura de novos cursos de Medicina resulta em

restrição manifestamente inconstitucional da liberdade econômica, ao desatender por completo o correspondente princípio e dever de proporcionalidade.

Relembramos que entre os fins da lei está o de reduzir a desigualdade de oferta de serviços médicos nas regiões do país. Para tal efeito, o meio eleito pelo legislador foi a instituição de chamamento público e correspondente pré-seleção de municípios e instituições de ensino superior tendo em conta a necessidade social da oferta, o que diz com a primeira etapa do teste de proporcionalidade. A aptidão, mesmo em tese de chamamento público como sendo o meio adequado a fomentar os fins da legislação, merece série críticas, dada a inexistência de qualquer garantia de que os profissionais formados em localidades beneficiadas pelo chamamento ali exercerão sua profissão.

A permanência do graduado na localidade em muito dependerá de variáveis que escapam ao domínio do Programa Mais Médicos, como, dentre outros, a extensão da rede hospitalar e ambulatorial, os postos de trabalho disponíveis, a infraestrutura dos complexos hospitalares e ambulatoriais e a própria contrapartida remuneratória pelo exercício da profissão, que, aliás, foi frisada em exposição anterior.

Além disso, acerca do critério para diagnosticar a necessidade de profissionais médicos em uma localidade, a própria Organização Mundial da Saúde desaconselha que as conclusões sejam retiradas exclusivamente da análise

da proporção médicos por habitantes. Contudo, é esse o único elemento adotado pela Lei do Mais Médicos para filtragem de municípios e instituições aptos a abrir novos cursos de Medicina, desconsiderando-se por completo outros fatores relevantes, como a extensão do território, sistema de saúde, nível socioeconômico, perfil demográfico e epidemiológico da população, bem como maior ou menor carência de médicos especializados em determinadas áreas.

Adentrando a segunda fase do teste de proporcionalidade, verificamos que a obrigatoriedade da submissão ao chamamento público é manifestamente desnecessária dada a existência de meio tanto ou até mais eficaz para alcançar os fins da lei, mas, ao mesmo tempo, menos restritivo da liberdade econômica e de outros direitos fundamentais.

Acrescentamos, na esteira do que fez o TCU, no Acórdão 1.869/2016, que, além de uma intensa interferência no âmbito da proteção da liberdade econômica, a exclusividade do procedimento chamamento público resulta também em intensa interferência na livre concorrência, favorecendo inclusive a produção de efeitos colaterais indesejáveis, como aumento dos preços das mensalidades e o próprio comprometimento da qualidade de serviços ofertados, dada a escassez de oferta e concorrência.

Finalmente, também no âmbito da proporcionalidade em sentido estrito, a conclusão é que a intensidade da retração da liberdade econômica

é elevadíssima. Isso porque não se trata da submissão de uma atividade econômica já exercida a determinados condicionamentos estabelecidos em lei, mas sim de um impedimento integral de que a atividade econômica seja desenvolvida caso municípios e instituições não sejam contemplados pelo chamamento público. De acordo com o art. 3º da Lei do Mais Médicos, uma instituição sequer pode submeter sua proposta para tê-la avaliada quanto ao seu mérito, tratando-se, portanto, de uma das intervenções mais gravosas no âmbito da proteção da liberdade econômica.

Se não bastasse este argumento, a adoção do procedimento de chamamento público como via exclusiva esvazia núcleo essencial do direito à liberdade econômica. Reportando-se ao núcleo essencial da livre iniciativa e da liberdade econômica, esta Corte já entendeu, na ADPF 449, que a regulação estatal não pode privar os agentes econômicos de empreender.

No entanto, a declaração incondicional da constitucionalidade do art. 3º da lei impedirá que agentes econômicos iniciem a prestação de serviços educacionais e, com isso, ingressem no segmento de mercado a fim de explorá-lo, violando a essência da livre iniciativa, em particular da liberdade econômica, sequer sendo permitido que esses, com largo prestígio, tradição e recursos humanos, além de infraestrutura suficiente e qualificada, possam submeter proposta de criação de novos cursos de Medicina.

Como terceiro argumento a ser invocado, entendemos que a imposição do rito exclusivo resulta em violação do princípio da proibição de retrocesso. Destacamos que a oferta de vagas no ensino superior de Medicina no Brasil encontra-se aquém dos níveis suficientes, o que justifica a ampliação e não redução, pelo menos, da possibilidade de abertura de novos cursos. A manifesta insuficiência da aplicação do procedimento exclusivo do chamamento público de modo a alcançar os objetivos do Programa Mais Médicos fica claramente demonstrada quando se relembra que a meta a ser alcançada em 2013 era de 2,7 médicos por mil habitantes em 2016, utilizando, para tanto, os parâmetros da OCDE de 2012.

Em virtude da aplicação do procedimento ora questionado, transcorridos seis anos do prazo, a proporção de médicos no Brasil é ainda bem inferior em 2022, tomando por referência os critérios da própria OCDE de 2012. Dados que se revelam ainda mais escandalosos, considerando que, pelos atuais parâmetros da OCDE de 2022, o número de médicos para mil habitantes deveria ser de 3,5.

Some-se a isso que, de acordo com dados oficiais do governo brasileiro de agosto do presente ano, a distribuição desproporcional do número de médicos em termos regionais, como também já frisado, é manifesta. Quarenta e um por cento dos médicos atuam nas 27 capitais, onde reside cerca de 24% da

população, restando para os demais municípios, em que residem 76%, o percentual de 59% dos demais médicos em atuação no serviço de saúde.

Destacamos, ainda mais, tendo em conta os dados citados, que a violação da proibição de retrocesso nas áreas de educação e saúde foi ainda mais agravada com a publicação, pelo MEC, da Portaria nº 208/2020, que suspendeu as autorizações para abertura de novos cursos de Medicina até 2023, ademais das Portarias nº 523/2018 e nº 371/2022, que limitaram o requerimento do aumento de vagas para os cursos a uma única solicitação, até o limite de 100 vagas.

Tudo isso, ademais de configurar-se um flagrante retrocesso no que diz respeito à efetividade do direito à proteção e promoção da saúde, apenas reforça ainda mais a tese da desproporcionalidade da aplicação do rito exclusivo de chamamento público.

Indo ao final, à vista das razões acima esgrimidas, o disposto na norma contida no art. 3º da Lei do Mais Médicos é incompatível com o sistema constitucional brasileiro.

Alternativamente, caso não declarada a inconstitucionalidade, é de ser atribuída à norma legal referida interpretação conforme a Constituição para que seja permitida a submissão de propostas e a obtenção de autorização para a abertura de novos cursos de Medicina, sem a realização de chamamento público. Subsidiariamente, não sendo também esse o entendimento a ser adotado por esta

Corte, que seja declarada inconstitucional, sem redução de texto do referido preceito legal, de modo a afastar sua aplicação nas hipóteses em que a abertura de novos cursos se der por razões diversas daquela almejada pelo Programa Mais Médicos, consistentes na redução da vulnerabilidade social de determinadas regiões brasileiras.

Com isso, agradeço pela atenção e pela honra que me foi concedida. Desejo a todos um excelente e produtivo seguimento desta audiência pública.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agradeço ao Professor Ingo Wolfgang Sarlet por sua intervenção e passo, em seguida, a palavra ao Deputado Federal Ricardo Barros, ex-Ministro de Estado da Saúde.

Estamos sendo informados de que o Deputado Ricardo Barros está com problemas de conexão, então passo a palavra agora ao Ministro de Estado da Educação, Victor Godoy Veiga.

O SENHOR VICTOR GODOY VEIGA (MINISTRO DA EDUCAÇÃO) - Bom dia a todos! Quero cumprimentar inicialmente o Ministro Gilmar Mendes e o parabenizar por essa iniciativa. Cumprimento também o Ministro Bruno Bianco, o Ministro Queiroga e cumprimentando a eles cumprimento também todos os demais presentes na audiência e que nos escutam.

O Ministério da Educação quer contribuir inicialmente para o debate com foco em três questões que consideramos relevantíssimas para compreensão do tema em torno da ampliação de vagas e abertura de novos cursos de Medicina no país.

O primeiro ponto se refere à importância da política de chamamento público para oferta dos cursos de graduação em Medicina. O número de médicos no país tem crescido significativamente ao longo dos anos e muito especialmente após o ano de 2010. Neste ano, havia cerca de 320 mil médicos no Brasil e, hoje, esse número é de 546 mil, segundo dados do Conselho Federal de Medicina. Isso equivale a 2,53 médico por mil habitantes, considerando nossa população atual de 215 milhões de brasileiros, conforme dados do IBGE.

Com base nesse estudo da demografia médica brasileira, feito em 2020 pela FMUSP, podemos dizer que a relação de médicos por mil habitantes no Brasil é próxima a de outros países bem relevantes no contexto global, como Estados Unidos, que tem relação de 2,6; Reino Unido, que tem relação de 2,8; e Canadá, que tem relação de 2,7. E é superior a de países como o Japão - 2,4 -, Coreia do Sul - 2,3 - e China - 2. Contudo, a distribuição dos médicos pelo território nacional é muito desigual. Conforme o referido estudo, enquanto no Sudeste a relação era de 3,15 por mil habitantes, no Nordeste era de 1,69, e, no norte, de 1,3.

Se observássemos naquele estudo a relação de médicos por mil habitantes nas capitais e no interior, a discrepância era ainda maior. Nas capitais a relação médica por mil habitantes era de 5,65, já no interior era de 1,49, correspondente a três vezes e meio a menos.

Considerando esse cenário, entendemos fundamental a manutenção da política de chamamento público, cominada com o estabelecimento de políticas públicas efetivas, voltadas à distribuição de médicos, pelas quais o poder público induza a ampliação de vagas de Medicina para localidades com maior carência desses profissionais e maior vulnerabilidade social.

De fato, o papel do Estado é imprescindível na busca da harmonização dos interesses e necessidades dos brasileiros em todo o território nacional na oferta desses serviços de saúde. Nesse sentido, a participação do MEC se insere em um contexto de direcionar os esforços dos sistemas educacionais para distribuir os cursos de Medicina de forma a abranger, de maneira mais equânime, não só as capitais do país, mas também o seu interior.

Em um segundo ponto, queremos enfatizar que o MEC, sensível à complexidade do tema, tem atuado no sentido de aprimorar a política de ofertas para o curso de Medicina. Após a edição da Lei do Mais Médicos, em 2013, o Brasil superou as metas de ampliação dos cursos de Medicina estabelecidas em conjunto com o Ministério da Saúde. O MEC já autorizou, desde então, mais de 16.500 vagas

e, atualmente, o Brasil conta com mais de 41.600 vagas de Medicina já autorizadas, distribuídas em mais de 380 cursos.

Os editais de chamamento foram suspensos por cinco anos, em 2018, para avaliar o acerto da política pública, contendo o avanço significativo da oferta de vagas em Medicina. O prazo de suspensão se encerra no próximo ano, em abril de 2023, e o MEC está atento a esse fato.

Nesse sentido, em abril deste ano, determinei a retomada do grupo de trabalho instituído para coletar subsídios e ouvir os diversos interlocutores da sociedade interessados no aperfeiçoamento da política de formação e regulação dos cursos de Medicina. Além dos órgãos e entidades ligadas ao MEC, participam do grupo de trabalho o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Associação Brasileira de Educação Médica.

Desse modo, é de todo o interesse do MEC o aperfeiçoamento da política pública, com amplo debate e pluralidade de opiniões, para que se caminhe no sentido de se adotar o melhor modelo de regulação, que atenda à necessidade de serviços médicos para a população, de forma sustentável e justa também para as diversas entidades que ofertam os cursos. Sabemos das necessidades e interesses de diversos atores públicos e privados na oferta de cursos de Medicina. É por isso que o tema requer debates amplos e fóruns adequados de

reflexão, o que vem sendo proporcionado hoje pelo Ministério da Educação. Como estabelecido na nossa Constituição, a educação é dever do Estado e sua promoção é feita em colaboração com a sociedade. Nesses princípios, fundamenta-se a atuação do MEC.

Por fim e em terceiro lugar, é muito importante pontuar a questão do aumento exponencial de medidas liminares que autorizam a ampliação de vagas e a abertura de novos cursos de Medicina. Só nos últimos seis meses, o MEC já respondeu a 145 ações judiciais, com 65 decisões para cumprimento, o que pode implicar a criação de cerca de 14.500 novas vagas nos próximos seis anos.

O MEC vê com muita preocupação a abertura de vagas e cursos por tutelas provisórias e, portanto, em caráter precário. A maior preocupação do MEC é com os estudantes que, fiados nas decisões judiciais, apostam seus sonhos e assumem gastos financeiros em um projeto estudantil que, ao final, pode não ser concretizado, pelo menos não no curso que obteve autorização provisória. Isso já tem gerado dificuldades ou até mesmo impossibilidade de recolocação desses estudantes em outros cursos autorizados, ocasionando problemas de ordem social.

Também nos preocupam as autorizações provisórias de cursos sem que se determine, supletivamente, a aplicação das normas administrativas que buscam assegurar a qualidade dos cursos oferecidos. Uma vez afastada, por liminar, a incidência dos critérios do chamamento público, quebra-se uma lógica

de regulação, prejudicando a aferição da conformidade do curso autorizado. A preocupação nesse ponto é ainda maior, por se tratar da formação de profissionais que cuidarão da saúde da população - as consequências de um mau atendimento médico podem ser gravíssimas.

Ressalta-se, ademais, que as escolas médicas contempladas com a abertura de vagas por decisão judicial não estão sendo compelidas a oferecer programas de residência médica, o que é obrigatório para as entidades que passam pelo procedimento regular.

Os dados atuais de regulação do MEC evidenciam ainda que, de modo geral, os novos cursos, autorizados unicamente por determinação judicial, possuem qualidade inferior aos aprovados no processo regulatório ordinário.

O MEC está empenhado para, ainda no primeiro trimestre de 2023, entregar a política de oferta de vagas devidamente aprimorada, com as contribuições de diversos atores da sociedade impactados por essa regulação, contemplados no grupo de trabalho referido anteriormente.

Desse modo, é muito importante que as decisões judiciais levem em conta a proximidade da definição dessas novas balizas regulatórias, a fim de que o estudante que ingressar na tão sonhada vaga do curso de Medicina tenha a segurança de que adquirirá habilidades e atitudes necessárias às competências profissionais para o exercício da Medicina.

Assim, faço um apelo ao Poder Judiciário para que se sensibilize diante da situação colocada, reconhecendo os esforços e o papel do Ministério da Educação na condução de uma política regulatória efetiva que atenda de forma satisfatória toda a população brasileira.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado, Ministro Victor Godoy!

Agora passaremos a palavra ao Deputado Federal Ricardo Barros, ex-Ministro da Saúde.

O SENHOR RICARDO BARROS (DEPUTADO FEDERAL - EX-MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE - CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS) - Ministro Gilmar Mendes, nobres participantes desta audiência pública, nós estamos diante de uma decisão importante. Eu, como Ministro da Saúde, aprendi que, em cursos de Medicina, devem ter hospitais próprios, isso seria muito útil para que nós pudéssemos avançar na qualidade do ensino, na interiorização da formação dos profissionais e da disponibilidade de oferta de serviços médicos. É muito importante que haja esse equilíbrio, porque o curso de Medicina é altamente rentável e a manutenção do hospital é deficitária, então nós somaríamos os esforços do curso de Medicina e da manutenção do hospital, equilibrando assim o patrocínio da oferta de serviços de saúde à

população e colocando, Ministro Gilmar Mendes, as pessoas mais próximas deste acesso à medicina.

O que acontece é que os profissionais de Medicina se formam numa idade em que estão também mais suscetíveis ao momento do casamento, então esses profissionais saem das suas regiões, vão fazer o curso de Medicina, acabam se deslocando para grandes centros, para fazer a residência médica, e depois não retornam mais, porque criam laços afetivos e acabam não voltando para as suas origens. Por isso, o Ministro da Educação deixou claro que há uma má distribuição dos profissionais no território nacional, embora tenhamos quantidade razoável de profissionais médicos, mas eles não vão para os rincões, eles não vão para os locais de difícil acesso.

Aí, nesse sentido, criou-se uma opção agora de uma carreira médica onde os profissionais podem se deslocar pelo país recebendo recursos pelo Ministério da Saúde, dentro de um objetivo muito antigo da Associação dos Médicos, do Conselho Federal de Medicina, de criar uma carreira médica e essa carreira permitir que profissionais construam uma ascensão profissional, estando inicialmente em locais mais distantes, e migrando, ao longo da sua carreira, para os centros maiores.

Mas isso não tem se verificado. No caso dos profissionais médicos cubanos do Mais Médicos, desses postos que antes eram ocupados por

cubanos, hoje, aproximadamente 2500 a 3000 postos estão vazios. Houve uma alteração no programa e agora médicos brasileiros com CRM têm a preferência para a contratação, depois médicos brasileiros formados no exterior, que também é um assunto que precisa ser tratado pelo Legislativo e pelo Executivo de forma mais efetiva, para que nós possamos dar a esses profissionais a opção de trabalhar no mercado brasileiro no lugar dos cubanos nos postos de trabalho onde o médico com CRM não se apresenta nas chamadas públicas, e esses postos continuam desantendidos de formação de profissionais médicos.

Então, dentro desse contexto, a questão que se coloca aqui, em especial a da chamada pública para a formação e a definição dos cursos, ela deve ser considerada, mas olhando do ponto de vista de que, se estabelecêssemos a exigência de que hospitais tivessem de ser mantidos pelos cursos de Medicina, ou seja, cada curso de Medicina, dentro daquele currículo que se propõe a estabelecer e formar profissionais tenha de ter o campo de trabalho específico o profissional médico, isso ajudaria muito.

Então, nem precisamos interiorizar os cursos de residência médica para que essa migração do profissional, às vezes formado numa faculdade no interior, em cidades mais interioranas do Brasil que têm faculdade de Medicina, mas, na hora da residência, ele se desloca para um grande centro e acaba não retornando mais para suas origens.

Então, o grande desafio sempre foi colocar o médico à disposição da população, conseguir localizar o médico onde a população precisa dos seus serviços. Esse é o grande desafio que encontramos no Ministério da Saúde. Eu estou aqui falando como ex-Ministro da Saúde, não como líder do Governo, estou falando das dificuldades práticas que nós tivemos ao tentar, ao fazer esse amplo atendimento da população, fazer com que os postos de saúde, as unidades básicas de saúde tenham um profissional lá.

O concurso público, Ministro Gilmar Mendes, que o profissional médico faz é para 40 horas de trabalho. Aí, a Organização Mundial da Saúde determina que cada consulta deve ser de 15 minutos, para ser uma boa consulta. Então, lá no posto de saúde, na unidade básica de saúde, marcam-se 16 consultas para o médico que tenha o concurso de 4 horas por dia, 16 consultas de 15 minutos. O médico cumpre essas consultas rapidamente e se desloca do posto de saúde ou da unidade básica de saúde. Então, ele não cumpre o seu concurso público que é de 40 horas, mas cria-se todo esse mecanismo confuso e que acaba tirando o profissional lá da unidade básica onde a população espera encontrá-lo. Aí, a pessoa que mora no bairro que tem uma unidade básica de saúde acaba se deslocando direto para a UPA ou direto para o hospital, porque ela sabe que ali do lado da sua casa tem unidade básica de saúde, mas que o médico não está lá cumprindo o horário, porque já fez o cumprimento das 16 consultas e não estará lá

disponível para atendê-lo. Aí, toda a estrutura que foi formada, todo o desenho do SUS, que é muito bem estruturado, acaba não sendo efetivo, porque não há, na prática, a disposição dos profissionais como está desenhado dentro do programa.

Então, fica aqui a minha contribuição no sentido de que haja, do ponto de vista do nosso Congresso Nacional, nós já legislamos sobre isso, está estabelecida a regra e há dúvida sobre a regra, liminares, muita judicialização na saúde, e agora na formação de médicos também. Então, que nós possamos refletir bem e tomar a melhor decisão sobre essa questão.

Mas qual é o objetivo? O objetivo é que os cursos de Medicina tenham os seus próprios hospitais. Isso só já limitaria os pedidos de cursos de Medicina, porque o estabelecimento do hospital tem de ter um mercado, tem de ter uma localização onde haja a necessidade dos seus serviços para que ele possa fazer parte do conjunto da estrutura da universidade que oferece o curso de Medicina.

É esse ponto que eu gostaria de destacar para que nós pudéssemos, então, contribuir para que mais brasileiros tenham acesso à medicina e mais profissionais médicos se localizem nas regiões interioranas do país onde nós precisamos desse profissional.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado ao Deputado Federal Ricardo Barros, que, como também destacou, falou na condição de ex-Ministro da Saúde.

E agora eu passo a palavra ao Ministro de Estado da Saúde, Doutor Professor Marcelo Queiroga.

O SENHOR MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES (MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE) - Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União, Bruno Bianco, excelentíssimo Senhor Procurador da República, excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, Victor Godoy, minhas senhoras e meus senhores.

Este é um tema de extrema importância. Nós estamos saindo da maior emergência de saúde pública que o mundo já viu: a pandemia da covid-19. E foi justamente com o nosso Sistema Único de Saúde que nós conseguimos vencer essa difícil situação sanitária.

A Constituição Federal de 1988 consagra a saúde como um direito fundamental. E não há saúde sem médicos qualificados.

A nossa Carta Magna, em seu art. 196, consagra que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas. Entre essas políticas se inclui, necessariamente, a formação dos

recursos humanos para o sistema de saúde, que não se cinge à formação de médicos.

O país, Brasil, é um país que tem mais de 500 mil médicos. E boa parte desses 500 mil médicos, eles foram injetados dentro do sistema de saúde nos últimos 20 anos. Duzentos e sessenta mil médicos no sistema de saúde nos últimos 20 anos. E o nosso país tem 360 escolas médicas. O vice-campeão em escolas médicas do mundo.

Eu pergunto: e esse vice-campeonato está assegurando o provimento adequado de médicos para nossa população? Sim ou não? E será com a abertura indiscriminada de escolas médicas que nós vamos resolver o problema de médicos nas nossas 48 mil unidades básicas de saúde?

Se a resposta for sim, vamos liberar a abertura de escolas médicas, vamos considerar inconstitucional o dispositivo legal ora reclamado. Mas, se a resposta for ao contrário. Não! Devamos, sim, seguir o que nos falou, aqui, com muita propriedade, o Professor Milton Arruda e a Professora Patrícia Tempski, numa análise técnica de como nós devemos considerar a abertura de escolas médicas no Brasil.

O nosso país tem um dos maiores sistemas de saúde de acesso universal, integral, igualitário e gratuito do mundo. São 48 mil unidades básicas de saúde. Nós temos 7 mil hospitais, 500 mil leitos hospitalares.

E quais são os médicos que nós precisamos? Nós precisamos de médicos que cuidam da atenção básica, médicos da saúde comunitária. De outro lado, pela transição demográfica que vivemos, nós precisamos de geriatras, mas também precisamos de neonatologistas, porque as mulheres, hoje, optam por ter filhos mais tarde.

Então, essa discussão é uma discussão complexa e é uma discussão que não vai se resolver buscando vagas em escolas médicas, através de medidas judiciais. O Judiciário já tem muita tarefa a fazer, e não é abrindo vagas em escolas, em locais onde não há área de prática, que vamos resolver esse problema.

Nos últimos anos, houve determinadas normativas que frearam essa abertura indiscriminada de escolas médicas. Não obstante, as vagas, nas escolas existentes, elas cresceram. Elas cresceram, mas não descentralizaram os médicos.

Ministro Gilmar Mendes, eu sou de um estado pequeno, o Estado da Paraíba, que tem cerca de 3,8 milhões de habitantes. E no meu estado, Ministro, são nove escolas de medicina: uma na cidade de Patos, escola privada; duas na cidade de Cajazeiras. Isso não interiorizou trabalho médico. Continuamos com dificuldade de médicos na atenção básica. Ou seja, nós precisamos, sim, de

políticas públicas eficientes, que sejam construídas pelo Estado brasileiro, no caso, pelo Poder Executivo, que é a quem incumbe a efetivação da política pública.

No caso em particular, o Ministro Victor Godoy e eu temos uma interlocução permanente e queremos trazer a saída daquela portaria de 2018. Não só para permitir que novas escolas surjam dentro da perspectiva do chamamento, mas também para fechar escolas que não formam os médicos que a sociedade brasileira precisa. É fundamental que a Administração Pública tenha essa prerrogativa.

Cito, aqui, para os senhores, que assumi o comando do Ministério da Saúde no auge da pandemia, e, naquela época, a grande dificuldade era com médicos intensivistas. E, também, há corporativismo médico, há colegas que não querem, de jeito nenhum, que se abra a faculdade de medicina e não se abra vaga, até feche, não é o caso. Mas tínhamos carências, na medicina intensiva, era uma verdadeira corrida de 400 m com barreira para formar o intensivista.

Pois bem, eu e o Ministro da Educação trabalhamos para mudar a matriz de competência da formação do médico intensivista. Derrubamos um pré-requisito desarrazoado e essa especialidade passou a ser uma especialidade de acesso direto. Parte dos óbitos da covid-19, no Brasil, que foram mais de 680 mil, decorre da falta de qualificação desses profissionais. Médicos que, ao entubar a traqueia, entubavam o esôfago. E qual o resultado disso, meus senhores?

Resolveremos isso com abertura de escolas médicas? A resposta é não. Nós vamos resolver isso qualificando as escolas que nós temos, fazendo sistemas de acreditação dessas escolas médicas, discutindo o chamado exame de progresso, porque, se deixarmos essas faculdades abrirem aí, sem critério nenhum, vamos cair no mesmo contexto das faculdades de Direito. E aí, a OAB começou, através do exame de Ordem, a barrar esses bacharéis em Direito de exercerem a advocacia e até cargos na magistratura, no Ministério Público etc.

Então, por que não discutir o exame de progresso? Dois anos, quatro anos, seis anos, como estava na conformação inicial da lei em 2013?

Essa audiência pública é uma oportunidade extraordinária para que, sob o comando de Vossa Excelência - que também é um professor de elevada qualificação -, nós consigamos buscar novos rumos para formar os médicos que o nosso Brasil precisa.

Neste último minuto, Ministro Gilmar Mendes, sendo hoje o dia 17 de outubro, o Dia da Vacina, fazer uma homenagem ao nosso Oswaldo Cruz, o Pai da Vacinação no Brasil. Foi com elas que nós superamos a emergência de saúde pública da covid-19. E hoje, podemos estar aqui reunidos e com a perspectiva de uma nova esperança para o nosso Brasil.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agradeço ao Ministro Marcelo Queiroga por sua exposição.

Passo, em seguida, a palavra à Doutora Diana Guimarães Azin, Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação.

A SENHORA DIANA GUIMARAES AZIN (SECRETÁRIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO) - Bom dia, Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, demais autoridades representadas e presentes neste recinto, senhoras e senhores, os meus cumprimentos.

Como Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação importa registrar o posicionamento do Ministério da Educação quanto ao reconhecimento da compatibilidade constitucional do art. 3º da Lei nº 12.871/2013, assim como a necessidade de sua estrita observância pelos magistrados, sob pena de forte impacto no sistema regulatório da formação médica, o que já se tem observado, inclusive, nos últimos anos, diante da crescente judicialização para autorização dos cursos de Medicina, de modo a comprometer a qualidade do ensino médico no país e os objetivos indicados no Programa Mais Médicos, que importam, neste momento, serem rememorados, especialmente no que diz respeito à diminuição, diminuir a carência

dos médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área de saúde, fortalecer a prestação de serviço na atenção básica em saúde no país, aprimorar a formação médica no país e proporcionar maior experiência no campo médico da prática médica durante o processo de formação, além de ampliar a inserção do médico em formação nas unidades e atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira.

Neste momento, de forma preliminar, importa destacar a relevância da regulação da educação superior no Brasil.

Atualmente, segundo dados oficiais, o Brasil possui 8.603.824 (oito milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e vinte e quatro) alunos estudantes no ensino superior.

A partir desses dados, observa-se que a qualidade da formação superior desses mais de 8 milhões de estudantes perpassa pelo êxito do Estado brasileiro em regular e supervisionar a educação superior, árdua tarefa que compete ao Ministério da Educação e, em especial, à Seres.

Cumpre destacar, ainda, que o êxito que a regulação e supervisão da educação superior alcançar, nos dias de hoje, gerando um padrão satisfatório de qualidade na formação dos atuais estudantes vai repercutir diretamente no nível dos futuros profissionais, sejam médicos, educadores,

pesquisadores e gestores públicos e tantas outras profissões. Consequentemente, tendo um grande impacto na autonomia científica e tecnológica do país do futuro.

Percebe-se, então, que a atuação estatal direcionada à garantia do ensino superior de qualidade, nos dias de hoje, seja de instituições públicas ou privadas, depende, necessariamente, o potencial de geração de riqueza do país do futuro.

Diante desse cenário, importa registrar que, diante desse cenário, esse cenário não passou despercebido pelo atual Ministro da Educação, Ministro Victor Godoy. De modo que o MEC tem dispensado especial atenção à política regulatória da educação superior, tendo atuado inclusive em diversas frentes, incluindo a elaboração de um novo marco regulatório da educação superior, em substituição ao atual Decreto nº 9.235/2017, que se propõe a estabelecer fluxos regulatórios mais céleres e eficientes; instituição do Grupo de Trabalho de Medicina instituído pela Portaria nº 328/2018, cujos trabalhos já foram finalizados; criação de dois novos sistemas, um novo e-MEC e um novo e-Cebas, que trarão automação no impulsionamento dos processos, impondo maior celeridade, transparência e governança; criação de uma plataforma denominada plataforma Seres, que poderá monitorar e supervisionar as instituições de ensino superior em tempo real. Há a instituição, ainda, de um grupo de trabalho de caráter técnico, no âmbito do Ministério da Educação, para apresentar subsídios, com

vistas à regulamentação da oferta dos cursos de graduação em Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem na modalidade a distância, e dispõe sobre o sobrestamento dos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de graduação na modalidade a distância, por meio da Portaria nº 668, de 14 de setembro de 2022.

Faço essas observações para demonstrar que o MEC, sob a diretiva do Ministro Victor Godoy, tem desempenhado, com efetividade, o seu papel de elaborar e executar políticas públicas educacionais, papel esse inerente ao Poder Executivo.

Acerca do tema objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade 81, dados extraídos do Censo da Educação Superior, realizado pelo Inep, no período de 2010 a 2018, demonstram que a nova política da formação médica implementada pela Lei do Mais Médicos alcançou o objetivo esperado. Tais informações evidenciam a importância da intervenção do Estado na educação superior, sendo indissociável a garantia constitucional de liberdade de criação de instituições de ensino e a exploração da educação superior, como fundamento da República Federativa do Brasil, de responsabilidade do Estado em regular e fiscalizar os serviços públicos educacionais prestados por elas.

Nesse aspecto, a incumbência do Estado de regular tal serviço pressupões a fixação de critérios normativos a serem previamente observados, de

modo que a harmonização prática entre o princípio da liberdade econômica e as incumbências colocadas ao Estado em matéria de educação superior determinam e justificam a atuação do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - Seres, visando assegurar que as instituições de educação superior, públicas e privadas, pertencentes ao Sistema Federal de Educação Superior, alcancem padrões de qualidade indispensáveis para a sociedade brasileira, sendo, portanto, suporte da sua autonomia e de sua liberdade.

No que diz respeito à política regulatória para autorização de curso medicina, desde a aprovação de Lei nº 12.871/2013, a abertura de cursos de medicina por instituições particulares é regulada de forma rígida pelo MEC, de modo que se exige que as propostas de abertura de novos cursos têm que obedecer aos critérios técnicos, os quais devem ser apresentados em locais considerados com maior demanda. Dentre requisitos, tem-se o cenário de prática como eixo relevante na formação médica.

Tendo-se como pressuposto para a qualidade da formação médica a garantia do cenário de práticas para os alunos, verificou-se que o crescimento acelerado das escolas médicas nos últimos anos, o crescente registro de erros médicos e também em função das distorções existentes em relação ao dimensionamento e distribuição de médicos em face de novos modelos de ensino

existentes, principalmente no contexto de práticas médicas, comprometia seriamente a formação médica, tornando-se necessária, mais uma vez, a intervenção do Estado para garantir a excelência do serviço educacional. De modo que, em 2018, o Ministério da Educação publicou a Portaria MEC nº 328, conhecida como Portaria da Moratória, que suspendeu o protocolo de pedidos de aumento de vagas e de novos editais ao chamamento público. Importa inferir que a suspensão do protocolo de pedidos de aumento de vagas não se aplica aos cursos de medicina autorizados no âmbito dos editais de chamamento público em tramitação ou concluídos, segundo o rito estabelecido no art. 3º da Lei nº 12.871/2013, e aos cursos de medicina pactuados no âmbito da política de expansão das universidades federais.

Desse modo, com o objetivo de atender a determinação normativa, o excelentíssimo Ministro Victor Godoy reconduziu o grupo de trabalho, por meio da Portaria nº 377/2022, e, nesse pórtico, visando trazer robustez, legitimidade à nova política regulatória a ser elaborada a partir dos trabalhos do GT, a Seres realizou tomada de subsídios aberta ao público com o objetivo de obter contribuições que fomentassem as atividades do grupo, por meio de edital Seres 52, de maio de 22, utilizando-se, para tanto, da plataforma da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Por fim, seria importante frisar a participação ativa e a ampla discussão dos médicos integrantes dos principais órgãos de representatividade profissional e docente no âmbito da medicina, dos representantes de órgãos públicos que atuam diretamente na regulação do ensino da medicina no país, bem como dos representantes das principais associações de instituições de ensino superior que ofertam o curso de medicina.

Essas são as questões que a Secretaria de Regulação e Educação Superior queria trazer.

Eu agradeço.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Obrigado, Doutora Diana.

Agora, vamos ouvir o Doutor Rafael Câmara, Secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde

O SENHOR RAPHAEL CÂMARA MEDEIROS PARENTE (SECRETÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) - Bom dia a todos! Cumprimento o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, nosso Ministro Queiroga, Ministro Victor, Ministro Bruno Bianco e todas as autoridades presentes.

Represento aqui a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que cuida da alocação de médicos para a atenção primária, e também sou conselheiro

federal e regional de Medicina, portanto, esse tema de alocação médica é bastante importante em minha vida profissional.

Nós somos a favor do chamamento público e aqui estamos para defendê-lo. A Demografia Médica 2022, de acordo com dados do CFM, mostra que, hoje, temos quase 550 mil médicos - na verdade, já passamos disso -, ou seja, a razão de 2,4 médicos para cada mil habitantes. Em 2010, era 1,9. A tendência é que aumente cada vez mais, chegando ao número de 28 mil médicos formados em 2024.

Em cem anos, aumentamos, proporcionalmente, em mais de cinco vezes, o número de médicos relacionado ao número de habitantes. Desde 2001, vamos vendo também esse aumento na formação de novos médicos. Até o ano de 2024, a gente passa de 8 mil para quase 32 mil, então a gente quase quadruplica. De forma alguma, a população brasileira chega sequer perto desse aumento.

De 2011 a 2020, foram mais de 20 mil novas vagas de graduação em Medicina, sendo 84% delas ofertadas por escolas médicas privadas, e 71% fora das capitais.

Também há cursos de Medicina instalados em locais sem infraestrutura para a prática do estudante. Como o Ministro falou, essa formação realmente é um problema sério. Isso se traduz em diversos erros médicos que a gente consegue ver no CRM e no CFM. Desde que entrei no cargo, já rodei o Brasil

todo, Ministro, duas vezes - as 27 unidades da federação -, pelo menos, duas vezes em cada unidade da federação. Sempre vou nas UBSs e a gente nota que, realmente, haver a faculdade de Medicina, de forma nenhuma garante a presença do médico ali. Para isso estamos trabalhando forte nos programas que vou mostrar a seguir.

Esse eslaide mostra, estado por estado, a abertura de vagas de Medicina. Vocês podem ver, por exemplo, em estados como Acre e Rondônia, que a maioria dos médicos que lá se formam saem. É muito comum. Gosto de ir às faculdades de Medicina nos estados para onde vou. Muitas vezes, praticamente ninguém é do local onde está. Eles vão lá para fazer o seu curso de Medicina e, tão logo acabem, voltam para seus lugares. De forma alguma, ter faculdade de Medicina se traduz em alocação de médicos.

Como o Ministro falou, na Paraíba, recentemente, passei por Patos e Cajazeiras. Fui em diversas cidades ao redor desses municípios, dessas faculdades, em Ingá, Gurinhém e Santa Luzia, e lá eles têm dificuldade de contratação de médicos.

É importante aqui também mostrar, como já foi mostrado, a evolução do número de vagas de graduação de Medicina. São importantes esses números. A pergunta é: faltam médicos? Não. Falo isso com toda tranquilidade, porque sou responsável tanto pelo programa anterior, que ainda está vigente, o Mais Médicos, como implantei, depois da lei de 2019, com grande ajuda do nosso

Ministro Queiroga, o Programa Médico pelo Brasil. Com isso, a gente conseguiu aumentar o provimento de médicos, em 2013, de menos de 6 mil para mais de 16 mil, em 2021.

É uma falácia também dizer que, na época em que se colocavam pessoas sem CRM - que a gente não pode chamar de médico - e profissionais vindo de Cuba, que o número era maior. Nunca foi. O recorde foi batido. Desde que entrei no Ministério da Saúde, não fiz nenhum edital para pessoas sem CRM - é discricionário do gestor. Tentaram inclusive entrar na Justiça para impedir isso e, mesmo assim, a gente bate recorde atrás de recorde na alocação de médicos. E a gente prova com esses números que a gente colocou aqui.

Quantos médicos já passaram pelo Programa Médicos pelo Brasil? Já passam de 55 mil médicos. Sempre que começa a ter falta de médico - vou mostrar depois -, o que tem grande diferença realmente é que os médicos acabam não se fixando. Para nunca deixar a população sofrer - porque onde vou sempre o pedido do gestor é médico -, a gente faz ciclo atrás de ciclo para não deixar a população desassistida.

Aqui temos um eslaide que mostra a comparação entre o número de médicos do Médicos pelo Brasil e o Programa Mais Médicos. Podem reparar, ano a ano, a alocação de médicos feita pelo Ministério da Saúde. Em 2013, menos de 4 mil médicos e, em 2022, mais ou menos 15.500 médicos. Essa é a média

que a gente mantém sem necessidade alguma de solicitar qualquer profissional sem CRM. Isso é o mais importante para a gente.

O número de consultas que esses médicos realizaram é fundamental para a população brasileira. É importante lembrar também que o Programa Médicos pelo Brasil é muito semelhante a uma carreira de Estado, dá dignidade na contratação - após 15 anos, o salário pode chegar a quase 38 mil reais. Com isso, a gente espera realmente conseguir resolver o problema de alocação de médicos no país.

A taxa de desistência de médicos é o grande problema hoje. A gente tem certeza de que com o Médicos pelo Brasil vai resolver essa questão. Naqueles locais muito complexos, como, por exemplo, nos distritos especiais indígenas - como nosso Ministro sempre fala -, a solução virá com a telemedicina. Esses são locais muito específicos, muitas vezes utilizados como argumento para o todo. E não é. São 37 distritos especiais indígenas no Brasil e, para esses locais, o Ministério da Saúde tem um olhar muito especial para resolver o problema deles.

Os profissionais formados no exterior, muitas vezes, são colocados como solução, e não são solução. O que importa é a segurança. Os próprios gestores solicitam isso. A gente precisa que quem se forme no exterior faça o Revalida. É importante dizer: a prova do Revalida é uma prova extremamente fácil. Quem não passa no Revalida é porque não tem condição alguma de atender

com dignidade a população brasileira. Em 2021, mais de três mil médicos se inscreveram e quase quatro mil passaram.

Tenho tempo, queria contar uma historinha. Eu estou cedido ao Ministério da Saúde. Sou da UFRJ. A UFRJ, em 2009/2010, mais ou menos, abriu um *campus* de Medicina em Macaé. Por conta do petróleo, Macaé é a cidade mais rica do Brasil. Macaé fica a duas horas do Rio de Janeiro e a UFRJ não conseguia colocar médicos em Macaé - estou falando isso porque sou concursado da UFRJ e, na época, também era de Macaé. Tinha que colocar cartaz no hospital e não conseguia alocar médicos.

O que aconteceu naquela situação? A faculdade tinha realmente que ter médicos para ensinar - chega um momento em que não se pode mais colocar outras profissões. Esses alunos tiveram que ir para a UFRJ do Rio de Janeiro. Lá, eles concluíram seu curso de graduação. O que estou querendo dizer com isso? Se Macaé, que fica a duas horas do Rio de Janeiro, com tantas faculdades próximas e tanto dinheiro e recursos que o petróleo dá... Vocês imaginem essa alocação de médicos para ensinar nos locais mais remotos do Brasil!

Estou falando isso com toda tranquilidade, porque há faculdades privadas excelentes, que estou conhecendo atualmente. A gente vê que muitas dessas faculdades não têm leitos de hospitais, não tem sequer unidade básica de saúde. Muitas vezes, vemos vinte, trinta, médicos atendendo um único

paciente. O que a gente pede aqui é que esse chamamento, que o Ministério da Educação faz com tanto rigor e com tanta qualidade, seja mantido, porque que quem vai ganhar com isso é a população brasileira.

O Ministério da Saúde está trabalhando forte. O Médicos pelo Brasil é um programa novo de alocação de médicos, e a gente tem certeza de que, com isso, vamos conseguir colocar médicos onde o Brasil mais precisa, tanto na atenção primária, que é a do Médicos pelo Brasil, quanto na atenção especializada.

Agradeço o tempo concedido e espero ter contribuído. Muitíssimo obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Raphael Câmara, por sua exposição!

Passamos agora a palavra ao Doutor Bruno Bianco, Advogado-Geral da União.

O SENHOR BRUNO BIANCO (ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO) - Muito obrigado, Ministro Gilmar Mendes!

Agradeço a Vossa Excelência e o parabenizo pela iniciativa.

Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes, todas as autoridades, e parabenizo todos que já fizeram suas exposições.

Ministro, é com grande satisfação, de fato, que venho fazer parte, neste Supremo Tribunal Federal, de mais uma audiência pública -

procedimento por meio do qual fica evidenciada a participação democrática na tomada de decisões em que há interpretação do texto constitucional, como também qualifica todas as decisões por meio de informações de especialistas sobre os mais variados temas. Hoje o tema em debate, como todos os outros, é de absoluta importância para o Brasil e para todos os brasileiros. Estamos diante de discussão sobre a compatibilidade, com o texto constitucional, de dispositivos legais que estabelecem requisitos diferenciados e mais rígidos, além do necessário chamamento público, para a abertura de novos cursos de graduação em Medicina e instituições de ensino superior de caráter privado.

Como se sabe, Excelência e todos os presentes, cuida-se de atividades de formação de novos médicos, profissionais que atuam diariamente com a saúde da população e, muitas vezes, salvam a vida dos brasileiros. Aliás, a importância da atividade médica, para além do que já vimos e convivemos diariamente, ficou notoriamente evidenciada, há dois anos, quando do advento da pandemia da covid-19, em que muitos profissionais, inclusive, perderam suas vidas na tentativa de salvar as vidas de seus pacientes, como muito bem lembrado aqui, há pouco, pelo Ministro Queiroga em sua manifestação.

Para lidar com tamanha responsabilidade, a lei estabeleceu parâmetros certamente mais rigorosos, com o objetivo claro de formar novos profissionais com a qualidade necessária para lidar com os desafios cotidianos da

atividade médica - obviamente, de grande importância e fundamental para a população brasileira. Assim, o legislador exigiu, dentre outras coisas, a existência de equipamentos públicos adequados e suficientes para a oferta de curso de Medicina, sem os quais não seria possível obter educação de qualidade. Além disso, a lei questionada, sempre com o objetivo de qualificar o ensino, exige que a instituição de ensino superior possua infraestrutura adequada, incluindo bibliotecas, laboratórios, ambulatórios, dentre outros equipamentos fundamentais à qualidade do ensino e à escorreita formação do profissional de saúde, no caso concreto, do médico. A discussão ora trazida pelos requerentes questiona tais requisitos sob a ótica de preceitos constitucionais atinentes à livre concorrência, à livre iniciativa e à autonomia universitária.

É certo, Ministro Gilmar, que o Estado, ao impor exigências rigorosas para dar qualidade ao ensino médico, pode, por via reflexa, restringir, sim, o número de instituições que tenham condições de cumprir com os requisitos legais, sempre em prol do interesse público e de bem formar profissionais médicos, levando em conta o interesse maior, o interesse social por trás de toda essa formação, de todo esse ensino, que é, sim, a boa prestação do serviço médico à população brasileira. Percebemos, portanto, que o tema envolve embate de disposições constitucionais, uma vez que a lei questionada foi objeto de debate no Congresso Nacional, onde se buscou o equilíbrio entre esses importantes valores e

a necessidade de se obter educação de qualidade. Note-se aqui que estamos diante de ponderação de princípios.

A concorrência entre instituições de ensino superior, obviamente, também é saudável. No entanto, existem outros valores, também constitucionais, que estão em jogo. Na minha ótica, todos os fatores devem ser levados em consideração, ponderando-se, sempre, e colocando-se em primeiro lugar, obviamente, a busca da qualidade da saúde Todos os princípios são fundamentais, mas, em nossa atividade jurídica, temos que ponderar princípios e encontrar aqueles que entendemos que, no caso concreto, sobrelevam-se em relação aos demais. Obviamente, na minha ótica e na ótica da Advocacia-Geral da União, o princípio mais importante é a boa formação médica, a educação e a boa prestação dos serviços à população brasileira.

As decisões judiciais tomadas no âmbito dos tribunais regionais federais, embora muito diversas, direcionam para a execução de liminares que excluem as exigências legais para a instituição de novos cursos, pondo em risco a qualificação dos profissionais de saúde e toda uma política bem formada no sentido da formação dos médicos. Portanto, trazem insegurança jurídica, algo absolutamente indesejado, especialmente diante de situação da saúde. Além disso, eventual reversão das liminares também pode gerar problemas significativos

consistentes na necessidade de realocação de alunos, que normalmente investem toda uma vida para a obtenção de sua graduação médica.

Nesta audiência pública, portanto, Ministro, o debate seguramente será enriquecido pelos elementos de fato que os expositores apresentarão. E já vimos quão profícuo será diante de manifestações que já ocorreram.

Ao final, seguramente perceber-se-á que, para o bom estabelecimento de curso de graduação em Medicina, é preciso cautela e parcimônia, e, mais do que tudo, observância à legislação que, na nossa ótica, é absolutamente constitucional e necessária diante dos princípios fundamentais que estamos aqui ponderando. O risco que se deve considerar, Excelência, é formarmos médicos que não tenham plenas condições de fazer frente aos desafios aos quais serão diuturnamente submetidos.

Com essas breves considerações, mais uma vez agradecendo a oportunidade da palavra, o convite e o parabenizando, Ministro, pela sua iniciativa, agradeço a oportunidade e também parabenizo todos aqueles que se manifestaram e todos aqueles que virão a se manifestar.

Muito obrigado a todos e uma ótima audiência, que certamente será importantíssima por ocasião da decisão do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agradeço ao Doutor Bruno Bianco por suas declarações. Agora, faremos um breve intervalo e voltaremos em seguida para observar nosso cronograma em relação a esta parte da manhã.

Começaremos, daqui a pouco, com a fala do Doutor Professor Raul Cutait.

O SENHOR RAUL CUTAIT (PROFESSOR, EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE) - Bom dia a todos. Ministro Gilmar Mendes, muito grato pela oportunidade.

Eu gostaria de fazer algumas reflexões na posição de médico, na posição de professor universitário e de um ex-secretário de saúde.

Todos nós, na vida, somos ou seremos pacientes. Todos nós, na vida, já tivemos algum ente querido doente. E todos nós queremos o melhor atendimento possível para nós mesmos e para aqueles que nos são próximos. Essa é uma coisa básica.

E por onde começa o atendimento? Pelo contato com o médico. O médico é quem faz "as honras da casa" para a saúde do indivíduo. E esse médico, quando se encontra com paciente, ele tem que estar preparado para cumprir o

juramento de Hipócrates, que é fazer bem para seu paciente. Agora, para isso ele precisa ser preparado.

Ser médico é complexo porque, ao longo da sua vida, ele precisa desenvolver uma série de competências, conhecimento, experiência, bom senso. Ele precisa ser dedicado, precisa ter humildade nas coisas que faz e, evidentemente, tudo isso recoberto por uma alta dose de humanismo.

Um indivíduo que resolve ser médico é estimulado durante a infância, adolescência por alguma coisa que aconteceu na vida dele, alguma coisa que ele viu, a curiosidade, a vontade de ajudar o próximo. É lá que começa a vontade de ser médico, mas é na faculdade onde ele começa a ser moldado para ser médico.

E aqui está o problema. Num curso de 7.200 horas, comparando com o de economia, por exemplo, que são 3.000 mil horas, o jovem tem que se dedicar, profundamente, ao que vai fazer, mas acontece que ele precisa ser preparado nesse curso. E nós estamos vivendo um cenário hoje bastante conflitante, eu diria, até de alto risco, para nossa população.

Com o nobre objetivo de se gerar mais atendimento para localidades onde nada existe ou pouco existe, disseminou-se a criação de novas faculdades de Medicina - isso já foi dito e redito - e o resultado é que preocupou-se muito com o acesso. Abrem-se então faculdades. Não se falou basicamente de

qualidade da formação dos indivíduos, e eu diria que houve alguns erros nessa proposta. Alguns deles estruturais.

Primeiro, não se faz faculdade de Medicina sem professor. O professor precisa ser qualificado. Ele não é um médico de atendimento. Ele é um indivíduo qualificado para isso e tem que ser preparado para ser um professor. E nós não temos o Brasil gente para todas essas faculdades. Talvez, em cadeira básica, possa valer a figura do professor itinerante, que dá aula de anatomia numa, noutra e noutra. Na área clínica, não.

O aluno precisa do convívio com professor não só para aprender coisas técnicas, mas para desenvolver a sua formação, a sua relação médico-paciente. Os professores são seus mentores, são aqueles que as pessoas olham e vislumbram na frente ser parecidos com algum deles, ou ser o anti-indivíduo que ele está vendo pela frente, mas esse convívio é fundamental. Então, isso é um erro estrutural: abrir tanta faculdade sem pensar que há a obrigatoriedade de um bom corpo docente.

Outro problema estrutural é que não se levou em conta que não adianta também só botar médico formado no mercado. Para a quase totalidade dos indivíduos é fundamental um programa de residência médica. E esses programas de residência médica são difíceis de serem montados, são complexos, requerem uma competência que não é do dia para noite que se consegue.

Então, hoje, nós já temos, com o número de médicos atuais, um hiato de mais ou menos 30% de médicos que não têm acesso à residência médica e, se nós chegarmos, como se prevê, até o fim dessa década, a 40 mil novos médicos por ano, esses 30 irão passar para 50, 55, talvez, 60, ou seja, nós estamos falando de tentar ampliar o acesso as faculdades de Medicina, mas deixando de tocar num tópico que é fundamental, que é a qualidade do ensino, que é a qualidade do médico que vai entrar no mercado e que vai cuidar de todos nós, a população. Então acho que isso é um outro erro estrutural.

Agora, existem também os erros de avaliação. Um deles é supor que hospital do SUS dá para treinar quem quer que seja. Não é verdade! Uma coisa é o médico que está tocando a sua rotina, outra coisa é o médico que está ensinando os que estão chegando. E os hospitais do SUS, embora tenham a matéria prima, vamos dizer assim, que é o paciente, eles não têm o outro lado da história, que é a sua estrutura para ensino e os professores para ensino. Então, isso foi um erro de avaliação nessa proposta, digo de novo, nobre de aumentar o acesso ao atendimento, mas é algo que não foi devidamente avaliado.

O outro erro de avaliação é que não se levou em conta uma tendência não só no Brasil, como mostram os trabalhos de demografia médica lá da nossa Faculdade de Medicina da USP... Não só nós não temos... Não só falta médico, mas o problema maior é a distribuição do médico pelo Brasil. Os médicos

não vão se instalar em cidades pequenininhas, mesmo que eles estudem no interior de Rondônia, no interior do Mato Grosso, no interior do Pará. Os médicos querem ir a um lugar onde eles possam exercer a Medicina, onde eles possam ser remunerados, onde eles possam constituir família, onde eles possam fazer com que seus filhos tenham acesso a educação de nível. Esse espaço que existe, pela leitura convencional de vamos formar mais médicos para ocupá-lo, é irreal, é irreal.

Então, não adianta formar cada vez mais médicos. Os números são assustadores. Nós vamos ter, logo mais, mais de 800 mil médicos, daqui a pouco, mais de um milhão de médicos formados, e não haverá mercado para isso. Talvez a gente tenha a infelicidade de saber que muitos desses formandos irão trabalhar em atividades não médicas, Uber, por exemplo, ou qualquer outra coisa que eles consigam, porque o médico não é preparado para mais nada na vida, ele é preparado para ser médico. Isso é um grande problema.

Se isso acontecer, nós criaremos situações dramáticas. Primeiro, cortando o sonho de um monte de gente nova, porque o médico é sonhador, cortando o sonho de fazer alguma coisa na Medicina. Segundo, muitos deles, estudando em faculdades privadas, são pessoas que gastaram o dinheiro seu, da sua família, que se cotizou para o indivíduo acabar uma faculdade que, em média, custa de 500 mil a um milhão de reais e sem a perspectiva de recuperar esse dinheiro lá na frente. A situação é muito frustrante.

Então, não adianta só pensar em abrir vagas e, em princípio, facilitar o acesso das pessoas aos sistemas de saúde público ou privado. Tem que se pensar na qualidade de quem vai entrar no mercado.

Essa breve introdução é apenas para dizer que a segurança da saúde da população passa por pessoas bem formadas - é inevitável -, passa por gente bem formada que, mesmo que não saiba resolver, consiga jogar em frente ao que fazer.

Eu diria que o problema não é fechar faculdades de Medicina, o problema é deixar faculdades de Medicina competentes funcionarem. Para isso, são necessários quatro itens - e eu finalizo. Primeiro: que os currículos sejam bem-preparados, que haja uma maneira de os currículos serem definidos de modo a preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Segundo: é fundamental que os alunos sejam avaliados. Terceiro: é fundamental que as faculdades sejam avaliadas. Quarto: é fundamental que os centros de ensino de treinamento também sejam avaliados. Somente se criando uma condição mínima de funcionamento é que se conseguirá melhorar as condições das nossas faculdades. Vejam: há muita instituição boa para abrir faculdades, muitas faculdades novas bem-preparadas, mas não é a regra geral.

O negócio é muito bom. Todo mundo que viu o *Valor Econômico* de sexta-feira viu duas faculdades do interior de dois estados vendidas por 850 milhões de reais, 2,4 milhões cada vaga, é um bom negócio.

Então, temos que pensar quem temos que favorecer: quem está atrás de um bom negócio, ou o que a população do Brasil precisa? Então, Ministro, o tema é qualidade. Qualidade só se consegue com bom sarrafo. Bom sarrafo implica avaliar aluno, faculdade e centros de treinamento.

Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado, Professor Raul Cutait.

Ouvimos agora o Doutor Marcelo Moura da Conceição, da Procuradoria-Geral da União.

O SENHOR MARCELO MOURA DA CONCEIÇÃO (COORDENADOR-GERAL DE DIREITO SOCIAL, ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DA PGU) - Bom dia a todos. Eu vou falar em nome da Procuradoria-Geral da União, que é o órgão responsável pela defesa judicial da União, no caso, os Ministérios da Educação e da Saúde, junto à Justiça Federal de Primeira e Segunda Instâncias.

A gente tem visto aqui, desde a primeira fala foi abordada a questão do alto número de liminares que são deferidas para processamento e

abertura dos cursos de Medicina, e isso tem sido uma preocupação muito grande nossa na nossa atuação.

Os principais pontos que são judicializados, e a maioria deles já foram abordados aqui, são a regra do chamamento público trazida pela Lei do Mais Médicos; a Portaria MEC nº 328/2018, que trouxe uma suspensão de protocolo para os aumentos de vagas e novos editais pelo prazo de cinco anos; e os pedidos de protocolo sem tramitação ou impossibilidade de avanço administrativo. O que a gente tem enfrentado na dinâmica da judicialização? Pedidos que são apresentados no Ministério da Educação e, por conta da portaria e por conta da Lei do Mais Médicos, ficam paralisados. As liminares têm sido nesse sentido de tramitação desses processos administrativos, e a gente tem visto uma dinâmica de concentração dessas ações. Isso é uma coisa um pouco comum na judicialização, mas a gente tem, nesse caso, por conta dos interesses envolvidos e do número de empresas e de interessados, um aumento muito grande da judicialização, especialmente nos anos de 2021 e 2022. A gente tem uma concentração muito grande dessas ações no Tribunal Regional Federal da 1ª Região aqui em Brasília, por conta do foro universal da Constituição de 88, e a gente tem um percentual mais ou menos de 60% das liminares que são deferidas. Qual tem sido essa dinâmica? A AGU tem enfrentado as liminares deferidas por alguns juízes de Primeira Instância e a maioria das liminares têm sido deferidas monocraticamente

no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ele é composto por duas Turmas julgadoras, a gente tem uma Turma com posicionamento favorável e uma outra Turma com posicionamento desfavorável.

O que nós já temos de decisões colegiadas nessa matéria? A gente tem os Tribunais Regionais Federais da 3ª e da 1ª Região. Na 1ª Região, por sua Sexta Turma, mantendo a lógica do chamamento público à portaria do Ministério da Educação sobre a suspensão do protocolo de tramitação, exatamente sob essa visão de que é livre a iniciativa privada, mas depende de autorização do poder público. E aqui é o problema onde a gente tem a maioria das nossas ações e os recursos que a AGU tem interposto em todos os casos, a gente tem um predomínio de decisões monocráticas desfavoráveis aqui no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, por conta de previsão constitucional, é possível de apreciar pedidos de abertura de cursos em todo Brasil. A gente tem enfrentado essas liminares em agravos de instrumento e a gente não tem conseguido, apesar de todos os pedidos, apesar de todas as tentativas, que esses recursos sejam pautados para julgamentos colegiados. A nossa preocupação tem sido um pouco a tendência da jurisprudência da Quinta Turma a respeito de afastar a lógica do chamamento como a única forma - e isso aqui foi muito bem exposto pelos Ministros de Estado da Educação e da Saúde e pelas demais autoridades, todas as preocupações e os fundamentos pelos quais isso foi estabelecido pelo legislador e

pelo Poder Executivo -, mas a gente tem visto uma tendência de afastar a lógica do chamamento para uma tramitação à medida que os pedidos são apresentados

Qual tem sido a nossa preocupação? A gente tem visto algumas decisões com uma lógica um pouco mais rasa do que toda a preocupação que a gente tem discutido aqui, e acho que o Supremo é o melhor foro para essa discussão. A gente tem visto que os desembargadores têm simplesmente acatado e determinado o processamento dos pedidos. A União tem ido a todos esses processos, seja nos juízes, seja nos desembargadores, apresentar o que está por trás dessas regras, porque a gente não está discutindo meramente um pedido de autorização, mas tem toda a preocupação, já foi muito bem trazido aqui, eu não preciso entrar nesses detalhes a respeito da qualidade do curso, do impacto para os estudantes. Mas a gente tem enfrentado ainda um pouco de resistência a qualificar essa discussão.

Quando a gente consegue chegar nos colegiados, a gente viu na Sexta Turma do TRF da 1ª Região e no TRF da 3ª Região, a gente consegue maiores sucessos no sentido de proteger e prestigiar o entendimento do Poder Executivo, dos Ministérios da Educação e da Saúde.

Qual tem sido a forma de atuação da PGU? E até pelo despacho do Ministro Gilmar, acho que é importante entrar um pouco nesses detalhes. A gente tem acompanhado todos esses casos com todas as defesas, todos os recursos

cabíveis sempre buscando provocar os desembargadores e os colegiados para que essa discussão seja feita pelos desembargadores em conjunto e abordando todos os temas com a profundidade que a matéria merece. A gente tem apresentado, nos tribunais, o impacto das decisões que deferem uma tramitação de uma autorização de curso.

E, com a lógica do chamamento e as necessidades das regras específicas para a análise da abertura de um novo curso de Medicina, tem muita coisa que precisa ser analisada e não se limita àquela lógica do pedido de liminar de tramitação processual. Essa liminar, quando ela chega no Ministério da Educação para cumprimento, causa muitos transtornos, porque a gente tem uma região de saúde que a gente pode estar muito bem superlotada de estudantes; a gente tem toda a necessidade de verificação da qualidade daquele curso e a gente não tem conseguido esse respaldo do Judiciário para adentrar essa discussão, porque, infelizmente, acho que o termo mais usado aqui foi liminares, a gente ainda está brigando para essas liminares se transformem em julgamentos colegiados.

E, na lógica, os pontos principais que a AGU tem levado, grosso modo, além de todos os argumentos técnicos muito bem já apresentados aqui, são a previsão da Constituição de que o ensino é livre à iniciativa privada, mas que depende de autorização do poder público. E as regras estão aí postas para isso.

E que a Portaria MEC da suspensão dos protocolos de cursos tem amparo não só Lei do Mais Médicos, mas na necessidade de organização das regras e demandas dos cursos.

E agora acho que a gente tem uma informação muito boa, muito atual a respeito do grupo de trabalho que reiniciou o seu trabalho exatamente para que essa tramitação administrativa e essas regras sejam estabelecidas.

Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Acho que eu busquei trazer um pouco da dinâmica da judicialização. Acho que esse foro da ADC é o melhor foro para essa análise e para essa decisão conjunta nacional.

Muito obrigado e bom dia!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Marcelo pela exposição.

E agora ouviremos, em modo virtual, a Doutora Francisca Valda, Conselheira Nacional de Saúde.

SENHORA FRANCISCA VALDA DA SILVA (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) – Bom dia a todas, todos, todes!

Ilustríssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes e demais autoridades presentes nesta audiência, sou Francisca Valda, enfermeira e

professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalhei na gestão do Município de Natal e na Secretaria Estadual de Saúde, na gestão do trabalho e educação na saúde. Sou membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão colegiado, deliberativo, composto por representantes do Governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros do SUS, cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, conforme a Lei Federal nº 8.142; coordenadora da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho.

Inicio a minha argumentação em nome do Conselho com os agradecimentos pela oportunidade da palavra desse órgão colegiado que representa os usuários do SUS.

O Conselho Nacional de Saúde participa nos processos e fluxos regulatórios dos cursos da saúde conforme determinação legal, objetivando preservar a qualidade, a relevância social dos cursos, o interesse público da formação de profissionais para o setor saúde.

A competência do Conselho Nacional de Saúde para a participação no processo e fluxos regulatórios, junto ao Ministério da Educação, se

dá, sobretudo, pelos seguintes dispositivos legais: Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência do SUS para o ordenamento da formação de recursos humanos para o setor; Leis Federais nº 8080, nº 8142, de 1990, e o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

Como se pode verificar, os dispositivos legais orientam a análise do Conselho Nacional de Saúde sobre a abertura de cursos de medicina, assim como o reconhecimento e renovação de reconhecimento. E abrange os cursos criados nos processos regulares.

O CNS tem buscado preservar essa competência formal, compreendendo tratar-se de uma função social relevante exercida na forma da lei. E realizá-la de tal forma que ela qualifique a formação dos profissionais, mesmo como, nos últimos anos, essa competência deixou de ser reconhecida pelas instâncias governamentais.

No ano de 2022, duas ações relevantes buscaram a mediação das instâncias do Judiciário. A primeira delas, preservar a competência do CNS na avaliação de cursos. É uma ação que considera frágil a argumentação que retirou do Conselho essa prerrogativa. A ação foi solicitada pelo Ministério Público Federal e a decisão da 22ª Vara Judiciária, que determina que o Ministério da Educação deve consultar o Conselho Nacional de Saúde nos processos de autorização e reconhecimento. A segunda iniciativa é uma ação civil pública do Ministério

Público Federal, em 27/7, que suspende a autorização do funcionamento de novos cursos de graduação a distância. Está em andamento.

Como se verifica, o Conselho tem atuado para garantir a qualidade e a relevância da formação.

A ação do Conselho na avaliação dos cursos visa assegurar que a regulação do mercado sobre o sistema regulatório de responsabilidade do Estado não comprometa a relevância social da formação e o princípio da preservação, da proteção, da integridade física, subjetiva e moral, e proteção da dignidade humana. E subjetiva das pessoas em relação ao seu direito à educação e à saúde.

O segundo ponto, que eu queria abordar, tem a ver com o registro dos parâmetros de critérios de avaliação.

A avaliação do CNS para os cursos inclui três planos, três eixos: a capacidade do curso e da IES de atender as necessidades sociais e compromissos do SUS; a coerência do projeto político-pedagógico, no que se refere às determinações sociais do processo de saúde e doença; e com as necessidades sociais e sanitárias do território onde o curso se insere; e a relevância social do curso.

Essa é a principal conclusão dos estudos internacionais que definem, inclusive, a integração entre a formação e o trabalho.

Com base nessas disposições, o Conselho Nacional de Saúde registra, nesta oportunidade, algumas considerações sobre a qualidade dos cursos de Medicina.

É indiscutível a escassez de médicos e a irregular distribuição no território nacional. E a solução estrutural, de tal diagnóstico, é a ampliação da oferta de vagas.

O Programa Mais Médicos foi relevante para alterar o cenário, mas insuficiente. Foi tímido o crescimento. Sendo que foi, na prática, a primeira política pública estruturante na ampliação ordenada de vagas no Sistema Federal de Ensino. O componente de expansão de vagas do Mais Médicos teve um impacto relativamente pequeno, com um acréscimo de 60 cursos, que representam 15% do total.

O Brasil, hoje, tem 391 cursos de medicina, 245 municípios, 42 mil vagas autorizadas e ativas. A oferta dos cursos nos municípios do interior, 285 cursos, 63% do total. Se nós olharmos o coeficiente ponderado, nós iremos ver que há uma iniquidade e insuficiência de vagas de Medicina que acompanha a insuficiente presença de profissionais e a iníqua distribuição do território nacional.

O assunto é complexo. Eu vou caminhar para o final, colocando que os dados ponderados, se você vir os dados de forma geral, você não vê uma distância muito grande. Mas, se for para os dados ponderados, nós vamos chegar

a dados que tornam evidente a iniquidade na distribuição desses profissionais. Os coeficientes de médicos por especialidades nas localidades variaram de 0,77 por mil habitantes, na Região Norte, com 1,20 nas capitais.

As questões corporativas e privadas quanto à ampliação de médicos e vagas de Medicina traduzem o uso seletivo das bases de dados. Nós, do Conselho Nacional de Saúde, referendamos e legitimamos o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES.

Então, a formação médica exclusiva ou prioritariamente já superada internacionalmente, apenas as competências do diagnóstico e tratamento de doenças nos serviços territoriais. Nós defendemos a saúde, a preservação da vida e a proteção, e essa inclui diagnóstico, tratamento e reabilitação.

Por outro lado, a necessidade de um corpo docente - retomamos aqui, já foi abordado por outros interlocutores - com boa formação pedagógica e com boa produção técnica e científica também é condição necessária para uma formação médica de qualidade. Temos vistos muitas IESs privadas, com vínculos precários, inseguros, com alto protagonismo de mecanismos tecnológicos no lugar da educação presencial e da prática presencial.

Por fim, queremos registrar a expectativa de que esta audiência pública e a posição do egrégio Supremo Tribunal Federal fortaleçam o esforço feito pelo Conselho Nacional de Saúde para assegurar condições de excelente formação

à juventude brasileira que escolhe as profissões da saúde para cuidar da vida das pessoas. No momento, ainda, mais forte de mudança da formação de alcançar os direitos à educação superior e à saúde da população brasileira.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado Doutora Francisca Valda.

Agora vamos ouvir o Deputado Federal Hiran Gonçalves, Presidente da Frente Parlamentar Mista de Medicina do Congresso.

O SENHOR HIRAN GONÇALVES (DEPUTADO FEDERAL) - Boa tarde a todas e a todos! Excelentíssimo Senhor Ministro da Suprema Corte Gilmar Mendes, quero fazer uma saudação em nome da Medicina brasileira, que eu represento no Congresso Nacional, a todos também componentes desse dispositivo, meu amigo Bruno Bianco, nosso Procurador Luís Santos, Lucas Faber, e Paulo Sauro Nogueira. Uma saudação a todos os presentes, representantes das associações, dos sindicatos, de todas as entidades aqui representadas.

É uma honra fazer parte deste debate tão importante e que visa, ao final, uma boa prestação de serviço à saúde dos brasileiros.

Ministro Gilmar, senhoras e senhores, nós estamos aqui, a meu ver, em frente a dois tripés fundamentais na nossa cidadania. O primeiro deles é o que preceitua a Lei nº 8.080, que diz que o SUS deve ser integral, equitativo e

universal. E esse tripé, que é pétreo, ele só é conseguido por meio da formação adequada de profissionais da área da saúde, não só médicos, mas da equipe multiprofissional da saúde, que é encabeçada, obviamente, por um médico.

Nós estamos, aqui, discutindo sobre qualidade, sobre quantidade e sobre interiorização.

E, Ministro, eu sou médico, médico do INAMPS (eu fiz concurso do INAMPS, eu acho que a maioria daqui dessa sala nem tinha nascido, quando eu fiz o meu último concurso em 82), também sou médico legista federal aposentado e sou especialista em oftalmologia. E continuo, ainda, até hoje conseguindo conciliar a minha atividade política, como deputado federal - e, agora, eleito senador da República pelo meu estado -, com a atividade médica; procuro praticar o estado da arte da oftalmologia lá naqueles rincões do hemisfério norte do nosso país que é Roraima.

Eu ouvi aqui a todos, com muito cuidado, e queria dizer que eu fiquei triste, porque escrevi um monte de coisa que não serve para absolutamente nada, pois a maioria já falou tudo que tinha que ser falado, aliás, com muita propriedade e com muita inteligência.

Cutait, você falou aqui de cenário de prática. Eu tenho filha médica, eu tenho dois filhos que fazem Medicina, e eles jamais serão bons médicos, se não tiverem bons tutores, bons orientadores. E nós, segundo o nosso Conselho

Federal de Medicina, temos, das 388 faculdades de Medicina no Brasil, apenas 20% dessas faculdades proporcionam um cenário de prática adequado para que os nossos alunos de Medicina sejam adequadamente formados.

E eu estava pensando ali sobre a nossa vida prática.

A maioria das pessoas que conheço ali no Congresso Nacional, elas, quando têm algum probleminha, correm para São Paulo - "Ah! Eu tenho que falar com a Ludmila, que estava aqui há pouco tempo". É assim! Vocês sabem por quê? Porque está introjetado na nossa cabeça que só quem faz boa Medicina é São Paulo, pois tem os melhores cursos, tem as melhores residências. E isso é verdade.

Contudo, nós temos um desafio, e esse desafio já foi consignado por todos que me antecederam, de tornar cada vez mais rigorosa a avaliação dos cursos de Medicina existentes. Porque, Ministro, muito se falou, aqui, e se esqueceram de dizer uma coisa importante: a maioria dos cursos de Medicina do nosso país não tem médicos ensinando Medicina; a maioria dos professores não são médicos. Precisamos garantir que médicos, professores - aliás, eu também sou, fui professor da Universidade Federal do meu estado -, eles têm que ser preparados para ensinar Medicina para quem vai ser médico. E isso não acontece hoje! Na maioria dos cursos de Medicina do nosso país, há outras profissões ensinando Medicina para quem vai ser médico.

Olha só que incongruência!

Então, acho que estamos aqui, primeiro, salientando a pertinência desta audiência pública e a sua inteligência, reconhecidas por todos nós, e a sua sensibilidade de trazer aqui tantos profissionais qualificados para lhe dar subsídio para decidir, como o é de seu feitio, com muita segurança e sempre visando o bem-estar e à saúde do povo brasileiro.

Nós não podemos, aqui, Ministro, criar decisões. E decisões liminares, eu não sou operador do Direito, mas acho que uma decisão liminar é algo muito frágil para aprovar abertura de novas vagas em curso de Medicina. E creio que o Senhor também é de acordo com isso, conhecendo o Senhor, como eu conheço a sua história.

Então, nós precisamos, sim, cada vez mais, estar vigilantes - e estarei vigilante -, para que nós sempre possamos salvaguardar a saúde do nosso povo, seja na saúde suplementar do nosso país, ou no Sistema Único de Saúde do nosso país, por meio de políticas públicas, de avaliações públicas, que garantam que o médico que sai da universidade, seja ela pública ou privada, esteja preparado para entrar em uma residência qualificada, já que temos também muitas residências em nosso país que absolutamente não ensinam adequadamente o médico a prestar serviço depois de formado. A nossa residência médica é o padrão ouro da formação da pós-graduação dos médicos no Brasil, mas ela também necessita de aperfeiçoamento. As bolsas precisam ter melhor remuneração para dar condição

digna aos profissionais, a fim de que eles trabalhem e aprendam, com eficiência, essa profissão que trata do nosso bem maior: a saúde e a vida.

Então, quero, primeiramente, saudar todos os que me antecederam em suas falas. Aliás, com raras exceções, todos falaram mais ou menos na mesma direção. Cada um utilizou as suas argumentações, as suas experiências, mas foram muito claros que nós devemos ter muito cuidado com a abertura de novas vagas em cursos de Medicina. Farei um desafio aqui: nós só vamos olhar isso com mais seriedade quando fecharmos alguma dessas faculdades vendedoras de diplomas, que regulamentam a vida de alunos oriundos do exterior, os quais vêm para praticar a Medicina, tentando burlar o nosso marco legal de Estado, aprovado com dois votos na Câmara Federal, o nosso revalida, para aprovar a atividade médica no nosso País.

Portanto, quero parabenizar a todos e dizer que essa luta é contínua. A necessidade de médicos no Brasil vai aumentar, porque a população aumenta, os nossos problemas aumentam. No entanto, aqui, nós demos um pontapé importante para termos cada vez mais cuidado com a formação do médico brasileiro, avaliando com muito critério essas 388 faculdades de Medicina já existente em nosso país.

Encerrando, estava analisando os números, temos dez faculdades de Medicina em Rondônia. Nós temos dez faculdades de Medicina em

Rondônia! E há a necessidade médica e muitos médicos formados na Bolívia querendo vir para Rondônia. Esse é um debate permanente do movimento médico brasileiro, tanto nas associações conselhais, sindicais, associativas, na Câmara Federal e no Senado da República obviamente. Esse é o meu compromisso.

Ministro, muito obrigado pela oportunidade que nos dá. Sigamos em frente, sempre defendendo a saúde do povo brasileiro.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado ao Deputado Hiran Gonçalves.

Nós, agora, ouviremos, pelo modo virtual, o Deputado Federal Frederico Escaleira.

O SENHOR FREDERICO ESCALEIRA (DEPUTADO FEDERAL) - Boa tarde, Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, que preside esta audiência pública!

Cumprimento a todos os demais Excelentíssimos Ministros de Estado, ex-Ministros de Estados, demais autoridades e oradores que tiveram a palavra antes da minha participação, o nosso presidente da Frente Parlamentar de Medicina; o Deputado, eleito Senador, Hiran Gonçalves.

Senhor Ministro, para que possamos ter muita objetividade e para tentar acrescentar informações de relevância a esta audiência, compartilho muito do que foi colocado aqui pelo nobre colega Hiran Gonçalves.

Fui deputado federal no primeiro mandato e reeleito pra o segundo, médico, especialista em oncologia clínica, área de cancerologia. Entre outras atuações, tive a oportunidade de, durante um ano e meio, ser professor de uma faculdade privada de Medicina. Quero deixar aqui que não há conflito de interesse na minha fala. Sou um representante da população, eleito pelos pacientes, pelos pacientes oncológicos, pela população que necessita do Sistema Único de Saúde.

Passarei alguns dados em relação à formação médica, porque sabemos que existe uma carência, às vezes até algum vazio assistencial, em um país de proporções continentais como o Brasil. Esse vazio assistencial precisa ser tratado como política pública séria. Entendo que o Médicos pelo Brasil, com a mudança do sistema de remuneração, favorecendo os médicos que vão trabalhar nessas áreas de vazio assistencial, áreas com menor disponibilidade de recurso, começou uma pequena correção, mas a gente observa que, no geral, em âmbito nacional, a atenção básica à saúde vem cumprindo o seu papel. Ela é primordial, fundamental. É muito importante que as pessoas tenham acesso básico à saúde por meio das equipes de saúde da família, das estratégias de saúde da família. O que observamos, em Minas

Gerais, meu estado, é que a maioria dos municípios vem conseguindo atender essa carência de médicos especialistas em saúde da família em seus postos de saúde, o que é um grande avanço. É importante que esse tipo de tratamento, de atendimento inicial aos pacientes, continue sendo sempre defendido em todo país.

Porém, Senhor Ministro, enquanto deputado, médico, acabamos recebendo grande parte das demandas da população. Sabemos que a medicina de saúde básica, a medicina de família, resolve em torno de 70%, 80% dos problemas de saúde. Mas, muitas vezes, é necessário realmente um especialista, seja no sistema de urgência-emergência - que precisa muito de especialistas -, seja nas unidades de atendimento especializados.

O que acho mais importante desse foco que quero destacar é que uma parte importante do conhecimento médico é realizada dentro dos hospitais. Na experiência como aluno e, depois, como professor, a gente precisa de atendimento hospitalar. O que entendemos como realmente estar sendo um desmando é a quantidade de faculdades de Medicina funcionando no país sem os devidos leitos hospitalares de retaguarda para garantir a possibilidade desses alunos terem o ensino prático de Medicina.

Vamos puxar para a prática. O leito hospitalar é onde os alunos conhecem as patologias, as doenças. É onde ele aprende a identificar uma insuficiência cardíaca, um câncer, uma insuficiência respiratória e todos os outros

problemas de saúde. O médico, mesmo que vá ser generalista, precisa ter conhecimento das doenças, para não colocar a vida de um paciente em risco ao deixar de identificar essas doenças ou para que não peça exames desnecessários, procedimentos desnecessários, na saúde básica, por não ter conhecimento da doença e estar inseguro.

De forma objetiva, Senhor Ministro, entendo que o STF precisa ter maior cautela no julgamento de liminares e processos de abertura de cursos em relação aos leitos hospitalares do SUS. Já está preconizada a abertura de novos cursos na portaria que orienta e normatiza. O que a gente percebe é que, com raras exceções, essa relação leitos hospitalares do SUS e cursos de Medicina está muito precária. Esta, Senhor Ministro, é uma forma de impor às universidades, às faculdades, que participem do sistema de saúde público também, do SUS, de forma assistencial. Como foi bem colocado, são universidades que têm uma questão financeira importante e que podem contribuir muito apoiando esses hospitais que prestam serviço de atendimento ao SUS. É uma parceria de grande importância para o país, porque, além de formar bons médicos, com unidades hospitalares para identificar os pacientes, as patologias, os exames a serem solicitados e os tratamentos a serem efetuados, a universidade também tem a obrigação moral e legal de participar da melhoria da atenção à saúde da população brasileira.

Por isso é uma decisão de grande importância, grande responsabilidade. Sabemos que o STF, o Colegiado e Vossa Excelência, tem ampla capacidade técnica, ampla assessoria, para tomar as melhores decisões, mas realmente entendemos que a abertura de novos cursos, sem estrutura adequada, principalmente sem leitos de atendimento ao SUS que permitam a maior parte das aulas práticas dos alunos, há grande risco de formarmos profissionais sem habilitação, sem capacidade técnica, para conseguir atender os pacientes.

Por fim - até para diminuir meu tempo - a gente tem um problema na Medicina, Excelentíssimo Ministro. A Medicina não costuma permitir segunda chance. Quando um paciente vem diante de um médico, em alguns momentos, se esse médico erra um diagnóstico, se esse médico deixou de ter uma formação, deixou de ver essa patologia na faculdade, e erra o diagnóstico, muitas vezes, o paciente perde a vida por isso.

Por isso, a gente sempre ressalta: precisamos aumentar o número de médicos com qualidade no Brasil sim, mas aumentar o número de médicos sem qualidade de formação é um altíssimo risco. Muitos milhares, até milhões, de brasileiros podem não ter a segunda chance de ter um médico bem formado.

Por isso, a gente coloca que, no nosso entendimento, a responsabilidade de abrir novos cursos deve ser uma decisão prioritária do MEC e

do Ministério da Saúde, que são os órgãos que devem determinar a abertura ou não de novos cursos.

Agradeço imensamente a oportunidade e o privilégio de estar participando dessa audiência pública. Parabenizo o Ministro Gilmar Mendes pela excelente audiência pública. Parabenizo a todos os demais Ministros, ex-Ministros, colegas parlamentares, colegas médicos e demais oradores. A gente se coloca sempre à disposição para acrescentar o que for possível.

Muito obrigado a todos!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agradeço ao Deputado Frederico Escaleira e passo a palavra agora ao também Deputado Federal Luiz Antônio Teixeira Júnior.

O SENHOR LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA JÚNIOR (DEPUTADO FEDERAL) - Boa tarde, Senhor Ministro Gilmar Mendes! Gostaria de agradecer o convite para participar desta audiência pública, a oportunidade de falar aqui, para todo Brasil, de tema tão importante.

Sou médico ortopedista. Fui eleito deputado federal pelo Partido Progressista em 2018 e reeleito no pleito do último dia 2 de outubro. Quero deixar consignada minha opinião sobre esse assunto: não há necessidade de abertura de novos cursos de Medicina, e, sim, uma avaliação criteriosa dos cursos já em funcionamento.

Nosso presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina, o Deputado Hiran Gonçalves, fez uma apresentação com muita maestria, como sempre, dizendo da necessidade de termos médicos atuando diretamente como professores nos nossos cursos universitários.

Nós queremos, sim, ter cursos universitários de Medicina com bastante qualidade. Infelizmente, isso não vem acontecendo. Por isso, causa-nos preocupação a abertura de novos cursos, principalmente, sem estrutura, Ministro, porque foram abertos cursos de Medicina sem hospitais universitários correspondentes para atender esses alunos. A maioria dos cursos de Medicina abertos em nosso país nos últimos dez anos está vinculada a hospitais que não têm condições de atuarem como hospitais de ensino.

Por isso, defendo e vou apresentar, nessa próxima legislatura, o exame de proficiência médica, para que todos que terminem o curso de graduação em Medicina façam o exame de proficiência médica, assim como no Direito, para exercer a profissão de advogado, para a gente ter condições e certeza de que esse profissional, formado médico, possa exercer uma medicina de qualidade, para o bem da saúde da população brasileira. Por isso, vamos apresentar o projeto de proficiência médica que, com certeza, vai ajudar a distinguir as faculdades boas e as que não têm condições de funcionamento.

A partir do momento em que mais alunos façam o exame de proficiência médica e a gente saiba - os pais, as pessoas que financiam essa faculdade - que, ao sair daquela faculdade, a pessoa não vai estar habilitada para fazer o curso de Medicina, com certeza, vamos começar a fazer uma seleção de quais faculdades de Medicina têm condições de funcionamento em nosso país.

Tenho defendido a prática médica e a residência médica e, com certeza, vamos continuar brigando.

Parabenizo essa audiência pública no Supremo Tribunal Federal e Vossa Excelência, por estar ouvindo a sociedade, nessa que, com certeza, é uma das discussões de base para o bem da saúde brasileira nos próximos anos.

Muito obrigado, Senhor Ministro!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agradeço a fala do Deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior e, em seguida, ouviremos o Doutor Gustavo Augusto Freitas de Lima, Conselheiro do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica.

Antes, gostaria de dar um aviso. Nossa transmissão pela TV Justiça será interrompida, daqui a pouco, por conta do horário eleitoral. Continuaremos no YouTube.

O SENHOR GUSTAVO AUGUSTO FREITAS LIMA (CONSELHEIRO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DEFESA

ECONÔMICA) - Senhor Ministro Gilmar Mendes, agradeço muitíssimo pela iniciativa desta audiência pública, por esse convite para que o Cade possa expor a sua posição.

Saúdo todas as autoridades aqui presentes, na figura do Advogado-Geral da União, Doutor Bruno Bianco, excelente profissional e amigo.

Saúdo, ainda, os profissionais aqui presentes, médicos, professores, advogados, servidores, estudantes e todos que nos acompanham presencialmente e remotamente.

A visão que eu pretendo trazer aqui, Ministro, é a visão um pouco mais econômica e sob a ótica do mercado, não por entender que essa visão tenha mais ou menos preponderância, mas para se trazer uma visão distinta e poder corroborar a visão de Vossa Excelência. Então, trago aqui a visão do Tribunal do Cade, que está, nessa ótica, preocupado com a defesa econômica.

O que a teoria econômica nos mostra, de modo geral, é que, quanto maior a oferta de qualquer produto, de qualquer serviço, a tendência é que se tenha uma diminuição de custo. De modo geral, quando um mercado é aberto e quando há uma maior possibilidade de oferecimento de serviços, em regra, se são serviços que são *commodities* e são serviços que são homogêneos, você tende a ver uma diminuição do preço.

Contudo, o critério preço não pode ser o único critério avaliado. Por isso, nós utilizamos também - e é, de modo geral, a grande ótica do Cade - o critério chamado do bem-estar do consumidor, que é o *consumer welfare standard*. Então, em alguns casos, a simples diminuição de preço pode embutir uma externalidade negativa quando aquele serviço que é oferecido de uma forma mais barata acaba causando danos à sociedade.

Aonde quero chegar?

Quando nós estamos analisando os cursos de Medicina, nós temos que analisar a existência de dois mercados diferentes. O primeiro é o mercado dos estudantes de Medicina que pretendem se formar, que pretendem contratar cursos, e, por isso, de modo geral, procurarão as universidades mais baratas, de maior qualidade e que estejam próximas a eles. Temos também um segundo mercado, que é o da sociedade em geral, que irá ser servida por esses médicos formados e que irão fazer os atendimentos, uma vez formados.

Se simplesmente observarmos a ótica do preço, o mais lógico seria permitir a abertura de quantos cursos sejam possíveis e formar o maior número de médicos que seja possível, porque, nesse critério, analisando por essa única ótica, o preço tenderá a descer. Porém, essa ótica poderá ocultar um custo para a sociedade. Por quê? Primeiro: teremos estudantes que contratarão os cursos de Medicina e não terão o retorno que esperam, ou seja, o trabalho como médico,

porque, ao fim e ao cabo, quem estuda Medicina contrata esse serviço com o objetivo muito claro de exercer a profissão. Segundo: podemos ter uma externalidade negativa para a sociedade, que poderá ser prejudicada por um trabalho de pior qualidade e, em se tratando de Medicina, o custo que se pode ter com isso é o custo mais alto possível de ser pago pelo ser humano, que é o custo da própria vida.

Digo isso, portanto, primeiro para dizer que é uma preocupação do Cade - vemos com certa ressalva - o fechamento absoluto de abertura de novos cursos, porque esse fechamento absoluto pode impedir que novos agentes disruptivos, que sejam qualificados e tenham tecnologias de ensino igualmente eficientes ou mais eficientes do que as outras existentes, entrem no mercado. Então, qualquer vedação absoluta à entrada de novos concorrentes é algo que o Cade vê com restrição. Porém, encaramos com naturalidade e entendemos desejável que sejam estabelecidos, sim, critérios para a entrada e freios para a entrada, porque a abertura indiscriminada de cursos universitários que não tenham uma qualificação mínima adequada também pode ser tão nociva para a sociedade quanto simplesmente o aumento do custo dos serviços sobre os quais eu já discorri.

Na experiência do Cade, o mercado universitário, de modo geral, é um mercado municipal, ou seja, onde a concorrência se dá dentro de um mesmo município. E, aí, nós temos a seguinte questão: em que ponto a abertura de

cursos universitários em municípios pode se mostrar sustentável? Então, considerando os dados da média dos países da OCDE - e eu digo isso não para dizer que o Brasil tem que chegar nesse nível - mas, para se mostrar o quantitativo do mundo desenvolvido, a média dos países da OCDE tem três e meio médicos por mil habitantes. Então, se nós utilizarmos como critério, por exemplo, uma cidade de 200 mil habitantes, o número que nós teríamos que ter de médicos é algo em torno de 700 médicos para atender a esta cidade. Considerando uma vida útil do médico de 35 anos, ou seja, ele se formando e exercendo mais 35 anos, para se ter esse universo de 700 médicos, nós teríamos mais ou menos que formar algo em torno de 20 médicos por cada turma. E eu faço esse breve exercício para mostrar o seguinte. Em cidades onde a população seja inferior a 200 mil médicos - e uma turma de 20 médicos é uma turma muito pequena, pode ser que não tenha nem escala no curso de Medicina para se formar tão pouco -, então em cidades com menos de 200 mil habitantes, o que provavelmente ocorrerá é que essa universidade não terá escala ou poderá acabar formando um número de médicos em números acima ao que vemos em países desenvolvidos, o que muito provavelmente indicará, principalmente em cidades que não são metrópoles, que esses médicos não encontrarão um mercado de trabalho para a sua atividade. E essa visão corresponde a muitas análises do Cade em outros mercados, mostrando que

cidades abaixo de 200 mil habitantes não costumam ter escalas para serviços mais sofisticados, e vemos isso em muitos casos.

Então, primeiro, nos preocupa a abertura de universidades em localidades onde não haja uma escala que permita uma formação com qualidade, e isso é um critério que tem que ser avaliado. E a segunda questão, mesmo que admitamos, por exemplo, que numa cidade de 200 mil habitantes será aberto um curso de Medicina, o que nós teremos é a figura de um monopolista, que é algo que também preocupo o Cade. Então, de modo geral, nós observamos, nos mercados universitários, que tem que ter uma competição e que participações acima de 30% na taxa de matrícula de um determinado mercado relevante costumam implicar em fechamento de mercado.

E o que poderá ocorrer? Se permitirmos a abertura de cursos universitários em pequenas cidades, que somente comportarão um único curso universitário, ou seja, onde não haverá concorrência, nós poderemos estar fechando esse mercado para o futuro. O que isso quer dizer? Na teoria econômica, é muito comum a vantagem do primeiro concorrente, o *first mover*, então, se você abre indistintamente o mercado para mercados que somente suportem uma única universidade, o que poderá ocorrer no futuro é que se torne impossível, em termos de escala, que novas universidades possam contestar esse mercado. E, se esse *first*

mover é uma universidade que não tem padrões qualitativos suficientes, isso poderá impedir que, no futuro, universidades mais eficientes surjam.

Então, quando se analisam os mercados, os mercados não podem ser analisados cidade a cidade, eles têm que ser pensado a nível de concorrência na região, tentando se imaginar pelo menos de três a cinco universidades que sejam capazes de competir entre si. De modo geral, o Cade usa, para esse critério, o critério de raio, e ele parte em cima dos consumidores. Ou seja, um critério que é simples de se fazer é se verificar os novos matriculantes num curso de ensino, verificar onde eles residem, e a teoria econômica nos mostra que o raio é de 60% desses novos entrantes. Então, a partir desse raio, você pode ver a região onde as universidades competem entre si, e, a partir disso, você consegue entender a dinâmica do mercado.

Digo isso porque temos visto com preocupação a decisão individual de abertura de universidades sem se considerar a concorrência na região. Isso pode permitir que o mesmo grupo econômico abra várias universidades na mesma região e exerça um monopólio de fato nesta região. Então, entendemos que é muito importante se considerar a dinâmica do mercado.

Quanto à fixação ou não de médicos no local, também entendemos que isso é um teste que deve ser feito empiricamente, é um teste que pode ser feito simplesmente verificando, dos egressos da universidade, onde esses

egressos se encontram dois anos depois, e isso, Ministro, sugiro que possa ser feito até com a ajuda dos Conselhos Regionais de Medicina e do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, verificam-se os formados, os egressos das universidades, onde eles se situam no território nacional, comparam-se as universidades do interior com as universidades da capital, para que se verifique se, de fato, essa maior interiorização de universidades contribui efetivamente para a interiorização do médico, algo que entendemos deva ser avaliado empiricamente e não do ponto de vista retórico.

Então, partindo para a conclusão, do ponto de vista do Cade, vemos com preocupação uma barreira de entrada absoluta por anos. Contudo, entendemos que a abertura de cursos novos deve ser avaliada, considerando a qualidade desses cursos e os aspectos concorrenciais em cada região, não podendo ser simplesmente ser permitida a abertura de monopólios individualizados sem considerar a escala do mercado.

Então, agradeço enormemente pela oportunidade!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Já caminhando para o encerramento desta parte da audiência, eu faria dois questionamentos, um deles dirigido ao Doutor Cutait.

Os §§ 1º e 7º do art. 3º da Lei nº 12.871 estabelecem critérios mínimos a serem observados por municípios e instituições de ensino para instalação de novos cursos de Medicina em determinada localidade. O senhor entende que essas condições são suficientes para assegurar a qualidade dos cursos de Medicina?

O SENHOR RAUL CUTAIT (PROFESSOR, EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE) - A resposta, Ministro, é não. Não, porque é necessário definir com mais precisão o que se espera de um curso de Medicina. Nós estamos numa fase ainda preliminar a isso. Quais seriam os bons currículos? Como eles poderiam ser implementados? E como o mercado de trabalho pode absorver o que acontece lá?

Devo dizer que não se pode fazer uma análise pasteurizada das faculdades de Medicina. Então, tem faculdades como a minha, a do Professor Milton, que são faculdades que têm um espectro de ação muito mais amplo, com forte carga de pesquisa agregada. Tem faculdades de cidades menores, faculdades menores que formam médicos que vão atingir um determinado público e que não necessitam de grandes investimentos para grandes pesquisas. Então, é necessário que se avalie o que a faculdade naquela região pode agregar. A grande preocupação de novo é lançar no mercado gente que não está apta a exercer a Medicina, e, às vezes, um pequeno erro, uma pequena má avaliação, a falta de

exposição a determinadas situações, tanto emocionais, sentimentais quanto técnicas, pode levar a resultados ruins.

Então, a gente não pode perder essa perspectiva da qualidade do ensino que vai preparar o indivíduo a ser um bom médico no futuro.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado!

A outra pergunta eu poderia dirigir ao AGU, eventualmente ao Procurador-Geral da União.

Várias intervenções produzidas ao longo da manhã convergiram ao afirmar que haveria, no estado atual, um número excessivo de vagas. Convergência também se deu ao apontar que as liminares seriam a principal causa. Considerando que o próprio Ministério da Saúde compartilha dessa compreensão e que a Advocacia da União tem ciência desses provimentos, pergunto: por que não foi até hoje requerido um pedido de suspensão? O microssistema de contracautela, a Lei nº 8.437/92 e outras, como sabemos, abre a via processual em relação tanto ao STJ quanto ao Supremo a partir de decisão monocrática do relator do Tribunal.

O SENHOR BRUNO BIANCO (ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO) - Perfeito, Ministro, agradeço a sua pergunta.

Se o senhor me permite, logo mais, após o Doutor Marcelo, eu queria fazer uma abordagem bem rápida sobre isso. E, de fato, uma pergunta bastante pertinente, tanto que, de fato, eu acabo de fazê-la. Também já havíamos conversado sobre isso e é algo que nos preocupava também para que pudéssemos pautar a atuação da Advocacia-Geral da União nessas questões.

O que que vem ocorrendo, Ministro? Eu vou ser bastante simplório na análise jurídica, já que, aqui, eu acho que a nossa discussão é um pouco menos jurídica e até mais fática, mas, na prática, é o seguinte: como que nós vimos, como que nós enxergamos tudo isso, como que o Ministério da Educação e da Saúde enxergam tudo isso?

Na prática as decisões liminares, elas são igualmente simplórias, no sentido de dizer o seguinte: olha, avalie se pode ou não, ou se tem ou não a necessidade de abertura de um curso. Então, elas pedem para que os ministérios façam um escrivo e não determinam, de fato, a concessão ou o deferimento de um novo curso, o que é bastante diferente. E, entre aspas, até com todo respeito possível, óbvio, não podia ser diferente, é uma decisão muito mais simples e fácil para o magistrado nesse momento. Por que ele diz o seguinte: avalie.

E, na prática, o que nos preocupa é como se nós tivéssemos diante de uma obrigação de abertura de um processo licitatório para compra de

algum bem público sem que a União, sem que o Estado, tivesse a necessidade desse bem.

Então, imaginemos, por hipótese, para que sejamos bem simples, que haja uma decisão judicial obrigando a União a abrir um processo licitatório para compra de caneta Bic. E, na prática, nós não temos esse interesse. Então, não há nenhum tipo de abertura específica ou de necessária determinação para que o curso seja deferido.

Há, na prática, um processo que, liminarmente, se diz aos ministérios que apreciem essa questão.

Então, se entendeu que, na prática, que o ministério, até por cautela e por determinação ou deferência ao poder público, fizesse essa análise. E assim foi feito. Mas todos os recursos foram feitos, os agravos foram feitos, todos no prazo, e todas as decisões foram desafiadas pelos recursos respectivos, mas não se entendeu que seria o caso de suspensão das liminares, até porque as liminares eram para que nós pudéssemos fazer essa análise. E assim foi feito. Mas, o que se discute - e eu acho que essa audiência pública, pelo menos nessa manhã, foi muito efetiva - é que nós possamos ter meios efetivos para que a análise seja mais efetiva e para que nós possamos delimitar os campos de maneira como o Doutor Raul, agora, muito bem expressou, da necessidade e das cautelas necessárias para que

nós possamos fazer abertura de um curso de medicina, tendo em vista todas as questões que envolvem para além da própria abertura.

Acho que é isso, mas o Doutor Marcelo, passo a palavra, se o Senhor me permite, Ministro, para que ele diga, na prática, porque que não fizemos as suspensões.

Muito obrigado.

O SENHOR MARCELO MOURA DA CONCEIÇÃO (COORDENADOR-GERAL DE DIREITO SOCIAL, ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DA PGU) Bom dia! Acho que é, com certeza, o que o Ministro Bruno Bianco falou. É exatamente o nosso pensamento, a nossa estratégia. E a gente tem tido muito uma preocupação em todas as suspensões de liminares que são, como o Senhor falou, Ministro Gilmar, são medidas excepcionais de contracautela. E a gente provoca diretamente os presidentes dos tribunais superiores, e tem tido uma preocupação, sempre, de levar elas precisamente e objetivamente bem instruídas, apontando exatamente qual é aquela grave lesão que a gente tem presente. E o Ministro Bruno Bianco detalhou o nosso pensamento todo. Não é uma via fechada, mas acho que essa ADC também reforça um pouco essa preocupação, mas a nossa preocupação tem sempre sido sempre essa: chegar com esses pedidos quando existir, de fato, essa grave lesão, essa preocupação. E bem fundamentados, bem documentados.

Acho que era isso.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado.

Bem, acho que cumprimos o nosso roteiro da manhã e vamos continuar na parte da tarde, agradecendo a participação de todos. Essas contribuições estão registradas e, certamente, muito contribuirão para o processo decisório do Tribunal na ADI e na ADC.

Muito obrigado.

DIA 17/10/2022 – TARDE

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Boa tarde a todos. Declaramos reaberta esta audiência pública da Ação Declaratória 81 e da ADI 7.187.

Recomeçamos o trabalho agora com a exposição do Doutor Nésio Fernandes, Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).

O SENHOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS) - Boa tarde a todas, a todos!

Gostaria de cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes e todos os participantes desta audiência.

Destaco a importância do tema ao debater a constitucionalidade do art. 3º da Lei do Mais Médicos.

Eu sou Nésio Fernandes, Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, presido o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, sou médico sanitarista e vim contribuir com as posições do Conass e as provocações da nossa entidade a respeito do tema apresentado.

O tema é complexo, multifatorial, não é simples conseguir abordar com profundidade nos 10 minutos de tempo destinado. Então, por isso, utilizarei de frases sínteses, Ministro Gilmar Mendes. E, para cada frase síntese, existe toda uma produção que posteriormente pode ser subsidiada ao uso STF no que diz respeito às suas conclusões.

O dimensionamento da mão de obra médica no Brasil precisa ser entendido num país que tem um modelo de saúde misto, um país que tem um modelo de saúde público e privado, que tem um papel importante na saúde suplementar. Nós temos agendas que não foram ainda superadas, como, por exemplo, o provimento de médicos para o Brasil profundo.

E nós temos a conclusão de que, dentro do orçamento da saúde pública, Senhor Ministro, o orçamento público destinado à saúde pública no Brasil é insuficiente para incorporar a mão de obra médica já disponibilizada. Não existe orçamento público disponível no SUS para a eficiência do sistema e de modo que a gente consiga garantir a integralidade e [ininteligível] cuidado.

Nós vivemos num cenário onde há diversas concepções fiscalistas. A própria Emenda Constitucional nº 95 impôs um limite à capacidade de financiamento da União sobre os serviços de saúde. E isso impacta diretamente no tema, de como o sistema de saúde é capaz de absorver a mão de obra médica já formada e aquela que será formada no futuro.

E, de fato, existe uma pergunta: de quantos médicos o Brasil precisa? E a resposta não existe enquanto não se define o parâmetro. Nós precisamos escolher como país qual é o parâmetro que será adotado. O parâmetro do mercado e de corporações privadas pode ser influenciado por interesses de critério de reserva de mercado, de controle de preços de mensalidades, de controle do valor da hora médica.

Nós temos parâmetros internacionais definidos. A própria OMS define, em alguns documentos, 2,8 médicos por mil habitantes como valor de referência, em alguns documentos da Organização Mundial da Saúde.

O Banco Mundial projetou, para os 35 países-membros da OCDE, projetava em 2017, 3,8 médicos por mil habitantes. Considerando a tendência de crescimento da proporção de médicos em países da OCDE, nós, para este ano, teríamos uma projeção 4,4 médicos por mil habitantes.

O Brasil, o parâmetro adotado nacional, segundo o CFM, 2,8 médicos por mil habitantes aproximadamente; se considerarmos médicos com registros no CNES estaria próximo de 2,2, 2,3 médicos por mil habitantes.

E os parâmetros regionais impõem um desafio muito grande. Por quê? Porque os parâmetros regionais podem revelar que a média nacional não pode ser a medida mais adequada para dimensionar o real tamanho de necessidade da mão de obra médica do país. Nós temos desigualdades regionais. Dentro dessas mesmas regiões, entre as regiões metropolitanas e interior também na proporção que expressa bem diversas iniquidades e desigualdades.

E a opinião do Conass nesse assunto é de que cabe ao SUS a ordenação da formação de recursos humanos em respeito ao inciso III do art. 200 da Constituição, que é indissociável a formação, a opinião do Estado, a regulação do Estado sobre a formação médica pública e privada e que o SUS deve regular os dois e formar para os dois.

A ordenação do campo de prática é responsabilidade do Sistema de Saúde Público e a sua qualidade determina, em grande medida, a qualidade do perfil de competência do profissional formado.

É preciso entender que qualquer debate sobre a formação de graduação dissociada do debate da formação dos especialistas médicos é um debate insuficiente e parcial.

Nós temos que ter objetivos claros e adotar uma medida. Na medida que a gente entender que a razão, a proporção de médicos da OCDE seja aquela que a gente deva alcançar no Brasil, ou a proporção da média na América Latina, ou qualquer parâmetro internacional, a gente deve entender em quanto tempo nós teríamos essa proporção de médicos alcançada no Brasil com o atual quantitativo de médicos formados todos os anos.

Se nós adotarmos para o Brasil a projeção da OCDE para este ano, formando 32 mil médicos por ano, levaríamos até 2037 para ter, no Brasil, 4,4 médicos por mil habitantes. Se nós formarmos 50 mil médicos por ano no Brasil, levaríamos até 2031 para ter 4,4 médicos por mil habitantes, que é a média dos 35 países que compõem a OCDE.

No entanto, prover médicos para 770 municípios do Brasil que compõem aquilo que a gente chama Brasil profundo não depende de uma lógica

mecanicista de que basta ter excedente de médicos nas regiões metropolitanas que esses médicos excedentes automaticamente irão para o Brasil profundo. Isso não funciona assim.

Nós temos 770 municípios no Brasil que não conseguem fixar médicos com as estratégias de longo prazo, com as estratégias já adotadas no país. Desses, 269 municípios, nem com o Mais Médicos, nem com o Médicos pelo Brasil, conseguem alocar um médico generalista na atenção básica desses municípios.

Para resolver o problema do Brasil profundo, não é necessário alcançar os indicadores de formação de médicos que a OCDE tem. É necessária uma decisão de política de Estado e, com os atuais médicos já existentes no Brasil, com estratégias já adotadas, é possível prover, via medidas de serviço militar obrigatório, serviço civil obrigatório, via estratégias que o próprio Mais Médicos adotou com a cooperação com a Opas e com registros temporários para médicos formados no exterior atuarem em algumas regiões remotas. São estratégias que já foram adotadas em países centrais, como Portugal, como Austrália, para poder prover profissionais a áreas de muito difícil fixação.

Nós não precisamos volver o debate da quantidade de formação de médicos no Brasil, nem do número de escolas médicas ao debate de prover para uma relação de 770 municípios em que nós já sabemos que faltam médicos. Existem

estratégias para hoje, para o ano que vem, que podem ser adotadas para poder levar profissionais a esses municípios.

Nós estamos ofertando 24 mil vagas de residências médicas por ano no país, formando mais de 32 mil médicos/ano também. A desigualdade da formação, da oferta de residência, da oferta de graduação é um problema também para a saúde pública e para o dimensionamento de médicos no país.

Nós entendemos, como entidade, como Conass, que uma diretriz que trouxe a Lei do Mais Médicos deveria ter sido perseguida com maior disciplina e vontade política por parte da União no sentido de que a quantidade de ofertas de vagas de residências médicas deve se constituir em uma das referências para a regulação da quantidade de cursos de graduação e de vagas que se ofertam no país. Se enchermos o mercado de trabalho com profissionais generalistas, sem o devido perfil de competência, sem a devida titulação, nós trazemos um problema adicional a outros problemas que já existem para a saúde pública resolver.

Nós reafirmamos: o Brasil, de fato, precisa de mais médicos e, principalmente, de mais médicos especialistas, mas a quantidade total de médicos, por si só, não altera a realidade epidemiológica. A intervenção de saúde pública capaz de alterar os indicadores epidemiológicos está relacionada à capacidade do sistema de saúde de incorporar os médicos disponíveis e de ofertar universalmente serviços médicos capazes de garantir a integralidade do cuidado.

Nesse sentido, nós entendemos que o art. 3º da Lei do Mais Médicos traz elementos suficientes para reconhecer mais do que a sua constitucionalidade, mas, como, de fato, há necessidade de reafirmar que o Estado deve regular a formação em saúde no Brasil e que nós precisamos fazer opções, que, enquanto o Brasil não tiver opções claras definidas e estabelecidas em políticas nacionais por meio de entendimentos e pactuações, nós vamos levar toda a discussão da formação médica ao banco do sistema judiciário, ao banco das disputas políticas, ao banco do debate no Parlamento sem a conclusão de uma política nacional clara. Por isso, nós entendemos, como entidade, que o art. 3º da Lei do Mais Médicos deve ser reconhecido como constitucional e que compete, sim, ao Poder Público, especialmente à União, a regulação da formação médica no nosso país.

Então, muito obrigado, Ministro! Era essa a contribuição.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado, Doutor Nésio!

Em seguida, ouviremos o Doutor Jeancarlo Cavalcante, do Conselho Federal de Medicina.

O SENHOR JEANCARLO FERNANDES CAVALCANTE (VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA) - Gostaria de

saudar Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, em nome de quem saúdo todas as autoridades da mesa. Saúdo os colegas palestrantes, Senhores e Senhoras.

Imaginemos que alguém resolva abrir um curso de nível superior no Brasil. Ele precisa acessar o sistema eletrônico do MEC, conhecido como e-MEC. Ali, ele vai colocar toda a documentação, tudo que é necessário para que se abra um curso de nível superior no Brasil. Tudo totalmente *on-line*, sem necessidade de papéis.

Acontece que, em outubro de 2013, esse ato de abrir um curso de nível superior foi excepcionalizado. Criou-se uma exceção a partir da promulgação da Lei nº 12.871, que, em seu art. 3º, como é de domínio público, estabelecia chamamento público para que se abra um curso de Medicina em uma universidade privada.

Esse chamamento, que fazia as vezes de licitação, embora não o seja, estabelece a região onde se deve abrir o curso de Medicina e quais pré-requisitos o curso deverá atender para ser aberto. Tudo isso em um cenário brasileiro com mais de 270 escolas médicas, sendo que dois terços dessas escolas são particulares, e 97% por cento desses cursos foram criados a partir de 2001. Mais de 200 escolas desse universo estão localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Santa Catarina. Oitenta por cento dessas escolas não atenderiam os requisitos mínimos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 12.871.

E por que isso ocorreu, Senhores? Porque tínhamos um problema: a saúde brasileira sofria cronicamente de carência de médicos, equipes e estrutura, principalmente nas áreas de difícil acesso. Diante desse problema, qual foi a estratégia adotada naquela ocasião? Ampliar o número de escolas médicas e de vagas nos cursos de Medicina. Tínhamos o problema, tínhamos uma estratégia. Qual foi o resultado dessa estratégia?

Como esperado, a estratégia não surtiu efeito. Tivemos queda na qualidade da formação médica e aumento na disparidade de densidade médica entre as regiões e as cidades. Isso é muito importante, porque um profissional qualquer, um contador, um advogado, seja qual for, pode arruinar a vida de uma pessoa patrimonialmente, cível e criminalmente, mas um médico, quando erra, acaba com a vida.

Isso é muito fácil de verificar na nossa prática. Basta que um médico mal formado não faça uma dosagem de insulina adequada ou não saiba entubar o paciente em um momento crucial e a luz se apaga, a vida se esvai. Aí está o preço do médico mal formado.

Tudo isso levou à ADI 7.187, que busca a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871, a Lei do Mais Médicos. Não temos falta de médicos. O Brasil hoje tem 2,51 médicos por mil habitantes, 536 mil médicos inscritos no

Conselho Federal de Medicina e, mesmo assim, querem abrir mais escolas médicas, como se a liberdade econômica fosse um direito absoluto.

O Ministro Gilmar Mendes já nos ensinou, em seu livro *Curso de Direito Constitucional* - livro esse que ele escreveu com o Professor Paulo Gustavo - : não há, em princípio, que se falar em direitos absolutos. Tanto outros direitos fundamentais quanto outros valores com sede constitucional podem limitá-los.

A livre iniciativa não é um princípio absoluto. Em dadas circunstâncias, ela se irá chocar com outros direitos, com outros princípios constitucionais de maior ou igual envergadura, até mesmo porque o parágrafo único do art. 170 da Constituição apresenta uma ressalva à questão absoluta da livre iniciativa:

> "Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

Na nossa análise clínico-jurídica, se é que posso falar assim, já que não sou operador do Direito, a constitucionalidade do art. 3º dessa lei salta aos olhos. Não importa ao CFM se os *players* dessa ADC e dessa ADI são gigantes da educação privada, com pensamentos e interesse diversos. O CFM é a maior instituição reguladora de Medicina do mundo. É bem verdade que a Índia tem mais médicos, os Estados Unidos e a China têm mais médicos, mas nenhum deles tem uma colegiatura única, nacional, como o Conselho Federal de Medicina, com mais de meio milhão de médicos com inscrição compulsória em seu órgão regulador.

Efetivamente, o Conselho Federal de Medicina é hoje a maior instituição regulatória do mundo. Para esta instituição, o que importa é que o legislador, ao escrever a lei, procure proteger a sociedade de profissionais mal formados.

Existem hoje mais de cem pedidos de liminares para abertura de escolas médicas que não atendem aos preceitos da Lei nº 12.871. É obvio que nunca teremos uma homogeneidade das escolas médicas. Nunca teremos escolas médicas com o mesmo nível de formação, mas me permito usar a metáfora do avião. Os passageiros viajam de primeira classe, de executiva e de econômica. O importante é que todos cheguem a seu destino de maneira segura, não importando em que classe viajem. Da mesma forma, a educação médica, a formação médica, tem que ter um critério mínimo. Não diria um mínimo existencial, mas é como se fosse à semelhança do mínimo existencial, para que tenhamos bons profissionais e a sociedade brasileira se possa beneficiar dessa formação.

O CFM espera que a constitucionalidade dessa lei seja concedida, porque a sociedade precisa de bons profissionais. Não podemos ofertar maus profissionais.

Lembrem-se: médico cuida da vida. Basta uma dosagem errada, basta uma não intubação, e tudo estará acabado.

Para concluir, existe um velho brocardo da Medicina que diz que o médico deve curar sempre que possível; aliviar, sempre. Eu diria que precisamos não fazer maleficência à sociedade brasileira, porque todos nós, eu, como professor universitário, vocês, como pessoas que trabalham com a educação médica, temos a responsabilidade de entregar à sociedade brasileira médicos bem formados. E não conseguiremos isso com essa proliferação indiscriminada de escolas médicas. Atentemos à qualidade para que possamos não chorar no futuro coisas brutais como o que ocorre com esses médicos mal formados que atendem a população.

Muito obrigado, Senhores!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Jeancarlo Cavalcante!

Agora vamos ouvir a Professora Doutora Ludhmila Abrahão Hajjar.

A SENHORA LUDHMILA ABRAHÃO HAJJAR (PROFESSORA E DOUTORA) - Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando Vossa Excelência, Senhor Ministro Gilmar Mendes, em nome de quem cumprimento as demais autoridades da mesa, Senhoras e Senhores aqui presentes.

É uma honra muito grande para uma médica formada em escola pública, que teve a sua vida toda baseada no ensino de grandes escolas. Eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Brasília, aqui em Brasília, quando fiz minha graduação; a partir dos anos 2000, fui para a Universidade de São Paulo, onde fiz as minhas residências de clínica médica, de cardiologia; titulei-me também em terapia intensiva e emergência, e, durante esses anos, fiz o meu doutorado, a minha livre-docência e tive acesso a grandes universidades, o que aumentou a minha responsabilidade como médica, como professora e me deu essa imensa honra e oportunidade de estar aqui hoje, discutindo um tema tão relevante para a sociedade brasileira.

Gostaria de cumprimentar o Ministro por tornar pública essa discussão e por ouvir as pessoas que estão reconhecendo, nos últimos anos, o nosso sofrimento com a redução da qualificação do profissional médico. Existem inúmeros fatores e, nos próximos minutos, tentarei discorrer um pouco, especialmente focada em quem é o médico brasileiro, qual é a situação das escolas. Não é tão simples assim. Ora abrimos muito, ora declara-se a moratória; mas o que aconteceu nesses dois períodos de uma abertura maior, depois o período de moratória e de judicialização? Quais foram os resultados desse período? Isso é fundamental, antes de fazermos uma análise mais aprofundada e entendermos qual o caminho o Brasil seguirá.

Então, nos próximos minutos, falarei um pouco da racionalização, da contextualização dessa temática; qual é o retrato, a demografia do médico brasileiro; o que nós temos de escolas médicas no Brasil; se nós sofremos, ou não, o impacto da pandemia e se essa é uma discussão relevante nesse ponto; e que propostas tenho, diante de todos os questionamentos aqui levantados na ADC, na ADI e nessa oportunidade que o Supremo Tribunal Federal nos dá em ouvir.

O objetivo dessa audiência pública é discutir a constitucionalidade de uma política pública instituída em 2013. Ela visa ao aperfeiçoamento da educação médica no Brasil e abre a oportunidade - essa audiência - para que possamos discutir sobre a formação médica e abertura de novas faculdades de Medicina.

Nós temos desafios a serem enfrentados, precisamos entender qual é a real oferta de médicos no Brasil, como isso tem evoluído e qual é a distribuição. Temos falado muito em heterogeneidade, mas qual é a possível resolução, ou solução viável, para isso nos próximos anos? Quais recursos precisamos realmente para ter uma graduação em Medicina de qualidade, que proteja a nossa população? Qual é o impacto dessa política pública estruturada em 2013?

Naquela ocasião, essa política pública tinha alguns objetivos. Dentre eles, ela aumentou o número de vagas, ampliou o número de escolas, mas também elevou o número de médicos vindouros de países externos.

O Brasil vivia um momento epidemiológico. Eu não posso pegar a realidade de 2013 e transpor, *sine qua non,* em 2022. A medicina é uma ciência de verdades transitórias, muda de acordo com a epidemiologia, com a geografia, com a demografia. Algumas décadas atrás, nós discutíamos, no Brasil, mortes por causas materno-infantis, traumas e infecções. Hoje, os nossos grandes desafios são as doenças crônicas: as doenças cardiovasculares, o câncer, as doenças neurovasculares.

Então, o sistema de saúde e o sistema educacional têm de ter a flexibilidade para se adequar de acordo com as respostas dadas pela ciência, de acordo com as modificações epidemiológicas. Nós não imaginávamos viver uma pandemia, e a gora temos de nos adequar às consequências dela.

Como médica, cientista e professora, acho muito difícil simplesmente voltar a algo definido em 2013 e dizer "eu tenho que garantir como era". Não, a realidade mudou! Eu falo hoje de um outro paciente. Eu posso até chamar o Brasil de paciente, quando eu vejo que a saúde e a educação vão mal, mas oportunidades como essa me fazem acreditar que podemos mudar esse cenário.

A saúde e a educação são direitos constitucionais, e precisamos assegurá-las para a população de maneira universal, igual, integral e de qualidade, e temos que lutar para reduzir as desigualdades.

E, quando falamos em qualificação do médico, é algo completamente distinto do simples número de vagas, da simples proporção. Qualidade não é quantidade. Isso é princípio básico. É semântico. Eu não posso dizer "tenho muitas escolas"; para melhorar a formação do médico, vamos impedir abertura de novas. Não faz o menor sentido!

Realmente, precisamos tomar uma atitude, no que se refere à qualidade dos cursos médicos a serem abertos, a revisão de qualificação de quem é o produto que a graduação médica está colocando na sociedade.

O objetivo de uma instituição de ensino superior é formar um produto com capacidade crítica e que vá servir a sociedade. O médico brasileiro que nós estamos formando hoje, de uma maneira geral, é um produto que a sociedade brasileira se beneficia? E o que podemos fazer diante deste cenário para melhorar? Quem é o médico brasileiro?

Então, sabemos, temos mais de 500 mil médicos. A maior parte desses médicos ou não tem título, ou tem apenas um título. Então, vejam bem, de 523 mil médicos, 204.280 não tem nenhum título de especialista. O título de

especialista qualifica um médico, ele treina no ambiente prático, ele faz com que possamos estar capacitados para atender às demandas da população.

Será que tem a ver com número de cursos o fato de quase a metade de nossos médicos não terem título de especialista? Ou temos que nos aprofundar, realmente, na problemática, nas reformas estruturantes que a educação e a saúde realmente precisam ter?

Sabemos que, nos últimos anos, a proporção de médicos cresceu dissociada do crescimento da população. Isso é fato!

Podemos ver que, em 1970, tínhamos 42.718 médicos e uma população em torno de 71 milhões de brasileiros. Quando vamos para 2020, o número de 42 mil médicos passa para 500 mil (esse aumento é de 11,7 vezes, mais de 1.000%), e o aumento da população é de 2,2 vezes.

Então, aumentou, proporcionalmente, o número de médicos em relação ao crescimento populacional. Isso é um demérito? Ou foi uma necessidade?

Em 2013, nós podemos ver que há um salto. Era um momento epidemiológico no qual era necessário. Portanto, houve uma ampliação do número de vagas. E, de lá para cá, esse número continua crescendo.

Quando olhamos nesta figura, nesta análise, podemos observar que, de uma maneira geral, o número de médicos cresce, gerando uma proporção em torno de 2,38 médicos para cada mil habitantes.

Qual é o número adequado? Existe um número?

A OCDE, a qual todos os senhores conhecem, é uma cooperação internacional de 37 países, que visa discutir os problemas e tentar impor soluções. A OCDE acha determinante que não haja um número, porque isso é individualizado, depende do país, depende da necessidade circunstancial, temporal, relacionada com a epidemiologia. Não há um número. Um número ideal é 4? É 3,5? 2,38 é muito? Nós não podemos afirmar. Quando olhamos por que esse número cresceu nos últimos anos, então vamos entender um pouco.

Em 2013, o Programa Mais Médicos procurou obter a reordenação da oferta dos cursos de Medicina, tentando, com os cursos de Medicina, diminuir uma heterogeneidade, porque o médico profissional de saúde procura a Região Sudeste, a Região Centro-Oeste, a Região Sul, em detrimento das Regiões Norte e Nordeste. Por quê? Muito pela estrutura, muito pela condição de trabalho, muito pela remuneração.

Entretanto, a visão e a interpretação daquele momento fizeram com que, no Programa Mais Médicos, buscassem-se editais, chamamentos públicos, de cursos de graduação para tentar povoar essas regiões com a menor proporção de médicos por 1.000 habitantes. Só que isso não funcionou porque o aluno não fica onde ele faz graduação. Menos de 30% dos alunos ficam onde eles

fazem graduação. Ele vai buscar uma residência mais qualificada, ele vai buscar condições de trabalho.

Então, essa iniquidade, essa heterogeneidade de Regiões Norte Nordeste, quando nós comparamos com as outras regiões, existe em quase todos os aspectos do Brasil: em educação, em saúde pública, em condição de saneamento. E não poderia ser diferente com a procura e com a permanência do médico nessas regiões. Não é abrindo edital de chamamento para o Norte que eu vou garantir assistência médica qualificada.

Ao mesmo tempo, o Programa Mais Médicos procurou dar ênfase ao aperfeiçoamento de médicos na saúde primária, inclusive por meio de intercâmbio internacional. A gente sabe que nós tivemos uma entrada no país de mais de 1.000 médicos provenientes de Cuba. Foi uma necessidade do momento.

E, também, a deliberação de 2013 era que a liberação, a aprovação para abertura de novos cursos de medicina estivesse condicionada a um chamamento público, especialmente por conta deste chamado de atender a regionalização.

Então, em 5 de abril de 2018, no Governo do Presidente Michel Temer, sendo o Ministro da Educação Mendonça Barros, determinou-se, por cinco anos, a suspensão dos cursos de Medicina, valendo então a partir de 5 de abril de 2018. E qual era a justificativa para que fosse suspensa abertura de novos cursos e

de novas vagas para médicos? A justificativa era que era o momento de interromper abertura de novos cursos para que se avaliasse e se adequasse a formação médica. E, aí, o que aconteceu nesse período? Onde estão os resultados da adequação da formação médica? Não temos! Provavelmente porque as deliberações em relação à saúde e educação não são, hoje, reconhecidas como política de Estado. Os governos mudam, e as ideias ficam para trás.

Então, nós não sabemos se a interrupção da abertura de novos cursos resultou em uma análise aprofundada e uma revisão da qualificação. Nós não temos esses dados. Não é isso que nós vimos. O que nós vimos é o que essa figura mostra: uma desproporção que nós já sabíamos que existia. E mesmo com a moratória definida em 2018, a desproporção continuou.

Então, impedimos abertura de novos cursos de Medicina, entretanto continuamos vendo uma concentração maior de médicos nas regiões com maior poder aquisitivo, com um número maior de habitantes, como é o caso de Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

E quando olhamos os dados da OCDE, no primeiro gráfico, o número de médicos por 1.000 habitantes; no segundo, número de médicos por 10.000 habitantes. Então, nós ainda vimos que o Brasil, em termos de média da OCDE, está muito inferior.

Então, eu não posso aqui mostrar, baseado em número, ou defender que o nosso número de médicos está além, e que fechar ou impedir abertura de novas escolas seria uma solução para a qualificação dos médicos e para atender melhor a população.

Nós entendemos também que há processo de um aumento do número de mulheres cursando medicina. Então, esse é um fato, a gente precisa conhecer a demografia, quem é o médico brasileiro. Nós vimos, nos últimos anos, um aumento da procura e da entrada nos cursos de medicina de pessoas do sexo feminino. Como vemos, hoje, que a maior parte dos médicos brasileiros se encontram entre os 25 e os 50 anos de idade.

Portanto, se nós pudermos observar esse gráfico, nos últimos anos, vemos a crescente progressiva entrada de mais mulheres no curso médico. Nós podemos observar que a mediana de idade das mulheres é menor do que dos homens. A mediana, ou seja, a maior parte dos homens médicos no Brasil está em torno de 45 anos; e as mulheres, em torno de 35 anos.

E onde é que estão essas escolas médicas e essas novas vagas? Muito mais nas capitais do que no interior. Ou seja, a moratória não reduziu os problemas.

É claro, houve judicialização, nós estamos discutindo isso, nós devemos evitar isso, porque nós estamos procurando nos aprofundar nos temas

para que a gente tenha critérios bem estabelecidos, para que a gente evite que haja um fura-fila, uma transformação da medicina em um balcão de negócios.

Entretanto, a gente tem que olhar com muita cautela.

Veja o que acontece. Onde o médico está? Em municípios mais populosos, que são mais ricos, que têm mais estrutura, que têm melhores salários. Então, esse é um ponto a ser discutido com profundidade. O que nós vamos fazer para tentar diminuir esta iniquidade?

Nós também podemos observar que, nos últimos anos, há um aumento do número de especialistas se compararmos com o de médicos generalistas, quando devemos enfocar na saúde primária, na prevenção. Então, nós também deveremos atuar nesse aspecto. Hoje, existe um crescente número de especialistas, quando nós comparamos com médicos generalistas.

E quando nós olhamos a quantidade de escolas médicas - hoje nós temos 357 escolas médicas -, a maior parte está concentrada nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e a maior parte delas é privada.

E nós podemos observar que, depois de 2013, esse aumento do número de alunos formando em medicina, por ano, ele é exponencial, chegando a quase 32 mil, em 2020, data de última análise desse estudo que foi realizado entre o Ministério e a Universidade de São Paulo.

Nós temos aqui o número progressivamente elevado da abertura de curso de medicina e de novas vagas. E nós também podemos observar que esse aumento, especialmente nos últimos 10 anos, é predominante de escolas privadas, e não de públicas.

E a qualidade do médico? O que nós fizemos para melhorar a qualidade do médico? A gente tem que dar um passo atrás e discutir o que que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do médico e para avaliar esse produto que vai para servir a nossa sociedade.

Primeiro aspecto, o aluno tem que ser avaliado.

O segundo aspecto é que a instituição, a faculdade de medicina, também tem que ser avaliada quanto a sua estrutura, se ela tem laboratórios, consultórios, bibliotecas, acervo, produção científica, se ela tem hospital, se esse hospital tem bons desfechos, se a mortalidade é abaixo da mortalidade média de hospitais e instituições semelhantes, se tem uma residência. Isso é fundamental, isso qualifica a formação do graduando médico.

Então, precisamos priorizar a abertura de escolas que tenham hospitais e que tenham programas de residência. Idealmente, que tenham pós-graduação *stricto sensu*. E nós vamos qualificar.

O mais importante é que a gente consiga avaliar a escola e o aluno, também passando por uma avaliação das diretrizes curriculares, de como é

a formação médica. Ela é humanística? Ela é dentro dos princípios éticos? Essa instituição proponente confere adequação e qualidade das atividades assistenciais de ensino, pesquisa e inovação? Qual que é a qualidade desse produto formado? Quais são as taxas de aprovação nos cursos de residência? Como é que o Brasil não vai ver o que aconteceu com determinada escola médica nos últimos quatro anos, que quase ninguém foi aprovado nas provas de residência? Essa escola médica tem autorização para continuar formando esse médico? Qual que é o papel social? Existem acordos, colaboração? Como é que a instituição privada pode ajudar a instituição pública?

É importante que o aluno de Medicina esteja permeando entre instituições públicas e privadas, essa é a realidade do médico brasileiro. Nesse estudo de demografia, o médico brasileiro tem, em média, três a quatro empregos. É utópico imaginar que um médico brasileiro trabalhe em uma única instituição. Então, conhecer as duas realidades é fundamental. Acordos e parcerias bem elaborados, com ganhos bilaterais, são fundamentais para o crescimento da saúde, da tecnologia e da ciência no Brasil.

Nós podemos fazer isso por meio de instituição de comissões de acreditação, assim como da instituição de uma comissão de avaliação periódica, com auditoria e sujeita a penalidades.

E eu chamo a atenção para o exemplo da pós-graduação no Brasil.

A CAPES, após as avaliações, que inicialmente eram trienais e agora são quadrienais, ela avalia, com critérios rígidos, com uma comissão sem conflito de interesse, com professores altamente qualificados. São quase 3 mil cursos de pós-graduação a cada quatro anos! Por que nós não vamos conseguir avaliar 357 escolas médicas? Essa avaliação da CAPES é fundamental. Eu sou coordenadora do curso de Pós-Graduação de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, nós crescemos com a avaliação da CAPES, nós buscamos melhorar não para obter a nota, mas para obter o certificado de excelência, porque isso é o que uma universidade procura.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Doutora Ludhmila, eu queria pedir que encaminhasse para o encerramento. Nós todos estamos ouvindo com muito encantamento, mas eu tenho inclusive perguntas para lhe fazer em seguida, mas pediria que...

A SENHORA DOUTORA LUDHMILA ABRAHÃO HAJJAR (PROFESSORA) - Terminando, Ministro. Obrigada e desculpa.

Por fim, nós temos uma prova denominada Enade, que ela não é obrigatória, ela é aleatória, mas eu trago aqui os resultados, mostrando qual é a qualidade desse médico. É uma avaliação ainda muito pequena diante das

necessidades de avaliação, mas as notas, como podemos ver, das instituições públicas são melhores do que das instituições privadas, mas o número de médicos avaliados é muito pouco. A residência, como já falei, é um item importantíssimo. Nós temos em torno de 15 a 20 mil residentes de R1, R2, R3, a cada ano, dentre uma proporção de 31 mil médicos ou novas vagas por ano.

Nós vimos, nos últimos anos, o aumento do número de processos por erro médico e estamos vivendo uma evolução da medicina, que ela transcende o número de vagas. A velocidade do conhecimento cresce em proporções geométricas. Nós deveremos fazer adaptações temporais e regionais, nós temos que investir em tecnologia e inovação, temos que focar em saúde primária, na formação humanística deste médico e este médico tem que entregar ao seu paciente a medicina baseada em evidências, que é pautada na melhor evidência dentro do processo científico de análise crítica, além do julgamento clínico, respeitando os valores e as preferências dos pacientes.

Em conclusão, as minhas propostas, diante desse cenário, são: estabelecer critérios rígidos para a avaliação da abertura de novas faculdades de medicina, por meio da instituição de uma comissão qualificada sem conflitos de interesse, sem a necessidade de chamamento público, mas que agisse em forma contínua, em torno de 120 dias para uma avaliação e uma resposta; eu daria prioridade para instituições que tenham hospitais-escolas e programas de

residência; faria uma avaliação institucional a cada quatro anos e uma prova no segundo, quarto e no sexto ano.

Para terminar, eu menciono os princípios que Willian Osler colocou na nossa prática médica desde o século XIX. Ele já mencionava que uma das razões de introduzir uma rotina de passagem de visita nas enfermarias era a forma frouxa e desleixada de conduzir escolas de Medicina. E nos ensinou que a prática da Medicina é uma arte, não é um comércio; é um chamado, e não um negócio; é um chamado no qual o seu coração será exercido igualmente com a cabeça. O bom médico trata doença; o grande médico trata o paciente que tem a doença; e a Medicina é aprendida à beira do leito, não nos anfiteatros.

A gente precisa de estrutura e qualidade.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado pela belíssima exposição! Mas eu tenho ainda, como lhe disse, indagações que vou formular.

Agora vamos ouvir a Doutora Lúcia Braga, Presidente da Rede Sarah.

A SENHORA LÚCIA WILLADINO BRAGA (REDE SARAH DE HOSPITAIS) - Boa tarde!

Senti-me muito honrada ao ser convidada para participar desta audiência pública. Inicialmente, gostaria de agradecer a Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes, por esta oportunidade única.

Estou aqui como representante da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, que é composta por nove hospitais em oito unidades da federação: Brasília, Belo Horizonte, São Luís, Salvador, Fortaleza, Belém, Macapá e Rio de Janeiro. Atendemos a um milhão e oitocentas mil pessoas por ano, com qualidade, excelência, evidências, ética e humanismo. Para a nossa instituição, a qualificação e a distribuição geográfica dos médicos são temas fundamentais. Precisamos de profissionais altamente qualificados, prontos para trabalhar em equipe interdisciplinar em diferentes regiões do Brasil.

Para o Sarah Macapá e o Sarah Belém, inaugurados respectivamente em 2005 e 2007, até hoje, é difícil captar e fixar médicos.

A questão da distribuição geográfica de cursos e profissionais é fundamental para a garantia do acesso da população aos serviços de saúde. Temos aproximadamente 2,38 médicos para cada mil habitantes, variando de 5,73 do Distrito Federal a 1,22 apenas no Pará. A distribuição é desigual. Nossa taxa de médicos por habitante é igual à do Japão, México, Polônia e muito perto do que dispõem os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.

Das 357 escolas de Medicina disponíveis no Brasil, mais da metade surgiu no período de 2000 a 2019, abrindo, anualmente, mais de 36 mil novas vagas. Estamos vivendo um crescimento vertiginoso de cursos de Medicina no país. O Brasil forma hoje, em média, 10,4 médicos para cada 100 mil habitantes, número maior do que a França, os Estados Unidos, o Canadá e o Japão. Precisamos ter parâmetros claros e auditáveis sobre a qualidade desses cursos. Qual é o nível dos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho voltado à saúde e à vida humana? Isso é muito sério!

Os resultados do exame do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo nos últimos anos mostram altos índices de reprovação. Esse exame é composto por questões fáceis, medianas em sua maioria. Em 2018, apenas 53,5% dos alunos da rede privada foram aprovados no exame do Cremesp. No momento, precisamos qualificar os cursos e ter uma distribuição de escolas e de médicos mais igualitária no território nacional.

A saúde de qualidade para a nossa população não depende apenas de um grande número de profissionais formados em Medicina. Precisamos de profissionais de saúde que trabalhem de forma interdisciplinar e integrada no atendimento à população. Precisamos de enfermeiros, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, de psicólogos, de nutricionistas, de fonoaudiólogos, de

professores hospitalares, de farmacêuticos, de biólogos, de bioquímicos, de assistentes sociais, de biomédicos, além dos técnicos de enfermagem, de patologia, de radiologia, de neurofisiologia, entre tantos outros. Precisamos de bons gestores que trabalhem com gestão de pessoas, otimizando a força de trabalho e incentivando a interdisciplinaridade, gestão de cadeias de suprimentos, fundamental a todo o sistema de saúde. Não pode faltar medicamento, mas também não pode haver perda de validade.

Precisamos integrar mais a tecnologia da informação à prestação de serviços de saúde. Hoje há tendência à digitalização dos postos, UPAs e hospitais, permitindo transparência, governança, *compliance* e controle, que é o que o país mais necessita. Bons médicos precisam estar integrados a todo esse sistema, visando aprimorá-lo.

O médico é integrante da equipe que cuida do diagnóstico, do tratamento médico, de exames, cirurgias, além de exercer inúmeras outras funções relacionadas à saúde da população. Precisa ser um profissional de formação sólida tanto do ponto de vista técnico-científico quanto humanista.

Em função disso, concordamos que a autorização para a abertura de cursos de graduação em Medicina deve seguir processo de chamamento público, além dos critérios de qualidade definidos e detalhados no § 7º do art. 3º: infraestrutura adequada, acesso dos alunos a serviços de saúde

habilitados, de qualidade, com a exigência de titulação, qualificação e metas para o corpo docente, que deve atuar em regime de tempo integral.

Pelas razões elencadas, acreditamos que o art. 3º da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, é fundamental para assegurar a distribuição geográfica e a qualidade da formação de nossos médicos, visando à melhoria dos serviços de saúde do Brasil. Realmente, advogamos pela constitucionalidade da lei e acreditamos que ela é uma base mínima para que a gente desenvolva uma saúde de qualidade para a nossa população.

Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de participar deste debate democrático, coordenado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, para a discussão de um tema tão relevante no nosso Brasil. Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigada, Doutora Lúcia!

Agora, passamos a ouvir o Doutor Angelo Vattimo, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

O SENHOR ANGELO VATTIMO (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO) - Inicialmente, cumprimento o Excelentíssimo Ministro e agradeço a oportunidade, em meu nome e em nome da nossa Presidente, Irene Abramovich.

Vou falar de maneira um pouco diferente da que os que me antecederam, mas, no fim, praticamente endosso tudo o que foi falado. Vou falar para os senhores na nossa ótica de Conselho de Medicina.

O que é um médico que não tem formação adequada? Isso se expressa nos processos éticos, expressa-se nos processos judiciais. Porém, nós, como médicos, quando compulsamos os autos, para nós, já salta aos olhos que aquilo poderia ser evitado se quem está envolvido tivesse uma melhor formação. Senhores, não há dolo em questões - não gosto da palavra - de erro médico, digamos, uma prática. Não há dolo. Erra-se por imperícia, uma série de situações, mas que não canalizam só - como querem muitos colocar - para a infraestrutura, sempre a estrutura não era adequada. A estrutura humana vem antes, a qualificação humana se sobrepõe - e se deve sobrepor -, muitas vezes, aos problemas de infraestrutura.

Temos mais escolas, acho, no mundo, menos só que a Índia. Em São Paulo, nem trouxe números, porque se abrem a cada momento. Não bastasse isso - não é só a questão de abrirem, outros *campi* são abertos -, há vários *campi* que pertencem à mesma faculdade. As vagas se vão multiplicando e a estrutura é a mesma.

Principalmente quando se esbarra na parte prática, a gente vê alunos em UBS, em Upas, jogados à mercê da rede assistencialista, não de uma rede

docente. Muitas vezes, a gente vê que, no papel, há os titulares das cadeiras, mas muitos apenas dão os nomes, geralmente não atuam. Isso é comum.

E o que esperamos? O que sai daí? Os senhores acham que vai sair um médico bem formado? Não vai. É um sistema muito cruel. Também sou radicalmente contra investir em infraestrutura onde a qualidade humana não é adequada, porque o médico mal formado onera o sistema, não só o público, mas também o privado. Ele onera.

Vou dar alguns exemplos rápidos e práticos da minha área. O doente chega com dor abdominal e começam a pedir "n" exames - não conseguem interpretar os exames -, "n" avaliações. O doente é operado depois de três ou quatro dias com apendicite, já em fase complicada. Fica na UTI quinze dias, às vezes, morre. Isso custa, quer dizer, a sociedade paga com a vida e o Estado, o erário, paga para manter isso. Claro que a questão não é tão simples assim. Com médicos bem formados acontece? Acontece, mas com o médico mal formado, sem dúvida, acontecerá. Isso não tenho a menor dúvida.

Também se questiona muito o método, que se pretende retornar, de avaliação das faculdades com exame final. O exame final é um mero exame. Medicina não é Direito, em que o advogado presta OAB. Aliás, desculpem-nos os advogados, há advogado que passa na OAB e não consegue fazer uma petição.

Muitos médicos vão poder até passar, mas será que eles estão preparados só porque passaram no exame?

E se não passarem, o que vamos fazer com eles? O Estado permitiu que eles estudassem lá. O Estado permitiu que aquela escola existisse. Como vamos resolver se eles não passarem? Eles vão pegar seis anos, um investimento de oitocentos mil reais, e jogar no lixo? Ou vão fazer a faculdade de novo? O que vamos fazer?

O exame vai ser a solução? Na nossa ótica não, porque existem cursinhos, depois, faz-se um cursinho. Ele vai poder prestar quantas vezes o exame? Temos que, como a Professora Ludmila já falou, fazer uma auditoria, vamos ter que rever essas faculdades.

A lei existe. O problema é que há subterfúgios e não é fiscalizada. Não alimento nenhuma esperança de que as faculdades que não se enquadram vão ser fechadas, acho até muito difícil que isso ocorra. Vamos ser práticos e realistas. O que podemos fazer é auditá-las e as que não oferecerem as condições não têm mais vestibular. Não vamos aumentar o número de novos alunos até elas se enquadrarem. Acho que é uma solução viável, a gente consegue mitigar um pouco isso. Não é a solução total, mas não podemos permitir que essa situação se perpetue.

Para finalizar, também temos que entender que, no Brasil, nossa lei permite que o médico, após se graduar e se registrar, atue sem ser especialista em qualquer área. Agora, os senhores imaginem, mesmo o médico bem formado não está apto a exercer na sua totalidade a Medicina. Imaginem o médico que não teve uma formação adequada!

Nos Estados Unidos, você não atua se você não tiver especialidade. Se não tiver, vai para pesquisa, enfim, mas você não atende paciente. Nós temos que rever isso. A residência é a continuação da graduação. Nem isso nós conseguimos implementar, que dirá, pelo menos, formar minimamente um médico, como hoje não está ocorrendo.

Também se engana quem acha que esse é um discurso, que o Brasil precisa de médicos. Quando se formarem, todos esses médicos que têm dinheiro para investir, pagar mensalidade de dez a quinze mil, não vão para lugares distantes. Eles vão querer ficar nos grandes centros e vão continuar fazendo uma Medicina que não é a que a gente imagina.

Temos que pensar, repensar, ver e pensar muito bem que Brasil queremos deixar para as novas gerações. Se é isso, onde vai parar isso? Temos que pensar.

Obrigado! Era isso.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado, Doutor Angelo Vattimo!

Agora, ouviremos o Doutor Alexandre Holthausen, da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

O SENHOR ALEXANDRE HOLTHAUSEN CAMPOS (SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN) - Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Gilmar Mendes, demais autoridades, senhoras e senhores, muito boa tarde.

Permitam-me que me apresente. Sou Alexandre Holthausen, sou médico formado em 1993 e trabalho na Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein desde 1997. Atualmente ocupo a posição de diretor superintendente de ensino na instituição e as minhas atividades diárias, nos últimos anos, compreendem assistência, ensino, pesquisa e gestão em saúde.

A Sociedade Beneficente, mais conhecida como Hospital Israelita Albert Einstein, é uma entidade privada sem fins lucrativos e filantrópica. Embora ela tenha mais notoriedade por sua atuação na assistência à saúde, tem robustos programas de pesquisa e ensino e conta hoje com cerca de 45 mil alunos e mais de 2 mil docentes, sempre em cursos relacionados ao ramo da saúde. Estes são programas regulados, como as graduações, e inclui-se aí a graduação em Medicina, que foi autorizada no âmbito da Lei do Mais Médicos, de 2013, e reconhecida com

nota máxima pelo MEC, além de um grande número de pós-graduações e 44 programas de residências médicas, cursos abertos e eventos científicos.

As nossas unidades estão incumbidas de treinar profissionais de saúde da instituição, bem como estudantes e profissionais formados, oriundos de todos os estados da Federação e, mais recentemente, de diferentes países da América Latina. São dezenas de milhares de egressos dos nossos cursos nos últimos 30 anos.

O Einstein é reconhecido como centro de altíssima qualidade técnica e segurança no cuidado do paciente. Embora isso seja produto de diferentes fatores, temos certeza de que o nosso capital humano, capazes profissionais de saúde, seja a razão mais importante para o sucesso alcançado. Somos um grande time de mais de 20 mil colaboradores, incluindo mais de 2.300 médicos contratados, além de cerca de 9 mil médicos credenciados no corpo clínico aberto. Esse grupo se encarrega de mais de 50 unidades públicas e privadas de saúde, incluindo cinco hospitais, bem como de nove unidades de ensino.

Assim, como centro formador e recrutador de número expressivo de estudantes de Medicina e médicos em diferentes fases da vida profissional, sentimo-nos confortáveis em participar desta audiência e emitir opinião.

O Brasil conta com um número de médicos por habitante crescente, como já foi dito, e essa proporção, quando comparada à de nações desenvolvidas, comporta e possivelmente necessita de aumento. Isso é particularmente verdadeiro em certas regiões do país, especialmente em áreas menos urbanizadas. Entretanto, quantidade absoluta de médicos é uma de nossas pendências, mas não a maior; deficiências em competências elementares, sim.

Já há algum tempo, os médicos que chegam ao mercado de trabalho o fazem com padrão de formação muitíssimo heterogêneo e, infelizmente, é seguro afirmar que um número razoável de escolas médicas não reúne as condições necessárias para tarefa tão essencial. Muitos desses colegas médicos procuram formação adicional e atingem, após um número de anos, conjunto mínimo de competências para a prática adequada da Medicina. Contudo, quantos pacientes não passam pelo atendimento com esses médicos, sem supervisão, enquanto isso não ocorre? Além disso, outros tantos médicos não buscam, ou não têm acesso à formação adicional. Naturalmente, são os cidadãos brasileiros, os pacientes que acabam prejudicados por essa situação.

O MEC tem à sua disposição as diretrizes curriculares, instrumentos de avaliação e rede de colaboradores adequados para julgar processos que incluem autorização de funcionamento e reconhecimento de novas escolas, recredenciamento de escolas em funcionamento e autorização de vagas

adicionais. É nossa opinião de que esse Ministério é organismo isento de conflito de interesses, mais bem posicionado e capacitado para essa função. Ainda, o MEC tem sido, no mais das vezes - e deve ser -, o guardião desses processos, protegendo, em última instância, o paciente.

Em 2018, o MEC interrompeu os processos de avaliação de autorização de novas escolas médicas, ou de vagas em escolas médicas existentes, e essa ainda é a regra em curso. Essa decisão trouxe o tempo suficiente para avaliar o sistema. Contudo, a norma foi aplicada, de forma indiscriminada, a todas as instituições de ensino superior, independentemente de suas competências formadoras e de seu valor em relação a corpo docente, infraestrutura e projeto pedagógico.

Considerando o exposto e concluindo, são nossas sugestões ao Senhor Ministro-Relator e aos demais presentes nessa audiência:

1. que o processo habitual de autorização de novas vagas de medicina seja retomado com base nos critérios constantes na lei vigente desde 2013;

2. que esse processo, assim como de autorização, reconhecimento e recredenciamento de cursos, seja conduzido e controlado pelo MEC;

3. que somente cursos que consigam demonstrar ter condições adequadas de infraestrutura, incluindo aí campos de estágio, projeto pedagógico,

e corpo docente, na teoria e na prática, possam ser elegíveis para as concessões mencionadas;

4. por fim, seja dado um prazo para que cursos de medicina em situação considerada imprópria para a formação de médicos de qualidade satisfatória sejam submetidos a processo de remediação, ou até mesmo suspensão de atividades até que condições adequadas sejam demonstráveis.

Muito obrigado pela atenção.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado, Doutor Alexandre Holthausen.

E agora passamos a palavra ao Doutor Sandro Schreiber, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Educação Médica.

O SENHOR SANDRO SCHREIBER DE OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA - ABEM) - Boa tarde, excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, em o nome do qual cumprimento todos os presentes.

É uma satisfação para a Associação Brasileira de Educação Médica poder estar presente neste debate tão importante para a qualidade do ensino médico no Brasil.

Sou Sandro, sou médico sanitarista, professor de saúde coletiva do Rio Grande do Sul - no interior do Rio Grande do Sul -, na Universidade Católica

de Pelotas e na Universidade Federal do Rio Grande. Fui diretor de saúde pública do município de Pelotas. Para quem não conhece o município, é de porte médio, de 350 mil habitantes. Fui coordenador do curso Medicina e, atualmente, sou Vice-Presidente da Associação Brasileira de Educação Médica.

Talvez valha a pena, para os senhores que não são da Medicina, dizer breves palavras sobre quem é a Abem. A Abem é uma associação sexagenária - no dia 21 de agosto passado, completamos 60 anos de existência - e reúne atualmente um pouco mais de 80% de todas as escolas médicas do Brasil. Hoje, temos quase 300 escolas médicas associadas à Abem das 350, 60, 70, dependendo do critério que utilizarmos para considerar o nosso número de escolas médicas. Também temos aí em torno de 10 mil acadêmicos associados à nossa Abem, acadêmicos docentes, discentes e outros interessados na educação médica no Brasil.

A Abem, ao longo destes 60 anos, tem sido muito ativa no cuidado às políticas de qualidade do ensino no Brasil. Especialmente, esteve especialmente envolvida na criação das primeiras diretrizes curriculares, lá em 2000/2001, no Projeto Cinaem, um importante projeto que alavancou diversas discussões com relação ao ensino médico no Brasil. Ano passado, em 2021, realizou a maior prova de avaliação de estudantes e de escolas médicas do mundo. Avaliamos, ano passado, 50 mil estudantes de Medicina de 130 escolas brasileiras, a partir de um teste de progresso, e não de um exame pontual ao final de cursos.

Isso é um pouquinho do que é a Abem.

Eu vou tecer algumas palavras sobre três ou quatro dos itens que foram solicitados e que são muito importantes.

O primeiro deles é sobre a oferta de médicos, a evolução da distribuição. E é importante vermos, já vimos muita gente falando disso aqui hoje, não temos, e acho que se tivermos o ouvido atento, vamos perceber que não temos um consenso sobre isso.

E por que não temos exatamente um consenso sobre isso? Porque os cálculos sobre a necessidade de médicos, eles precisam levar em conta inúmeros fatores que ainda não temos estudos que levam em conta todos eles. Precisamos levar em conta, em primeiro lugar, o próprio sistema de saúde. Não são todos, aliás, a minoria dos países do mundo tem sistemas universais como o Brasil. Portanto, países com sistemas universais precisam de mais médicos do que países com sistemas que não sejam universais.

Uma outra questão muito importante é a nossa distribuição geográfica, que também dificulta e complexifica esses cálculos sobre as necessidades de médicos.

Também o nosso modelo de atenção, independentemente de sermos um sistema universal ou não, o modelo de atenção modifica a necessidade de médicos.

A própria evolução que a Medicina tem tomado, já há várias décadas, da especialização, que é crescente a cada momento, significa que precisamos de mais médicos. Quanto maior o número de especialistas, mais médicos precisamos, em termo de média. Portanto, esse é um valor que, efetivamente, não conseguimos, com os dados que temos hoje disponíveis, ter certeza disso.

Doutor Nésio trouxe, com muita clareza, que olhamos para média de hoje e projeta lá em 2025, 2030, a média que hoje os países da OCDE têm - com todas essas ressalvas que eu já fiz, porque são países muito diferentes do Brasil, mas OK para tomar como parâmetro. Olhamos para isso no futuro, mas no futuro nem mesmo os da OCDE terão essa média. Portanto, são dados difíceis de serem levados em consideração para uma tomada de decisão do que temos hoje.

Por isso, e talvez seja muito importante, para que retiremos talvez um pouco o foco dessa questão. A questão central, ela é efetivamente da qualidade e da necessidade da saúde da nossa população.

A segunda pergunta fala sobre os recursos essenciais para o funcionamento adequado de cursos de graduação.

A Professora Patrícia trouxe vários elementos, e vários colegas também. Eu não vou ser repetitivo, porque os principais foram ditos, mas é muito

importante que haja, minimamente, um sistema de saúde minimamente organizado em que as escolas de Medicina sejam implementadas.

As escolas de Medicina ajudam, fortalecem, ampliam o sistema de saúde local? Sem dúvida alguma. Entretanto, não são elas que criam o sistema de saúde local. Esse sistema precisa existir e ele precisa ser minimamente robusto, para que consigamos aproveitar toda a potencialidade de uma escola de Medicina em favor da população. Do contrário, não vamos ter condições mínimas de formar médicos em determinados lugares.

Há necessidade de médicos docentes de múltiplas especialidades e, sobretudo, com formação em docência, o que também é ainda mais raro. Se já é difícil encontrar médicos para darem aula em faculdade de Medicina - e eu falo do meu município com 350 mil habitantes no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, hoje, um concurso com 15 vagas abertas. E eu tenho certeza de que, ao terminar esse concurso, metade dessas vagas continuarão abertas porque não haverá médicos inscritos. Então, não estou falando da Amazônia, não estou falando de lugares de difícil acesso, estou falando de uma cidade de 350 mil habitantes do Rio Grande do Sul, a duas horas da capital do Rio Grande do Sul.

Isso também, por outro lado, nos indica que se os números sobre médicos não são lá muito seguros para que a gente afirme, na prática, faltam médicos, mesmo numa cidade gaúcha de 350 mil habitantes. Na prática, faltam

médicos. Os números, a gente não consegue ter certeza deles, mas, na prática, faltam médicos.

Sobre os editais de chamamento, que é a terceira pergunta, parece-nos uma estratégia bastante adequada, porque ela é capaz de levar em consideração essas questões que a gente está tecendo comentários anteriormente.

Obviamente que esses editais precisam ser seriamente, esses locais precisam ser seriamente definidos por esses editais. E aí, então, essa pode ser uma estratégia bastante interessante.

Para tentar não usar mais do que o tempo de 10 minutos, como a Associação Brasileira de Educação Médica, fundamentalmente, defendemos uma política pública de formação para a Medicina. E a Lei do Mais Médicos é uma primeira iniciativa nesse sentido. E, portando, até que tenhamos algo melhor, a gente precisa defender a constitucionalidade dessa lei. Ela não é perfeita, ela provavelmente requererá, ao longo do tempo, ajustes, mas ela, hoje, é o que de melhor temos nessa perspectiva de abrir ou de autorizar o funcionamento de curso de Medicina com uma qualidade mínima.

Também sobre o questionamento, se a gente pode ou não pode fazer isso, eu, que sou médico e, portanto, talvez, nem devesse dizer isso, mas, para mim, que dou aula disso para os meus estudantes, eu leio, lá, no art. 200 da Constituição, na Lei nº 8.080, que o SUS é ordenador da formação de recursos

humanos na área da saúde. Aí, eu fico me perguntando: por que mesmo que a gente está questionando se a gente pode ou não pode criar critérios para a Medicina, se está escrito na Constituição que o SUS é ordenador da formação de recursos humanos? E, é claro, que eu digo isso como médico, peço já desculpas aos especialistas que aí estão.

No nosso entender, então, isso é fundamento mais do que suficiente para que a gente creia que, efetivamente, não só podemos, mas devemos fazer isso.

Mas a última questão que me parece muito importante é: que profissionais de saúde são esses? A gente tem que ter clareza que esse médico que a gente que forma ele é, antes de qualquer coisa, um operador de uma das maiores políticas sociais deste país.

A saúde, no Brasil, é uma política social. Talvez não seja em todos os países do mundo, mas, no Brasil, é. A gente forma, em primeiro lugar, operadores de uma política social. E se for formamos operadores de uma política social, nada mais adequado que os critérios sejam dados pelo Estado, que deve se preocupar com isso. Do contrário, vamos estar reduzindo nosso médico a um mero prestador de serviços. E a Medicina e o médico não podem ser apenas um prestador de serviço. Ele é e deverá ser sempre ser um operador de uma política social.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Sandro Schreiber.

E, agora, ouviremos o Doutor José Eduardo Dolci, da Associação Médica Brasileira.

O SENHOR JOSÉ EDUARDO LUTAIF DOLCI (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA - AMB) - Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Ministro da Suprema Corte Gilmar Mendes, em nome de quem cumprimento todas as autoridades e colegas aqui presentes.

Eu sou Reitor das Faculdades [ininteligível] de São Paulo, onde sou professor titular da Otorrinolaringologia, e sou diretor científico da AMB, a quem aqui represento.

Eu gostaria de compartilhar alguns eslaides para poder fazer uma apresentação bem breve, prometendo que vou cumprir o meu tempo, Senhor Ministro.

A AMB é uma associação civil, sem fins lucrativo, e que representa todos os médicos no país inteiro, fundada há 70 anos. Dentre os seus objetivos institucionais, destacam-se a atualização científica, a contribuição para a elaboração das políticas de saúde e o aperfeiçoamento do sistema médico assistencial público e privado no país. Ela congrega 27 associações médicas estaduais e 54 sociedades de especialidades médicas a ela filiadas.

O objetivo da AMB é contribuir para que tenhamos, no Brasil, médicos bem formados e adequada assistência à saúde da população. A AMB se preocupa com a qualidade do ensino nos cursos de graduação em Medicina no Brasil e, por consequência, com a qualidade dos médicos que vêm se formando.

No Brasil, tivemos uma profusão de escolas médicas. Mais do que dobrou o número de escolas de 2013 para cá. O número exato de escolas médicas é difícil, acredito que tenhamos 357 escolas atualmente, a imensa maioria com deficiências importantes em questões básicas para a formação do médico.

Em breve, chegaremos a um número de aproximadamente 40 mil médicos se formando por ano, muitos deles obtendo o diploma sem o devido conhecimento para o exercício da Medicina, porém legalmente liberados para o atendimento à população.

Não há necessidade de aumento de médicos para a melhoria da assistência à população. Há médicos em número suficiente para atender a população brasileira. O problema está na sua distribuição, como já foi falado por inúmeros palestrantes que me antecederam.

No Brasil, o total de médicos subiu de 230 mil, no ano 2000, para mais de 500 mil profissionais, em 2020. Nesse período, a relação número de médico por mil habitantes aumentou significativamente de 1,41 para 2,4, na média geral do nosso país. Ou seja, nós temos uma proporção de médicos que é equivalente ao de

países como Japão, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Se fizermos uma análise - pena que não esteja projetando aí -, mas nós temos um quadro mostrando que, no ano 2000, nós tínhamos 240 mil médicos, o que dava uma proporção de 1,41. No ano de 2020, nós temos 500 mil médicos, dando uma proporção de 2,38. Ou seja, do ano 2000 para 2020, nós passamos de 1,40 para 2,40 praticamente. Mas o problema está na distribuição. No sudeste, nós temos 3,15 por mil habitantes; o Sul, 2,78; Centro-Oeste, 2,74; mas o Nordeste, 1,69 e o Norte, 1,30. Então, há realmente um grave defeito, um viés de distribuição dos médicos no nosso Brasil.

Nós, se formos falar sobre o impacto do art. 3º da Lei nº 12.871, de 2003, na verdade nós não temos o conhecimento de um estudo abrangente e com metodologia adequada que responda a essa questão de forma confiável. Sugerimos que esse impacto seja avaliado antes da tomada de decisão da abertura de novos cursos de Medicina.

O impacto regulatório precisa ser avaliado com base em dados e em termos de chamamento público, distribuição regional dos médicos e qualidade na formação médica brasileira. É fundamental que tenhamos avaliação dos egressos, avaliação de indicadores de saúde da população, onde a Lei nº 12.871 imaginava que fosse ter uma melhoria considerável dos indicadores, isso realmente aconteceu? Avaliação de segurança do paciente, avaliação dos impactos sobre a

rede de saúde local, onde supostamente foram abertas escolas com qualidade para dar aos nossos médicos o poder de atender à população.

Portanto, o posicionamento da AMB, entendemos que é necessária uma regulação forte e rígida para a abertura de novos cursos de Medicina no Brasil, bem como é urgente se estabelecer mecanismos adequados para a avaliação das faculdades já existentes e avaliação constante e periódica dos seus alunos.

Não é adequado, visando garantir a segurança dos pacientes, se pensar em autorizar abertura de novas faculdades sem que antes sejam definidas com clareza as competências que serão exigidas dos cursos de Medicina, sendo imprescindível a revisão das diretrizes curriculares nacionais de 2014, que não definem claramente quais são as atividades para as quais o futuro médico deverá estar preparado no final do seu curso.

Portanto, no momento, a AMB é contrária à abertura de novas escolas de Medicina ou à ampliação de vagas existentes, e sim favorável à avaliação dos cursos de Medicina e dos alunos egressos para verificar a sua conformidade com as necessidades de aprendizagem e treinamento do futuro médico.

Era isso, Senhor Ministro. Muito obrigado pela oportunidade de a AMB expressar quais são as suas ideias sobre esse assunto.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor José Eduardo Dolci.

Ouviremos agora a Doutora Maria do Socorro Mendonça de Campos, da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica.

A SENHORA MARIA DO SOCORRO MENDONÇA DE CAMPOS (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA) - Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Ministro Gilmar Mendes pela sensibilidade de trazer ao debate esse tema tão relevante para nós que trabalhamos com o ensino médico.

É muito difícil falar já no final, depois de Doutor Jeancarlo, depois de Doutora Ludhmila e de todos os colegas que me precederam. Na verdade, eu acho que mudei minha estratégia de fala umas cinco ou seis vezes para não ser repetitiva e cansativa, mas eu vou trazer alguns assuntos polêmicos.

Na verdade, o Brasil é o país dos erros repetidos e das verdades sinistras, como diz o jovem hoje em dia. Nós temos um Sistema Único de Saúde, que não é único; quando eu era criança, a gente tinha médico no interior, porque a gente tinha a Sucam, tinha a Sesp, que o médico ia para os interiores, tratava todas as doenças típicas, na época, que eram endêmicas. Hoje em dia, nós temos dificuldade do médico ir para o interior. Por quê? Dentro de outras coisas, a má remuneração do médico, a falta de uma carreira de Estado para o médico, que fixe

o médico, porque, na verdade, o que a gente tem? O médico vai para o interior trabalhar, toma calote dos prefeitos, trabalha como PJ, vínculos precarizados, que levam três, quatro meses para receber o salário de um mês trabalhado, receber três, quatro meses depois. E, nos últimos 30, 34 anos, nós vimos foi o quê? A Constituição diz que a saúde, a segurança e a educação é um direito de todos e uma obrigação do Estado, mas, no entanto, nós não vemos isso acontecer e não vemos isso ser cobrado efetivamente.

Nós temos, já existe, desde 2004, criado com a Lei nº 10.861, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Mas, no entanto, a gente não a vê sendo posta em prática realmente e ser fiscalizada como deveria ser.

Em 2002, foi criada Portaria nº 2.048, da criação da urgência e emergência e, lá na portaria, diz que o Samu seria um observatório da rede para, a partir daí, fazer políticas públicas em relação à saúde. Aí, eu pergunto a aqui de vocês, quem já viu alguém usar dados do Samu para fazer alguma política pública neste país? Ninguém. Eu sou cirurgiã-pediátrica, mas sou especializada também em regulação em saúde. Trabalhei 13 anos como médica reguladora do Samu. Já estou há 4 anos agora trabalhando como médica reguladora de leitos e eu não vejo o observatório do Samu passar a ser uma fonte de políticas públicas.

Outra coisa também é que durante esses anos todos que vem sendo implantado o Programa Mais Médicos e que deu essa abertura desenfreada

de escolas médicas, o que vimos nesse período foi o quê? De 2008 a 2018, mais de 40 mil leitos hospitalares fechados, mais de 32 mil leitos da saúde pública fechados, principalmente psiquiatria, pediatria e obstetrícia. Então, ao mesmo tempo que se criam mais escolas, botam-se mais médicos, mais estudantes, eles não têm campo de prática, porque leitos são fechados.

Outra coisa também, em relação a leitos de UTI no Brasil. Em 2018, num estudo, apenas 505 municípios brasileiros possuíam leitos de UTI, o que corresponde a 10% do total; sem cobertura de leitos de UTI, tinham 5.065 municípios. Hoje, muitos vão dizer: "Ah, com a pandemia, foram abertos muitos leitos de UTI". Foram abertos leitos de UTI, não. Foram abertos um leito com um monitor, mas o profissional especializado para cuidar do paciente, nós não temos, certo? Então, não adianta nada você ter um monitor, ter um leito e um médico que está ali na UTI não saber nem atender, nem entubar um paciente. Então, eu acho que nós temos de pensar muito em relação a isso.

Nos anos 80, eu me lembro que criticávamos muito que o Brasil só tinha especialistas, e, aí, foi dado o incentivo para criar o Programa de Saúde da Família. Hoje estamos reclamando que o Brasil não tem especialistas.

Então, eu acho que a gente tem muita coisa a pensar em relação tanto à saúde como à educação médica no Brasil. A gente tem de fazer uma reflexão bem grande para que o Brasil não continue sendo o país dos erros repetidos.

Eu concordo com a Ludhmila quando ela fala que o aluno precisa, aliás, não é que precisa, já está na lei, o Enad está aí, não é cumprido adequadamente como deve ser; o aluno tem de ser avaliado no segundo, quarto e sexto ano. Não é correto as escolas médicas estarem ganhando dinheiro à custa de um jovem que sonha em ser médico ou de uma família que sonha em ter um filho médico, e, no final do curso, apenas o aluno que será punido, porque ele vai fazer um exame que, como o colega acabou de falar há pouco instante aí, que não é exemplo para ninguém, a prova da OAB. Nós vemos aí advogados que mal sabem fazer uma petição e, no entanto, têm a OAB, porque fazem a prova três, quatro vezes, fazem o cursinho preparatório e terminam passando na prova. Como não têm nem capacidade de fazer uma petição, vão viver eternamente como auxiliares em um escritório de advocacia maior.

Então, eu acho que não é a solução se fazer um exame apenas ao término da conclusão do curso de Medicina. Só o aluno será punido e as escolas médicas, não.

Eu acho que a gente tem muito sobre o que refletir. Leis nós temos. Há o Enad, há esse sistema nacional de avaliação. Nós temos tudo pronto, só falta que tudo seja cumprido, rigorosamente fiscalizado e as punições devidas sejam aplicadas a quem de direito.

Obrigada!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigada, Doutora Maria do Socorro Mendonça.

Eu agora gostaria de ouvir o Doutor Flavio Gomes Figueira Camacho, da Sociedade Brasileira de Epidemiologia.

O SENHOR FLAVIO GOMES FIGUEIRA CAMACHO (PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA) - Boa tarde, Ministro Gilmar Mendes!

Obrigada pela oportunidade de vir aqui participar deste debate, que está bem produtivo.

Sou presidente da Sociedade Brasileira de Epidemiologia. Nós, basicamente, estudamos e nos debruçamos tecnicamente sobre epidemias. Passamos pela maior de todas agora, a da covid, que nos trouxe muitos ensinamentos e conhecimentos. Produzimos vários trabalhos, várias publicações, vários artigos. Trouxe aqui alguns fragmentos de algumas coisas desses artigos que acho que ajudariam, de repente, no entendimento do contexto do Mais Médicos.

O Brasil teve 34 milhões de casos de covid, mesma quantidade de casos que a Alemanha teve. A Alemanha também está com 34 milhões de casos de covid, mas, no Brasil, 680 mil pessoas morreram, contra 150 mil na Alemanha.

A gente pensa: por que, na Alemanha, morreu-se tão pouco e, no Brasil, morreram tantos? A gente se debruçou sobre isso para tentar entender, porque o objetivo do epidemiologista é tentar entender as causas disso, para poder atuar sobre isso.

Se a gente pensar que houve essa diferença, a gente vê que, no Brasil, para cada mil pessoas que pegaram covid, vinte morreram. Na Alemanha, de cada mil, só quatro morreram. É uma discrepância muito grande.

Lógico que esse estudo é multifatorial. Há vários itens envolvidos: sistema de saúde, investimento. Mas a gente começa a bater em um ponto: quantos médicos temos no Brasil por mil habitantes? Dois. Na Alemanha? Quatro. Isso é um indicativo, uma evidência de que isso poderia ter influenciado nessa mortalidade tão grande no Brasil, mas, como as diferenças de economia, de sociedade, de legislação, são tão grandes, a gente ainda não consegue tirar grandes conclusões.

A gente compara com a França, que também teve 65 milhões de casos - matematicamente muito próximo - e 152 mil mortes, ou seja, 4%, novamente. França e Alemanha têm uma quantidade de mortos muito próxima - quatro a cada

mil habitantes - e, na França, temos 6,5 médicos por cada mil habitantes. Temos uma quantidade muito maior de médicos, mas a consideração se mantém constante.

Como a comparação com esses países não seria válida, vamos comparar com a Argentina, nossa vizinha. A Argentina teve 9 milhões e 700 mil casos de covid e 129 mil mortes, o que dá treze mortes para cada mil habitantes.

Por que, no Brasil, morreram vinte para cada mil e, na Argentina, nossa vizinha, morreram treze para cada mil habitantes? Alguma coisa está errada.

A economia da Argentina é melhor que a do Brasil? O sistema de saúde da Argentina é muito melhor que o do Brasil? A política pública é melhor? Ela passa por uma situação econômica boa, socialmente excelente? Não!

Então, como ela saiu dessa epidemia tão bem? A Argentina tem quatro médicos para cada mil habitantes. O Brasil tem dois. Isso é uma evidência de que essa quantidade de médicos fez diferença.

Mas vamos lá, temos outros países. Vamos analisar o Uruguai, também nosso vizinho, politicamente mais estável. Ele tem cinco médicos para cada mil habitantes. Lá morreram sete pessoas a cada mil. No Brasil, morreram vinte.

Qual a diferença entre Uruguai e Brasil? Várias diferenças. Uma das que a gente consegue elencar, que é uma evidência, é que a quantidade de médicos precisa crescer, justamente a quantidade de médicos. Aqui, temos dois!

Isso nos leva a entender que não se sabe qual é a quantidade certa. Claro que ninguém sabe quanto é a quantidade ideal de médicos por habitante, mas se imagina que temos menos do que o necessário. Era uma condição excepcional, porque era uma epidemia e, nessa epidemia, precisava-se de muitos médicos. Mas mostra que o país não estava preparado para lidar com isso.

Se, em 2013, tivéssemos aumentado a quantidade de médicos no país, em 2019, seis anos depois, teríamos menos mortes. No Brasil, morreram 687 mil pessoas. Se aqui morressem 13 habitantes a cada mil, como morreram na Argentina, teríamos salvado 222 mil vidas! Se tivéssemos cinco médicos, como no Uruguai e um sistema médico igual do Uruguai, teríamos salvado 423 mil pessoas!

Isso é o que a gente quis trazer para reflexão. Se a gente falar "não, mas, são outros países!", vamos olhar o Brasil, o Pará! O Pará teve 843 mil casos de covid, 18 mil mortos! O Pará tem um médico para cada mil habitantes! Teve a maior taxa de morte de covid no Brasil: 22,3! É claro que temos um problema e o aumento da quantidade de médicos vai melhorar.

Como é que se prepara um país para uma epidemia? Você não pode comprar respirador, porque a próxima epidemia pode ser de uma infecção

não respiratória. A própria varíola, por exemplo, que está voltando agora, não precisa de respirador. Então, equipamento não adianta.

Tu tens que ter o quê? Médicos, profissionais, funcionários, pessoas que vão atuar. Em qualquer epidemia que venha para o país, o médico vai ser o cara que vai ter que trabalhar. É ele que vai fazer diferença na hora de salvar vidas e, na hora, fazer a diferença para poder melhorar isso.

Esse aqui é só um fragmento, na verdade, de vários *papers* que a gente fez e tudo mais, onde eu me quis concentrar, porque eles comentavam e vários índices nossos indicavam que a quantidade de médico estava associada. Lógico que os estudos envolvem muitas outras coisas multifatoriais, todos os profissionais aqui sabem disso, mas um dos fatores, e temos evidências disso, provavelmente, é a quantidade de médicos.

Nosso objetivo era contribuir com isso, com esses estudos, para poder mostrar e para ajudar no entendimento do caso. Realmente não existe um valor mágico. Não sabemos se é 3, 4 ou 6. O exemplo da França é clássico. A França tem 6,5 médicos por mil habitantes; a Alemanha tem quatro. Os dois países tiveram exatamente a mesma taxa de mortalidade, um teve 4,4 e o outro 4,3, uma diferença estatisticamente desprezível, ou seja, aumentar demais a quantidade de médicos também não resolve.

Existe um limite até onde você colocando mais profissional, você vai conseguir melhorar o processo. Mas qual é o limite? Não sabemos. Mas uma coisa é certa: a gente está fora dele. Precisa de mais! O país necessita de mais profissionais.

A gente não é político para saber como é a parte constitucional, a parte jurídica e tudo mais. Nossa função aqui é muito mais técnica, mas a gente entende que precisa aumentar a quantidade de médicos. Como? Isso cabe a vocês decidirem ou discutirem, porque vi que há várias pessoas aqui também integradas com o processo de discussão disso, com propostas e tudo mais.

A gente veio tentar ajudar o Tribunal com fatos, com dados concretos, para mostrar o estrago que a covid fez em nosso país e como ele poderia ter sido muito menor, se, em 2013, tivéssemos conseguido colocar mais médicos dentro desse país, se a gente tivesse uma comunidade médica maior.

O fato é que se morre por falta de atendimento, por falta de gente. Há o problema de qualidade? Sim, e quantitativo também. Não adianta ter qualidade, se não tiver quantidade, ou quantidade sem qualidade. Os dois não podem andar sozinhos. Se você tiver 2,2 médicos excelentes, ia dar problema do mesmo jeito, porque eu precisava de quantidade. Eu tinha uma população de milhões de pessoas sendo internadas ao mesmo tempo, hospitais superlotados.

Outros países lidaram melhor com isso, com economias piores que a nossa, com sistemas de saúde muito piores que o nosso.

Vou encerrar aqui de qualquer maneira. Obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado, Doutor Flavio, por essa contribuição!

Agora, ouviremos o Doutor Carlos Eduardo de Souza Miranda, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

O SENHOR CARLOS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA) - Excelentíssimo Senhor Ministro e demais autoridades presentes, Senhoras e Senhores, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, na qual faço parte do Conselho Administrativo, agradeço a oportunidade de participar desta importante audiência pública.

Inicialmente destaco que a Sociedade Brasileira de Cardiologia entende que aumentar o número de cursos de Medicina ou mesmo o número de vagas naqueles já existentes não significa aumentar o acesso da população aos médicos e ao tratamento adequado. Ao contrário, percebemos que a criação descoordenada e desequilibrada de cursos de Medicina, sem a adequada fiscalização, pode levar a gravíssimas consequências, em especial aos cidadãos que buscam acesso à saúde.

Conforme previamente apresentado por aqueles que me antecederam, o que há atualmente no Brasil em relação aos médicos é uma intensa concentração de profissionais em determinadas regiões, e não um déficit propriamente dito.

O Brasil é o segundo país com mais escolas médicas no mundo. Nem por isso consegue oferecer acesso à saúde em níveis adequados e recomendados pela Organização Mundial de Saúde. A verdade, Senhor Ministro, é que não há saúde sem médicos qualificados. Não é a abertura de novos cursos de Medicina que irá garantir essa qualificação. Na verdade, dados os resultados, parece-nos exatamente o contrário.

Quanto aos novos cursos, causa-nos imensa preocupação a possibilidade de não haver corpo docente qualificado que preencha os pré-requisitos mínimos de titulação acadêmica de mestrado ou doutorado em número suficiente para atender à crescente demanda.

Além disso, vários dos novos cursos poderão não apresentar estrutura adequada tanto em nível das atenções básicas e ambulatorial quanto em nível hospitalar, bem como em serviços de urgência e emergência.

Ressaltamos aqui que, sem as atividades práticas de ensino, seja nos primeiros anos do curso, durante o internato, seja durante a residência médica, não há como oferecer educação eficiente e de qualidade aos futuros médicos. Isso

sem dúvida impacta não só na formação médica em si, mas também na especialização.

Especificamente, em relação à residência médica, essencial para a formação do profissional qualificado, a abertura em grande escala de vagas de graduação, sem a proporcional oferta de vagas de residência, como já lembrado por alguns que nos antecederam, pode levar ao aumento dose médicos generalistas - generalistas aqui são aqueles que não possuem nem residência médica nem título de especialista; não aqueles, como muito bem colocado pela Doutora Ludhmila, que vão prestar assistência na atenção básica de saúde. Sabemos que isso é importante, mas eles devem ter alguma formação, seja em clínica médica, seja em medicina de família, porque entendemos que grande parte das doenças cardiovasculares é prevenível sim na atenção primária à saúde. Estamos aqui nos referindo àqueles generalistas que não têm formação nenhuma sequer após a graduação.

Em termos práticos, isso pode impactar negativamente no atendimento de doenças cardiovasculares, principal causa de morte no Brasil e no mundo. A cada ano, mais de 350 mil brasileiros morrem de causas cardiovasculares.

Destacamos ainda a possível incapacidade das novas escolas no desenvolvimento de pesquisa de boa qualidade. Nesse ponto, ressaltamos que, sem

as pesquisas, a ciência não evolui e a qualidade da assistência, mais uma vez, pode ser prejudicada.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia entende que não há como criar cursos e abrir novas vagas sem a observância de critérios técnicos mínimos que envolvam profissionais capacitados, estrutura adequada para assistência e pesquisa e que, em última análise, permitam aos alunos educação eficiente e de boa qualidade. Entendemos que somente assim os novos profissionais poderão estar preparados para oferecer assistência de qualidade à população.

Por fim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no cumprimento de sua missão - atuar pela excelência no cuidado cardiovascular no Brasil -, sugere: até que sejam mais bem definidos os critérios de avaliação e fiscalização - e já o foram sugeridos aqui - para os novos cursos, do ponto de vista médico, mantenha-se o chamamento público para que seja deferida autorização ao funcionamento de novos cursos de Medicina.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Carlos Eduardo de Souza por sua exposição!

Como havia anunciado, tenho duas indagações dirigidas inicialmente à Doutora Ludhmila Hajjar e, depois, à Doutora Lúcia Braga.

Eu queria também dizer a todos os senhores que alguns dos *experts* convidados não puderam comparecer, mas mandaram suas contribuições.

Eu vi que os senhores, inclusive a Doutora Ludhmila, ficaram constrangidos pelo tempo estabelecido. Nós queremos que essas exposições nos sejam encaminhadas para que subsidiem nossa decisão.

Diria, então, Doutora Ludhmila, que a Lei nº 12.871, além do chamamento público, objeto de várias considerações aqui, estabelece critérios técnicos para a abertura de novos cursos de Medicina. Em relação aos municípios que receberão escolas de Medicina, ao menos exigem-se ações e programas: atenção básica; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde.

Quanto às instituições de ensino, a norma impõe infraestrutura adequada; acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as especialidades básicas indispensáveis à formação dos alunos; possuir metas para corpo docente em regime de tempo integral e para corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver pesquisa de boa qualidade.

Então, nesse contexto, eu pergunto se a senhora considera ser necessário o chamamento público para assegurar a qualidade dos novos cursos de

Medicina, ou se seriam suficientes, ou poderiam ser suficientes, os critérios técnicos dos §§ 1º e 7º do art. 3º da Lei nº 12.871?

A SENHORA DOUTORA LUDHMILA ABRAHÃO HAJJAR (PROFESSORA) - Excelentíssimo Ministro, obrigada pela pergunta.

A minha opinião em relação à necessidade do chamamento. Eu não o vejo como necessário. Entendo que, em 2013, o chamamento público, por meio de edital, era uma necessidade para atender a regionalização daquelas necessidades naquele momento. Então, estipulava-se o município ou a região, e aquilo demandaria uma concorrência.

Eu vejo no sentido de, se nós revisarmos os critérios, os critérios são adequados, mas houve uma flexibilização deles, então, eu penso que nós deveríamos agir com bastante intensidade no sentido de colocar como pré-requisitos necessários e impor que estas instituições, elas consigam ser avaliadas de acordo com esses pré-requisitos de uma maneira mais rígida; e, possivelmente, esses critérios deverão revisitados por uma comissão independente, que agiria em modo contínuo, lembrando que, muitas vezes, o tempo para uma avaliação demora-se até um ano, dois anos. Então, até coloquei como uma sugestão um tempo de 120 dias, por exemplo, em ato contínuo, desde que a instituição tenha obedecido àqueles pré-requisitos determinados.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Ludhmila!

Agora uma pergunta para a Doutora Lúcia Braga.

Doutora Lúcia, as disposições até aqui realizadas indicaram que a fixação de médicos em cidades do interior do país é um dos grandes problemas enfrentados pelo Estado brasileiro, pelo SUS inclusive, a despeito de outras considerações que se possam fazer sobre a qualidade e a qualificação desses profissionais. Que medidas a senhora considera importantes para alcançar-se êxito na melhor distribuição de médicos no território nacional?

A SENHORA LÚCIA WILLADINO BRAGA (REDE SARAH DE HOSPITAIS) - Eu defendo o chamamento público no sentido de que, concordo com a Doutora Ludhmila, que muitos médicos não ficam no lugar onde se formaram. Aqui na Rede Sarah, a gente recebe muito pacientes que fizeram a residência na Unicamp, em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro.

Entretanto, por exemplo, nós começamos a expandir a Rede Sarah para a Região Amazônica, onde mais faltam médicos, e a gente verificou, inicialmente, na Rede Sarah, como é uma rede nacional, nós fazemos uma seleção nacional para médicos, para todos os profissionais. Então, a pessoa passa no processo seletivo e é convocada para trabalhar em Belo Horizonte ou em Macapá. E ninguém ia para esses lugares.

Quando aí nós optamos por uma coisa, depois de muitos anos sem conseguir profissionais para Belém e Macapá, fazer seleção local com as universidades locais. E conseguimos obter médicos e melhor qualificá-los para ali ficarem, aderirem a estar naquele estado e fazer o processo de requalificação de eventuais deficiências.

Então, eu acho que o chamamento público ainda é necessário no Brasil.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado!

Bem, senhoras e senhores, eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Certamente, tivemos aqui excelentes contribuições. Se nós tivéssemos tomado qualquer decisão antes de uma instrução tão cuidada como a que os senhores propiciaram ao Tribunal, certamente nós poderíamos incorrer em, ou pelo menos teria essa possibilidade, maiores equívocos, num país dessa complexidade, como se demonstrou aqui nas várias abordagens.

Nós já fizemos, eu mesmo - os anos já se passam, não é? -, em 2009, eu presidi uma audiência pública sobre a judicialização da saúde, e discutimos, então, essa problemática. E, claro, fomos para além das questões, indicamos, assim, havia todo aquele problema sobre registro dos medicamentos, inicialmente, registro dos medicamentos na Anvisa, depois a sua incorporação ao

SUS. Portanto, todo aquele debate que nós travamos naquele momento e que surtiu efeito, pelo menos no que diz respeito a uma regularização geral, e também nos valemos do CNJ - à época, Presidente do Supremo, Presidente do CNJ -, para estabelecer algum tipo de regulação, a possibilidade até mesmo de que houvesse peritos que auxiliassem os juízes.

Eu já brinquei várias vezes sobre essa situação - um pouco para fazer o ambiente menos tenso - que, assim como para os senhores tudo acontece em momentos os mais, talvez, inapropriados, acontece a toda hora; também para nós, muitas vezes, no Judiciário - eu estava, sempre converso, tive uma boa experiência, vivi dois anos muito intensos na minha vida na Advocacia-Geral da União, de 2000 a 2002 - eu dizia, Doutora Lúcia, que tudo parecia acontecer sexta-feira às 6h da tarde, quando, na Amazônia, por exemplo, o advogado público já tinha saído para pescar. Então, alguém foi preso, e nós precisávamos então tomar alguma medida. No caso da vida dos médicos, isso ainda é muito mais sério. E nós então tínhamos que tomar medidas.

No caso específico do funcionário público, por exemplo, que está obrigado a dar um tratamento, a prover uma ordem do juiz, isso ocorria a toda hora: atenda isso, proveja uma vaga em um hospital ou vaga na UTI. E nós então tentamos racionalizar isso a partir da abordagem, e também do diálogo amplo na construção de políticas públicas.

Parece-me, também, aqui, acho que graças à contribuição dos senhores, a despeito do debate, que tem marcos processuais e legais próprios, também ficará um legado para políticas públicas que precisam ser necessariamente atualizadas. Acho que essa é a importância também desta audiência pública que, a par de iluminar o trabalho que vem sendo feito, no caso concreto, e que está sendo colocado, nos ajuda a compreender toda essa complexidade marcada, todas essas assimetrias que marcam o Brasil.

Nós ouvimos a exposição do Doutor Flávio Gomes sobre a questão da pandemia. Ele, obviamente, não fez essa consideração - e nem precisava, e nem deveria fazê-lo -, mas um dado importante que talvez a comunidade médica não precise ser relembrada, mas certamente tem que fazer um registro, é que nós tivemos, também, no que diz respeito à pandemia, uma intensa judicialização.

É difícil fazer o cálculo só com a falta de médicos para essa questão das mortes dos 600 mil, 700 mil mortos. Mas nós tivemos um ziguezague, uma confusão que não é o que o SUS preconiza, não é o que o texto constitucional preconiza que é a ideia de um sistema coordenado integrado de saúde. Tanto é que, desde o início 2020, nós começamos a ter aquele desacerto sobre o isolamento social, as desinteligências a propósito disso. E as primeiras decisões que o Tribunal teve que tomar foram sobre a competência: se estados e municípios precisavam de uma autorização da União para baixar aquelas medidas que já estavam previstas na lei:

isolamento social, quarentena e tudo mais, ou se eles tinham competências para fazê-lo.

Esse foi um debate que o Tribunal teve que enfrentar. Enfrentou como senhores conhecem, reconhecendo a competência de Estados e municípios na matéria.

É claro que, qualquer um percebe, e aqui falou o Conass também, que, se houvesse uma coordenação adequada, a partir da União, certamente as restrições para isolamento social, por exemplo, ou outras medidas de restrição à locomoção, poderiam ser muito mais racionalizadas. E isso seria factível.

Mas, naquele quadro de confusão administrativa e confusão jurídica, o Tribunal, então, afirmou a competência de estados e municípios. E era natural, também, dentro da estrutura do SUS. A União tem uma participação muito forte no sistema do SUS, há muito questionamento sobre se o financiamento é adequado, tanto é que temos até uma ADI em que está sendo discutida a emenda constitucional a propósito dessa temática. Mas, claro, os senhores sabem bem, e aqui já foi falado, nós tínhamos um quadro de exposição das pessoas ao vírus, à infecção. E muitas dessas pessoas precisavam de algum atendimento básico. E o atendimento básico teria que se dar, normalmente, num hospital do sistema SUS ou administrado pelo município ou pelo estado. E, daí, muitos precisavam de hospitalização, e muitos precisavam de atendimento UTI, e tudo isso sob a

responsabilidade massiva, normal, de estados e municípios. E veio o Supremo, então, e fez essa afirmação, inclusive seguindo uma certa consideração de índole pragmática.

Depois, no final de 2020 - e eu estou falando para especialistas que sabem disso tudo, mas só para que nós possamos entender a própria responsabilidade com que o Tribunal se houve nesse contexto -, no final de 2020, vem aquela esdrúxula guerra da vacina. A vacina do Dória, a vacina da China, a não compra da vacina, e todo esse quadro. E pasmem os senhores, um país com toda essa experiência de vacinação, na verdade o plano de imunização foi estabelecido a partir de uma liminar do Ministro Lewandowski - aqui, se falou muito de liminares e também se falou mal de liminares. E, de fato, há problemas, muitas vezes, com as decisões liminares, mas há liminares salvadoras. Nesse caso, o foi. E, depois, referendada pelo Plenário. Mas o Brasil começou a inauguração do processo de imunização a partir também de decisão do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, essa é uma tarefa extremamente complexa. E eu ainda, anteontem - acho que anteontem - falava, em Berlim, e participava de um seminário, e, aí, relatei um pouco desses fatos. Então, estava lá um velho professor, um colega, o Professor Dieter Grimm, e ele observou que a Corte Constitucional Alemã foi muito cautelosa na intervenção, na discussão sobre políticas públicas. E eu relatando os fatos que ocorreram, e ele, então, chegou a seguinte conclusão:

talvez porque o sistema público no Brasil tenha tido muitas falhas, a Corte teve que ser muito mais ativista, talvez, mais firme do que o que aconteceu com a Corte Alemã.

Seja lá qual for a razão, eu só queria colocar aos senhores esses aspectos que são muito relevantes para a discussão de políticas públicas.

Eu gostei imensamente, eu gostei de várias exposições, mas de uma colocação que a Doutora Ludhmila fez sobre a mudança de paradigmas. Os fatos vão mudando e nós precisamos atualizar. As políticas públicas precisam de ser também constantemente reavaliadas.

No Direito, a gente trabalha, no plano constitucional, com a ideia de mutação constitucional, e admitimos também que as leis podem ir se inconstitucionalizando. Tudo isso acaba por ocorrer e necessita, às vezes, de atualização.

Pois eu queria fazer esse registro realmente da bela, positiva contribuição que os senhores trouxeram para nós, certamente muito úteis para essa avaliação.

Muito obrigado.

Vamos fazer um intervalo e em seguida prosseguiremos com a audiência.

[INTERVALO]

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Boa tarde mais uma vez! Estamos reabrindo nossa sessão da Audiência Pública da ADC 81 e da ADI 7.087. Vamos dar continuidade às exposições. Agora chamamos o Doutor Henrique Sartori de Almeida Prado, ex-Secretário Executivo do Ministério da Educação e ex-Ministro da Educação substituto, que falará pela Associação da Instituições Comunitárias de Educação Superior e pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará.

O SENHOR HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ) - Boa tarde a todos os presentes.

Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, em nome do Senhor, gostaria de cumprimentar a todas as autoridades do Poder Judiciário, e, em nome do nosso colega Paulo Chanan, também estendo a todos os componentes dessa mesa que se fazem presentes; aos dirigentes universitários; todos os dirigentes das instituições de educação superior do Brasil que aqui se representam; em especial à ABRUC e ao Sindicato do Pará pelo convite e pela extensão da sensibilidade ao se fazer presente nesta importantíssima audiência pública.

Desde já, Ministro Gilmar, gostaria de agradecer e fazer pública uma menção de honra que temos, hoje, de discutir esse tema tão caro, tão rico para a educação brasileira e, ao mesmo tempo, a oportunidade de expressar vários pontos de vista. Uma vez que começamos o dia de hoje conversando muito sobre questões concorrenciais, de mercado, da profissão médica, acredito eu que agora podemos inaugurar um debate também em relação ao nosso sistema de ensino, como funciona a sua regulação, o impacto dessa regulação e para que servem os processos de avaliação, já que houve grande empatia dos oradores anteriores, falando nessa parte, e agora podemos explorar um pouco mais.

Eu utilizei um tema bastante polêmico para indicar um final feliz nessa apresentação. Espero discorrê-la o mais rápido possível. Farei alguns pulos durante esses slides, porque são muitos.

Por que coloquei "o fim do Programa Mais Médicos"?

Como foi falado anteriormente e muito bem explorado pela Doutora Ludhmila em suas menções e pelo Ministro na sua última intervenção, parece-me que o programa exauriu o seu sentido. Há pelo menos quatro anos, esse programa não funciona mais para a educação brasileira. E também, para o Ministério da Saúde, este programa foi revisto. Então, existem vários pontos a serem conectados, de forma que eu acredito que a lógica e a persuasão de todos os

apresentadores do tema aqui serão de suma importância para entender esse contexto.

Deixarei os dados que já foram traduzidos aqui em relação às vagas, ao número da formação médica, mas vou ressaltar a importância da alteração do número de vagas, matrículas e concluintes.

Quando falamos que temos 41 mil matrículas - ou vagas, melhor falando -, não podemos esquecer que nem todos os 41.500 chegam no final do processo e que não quer dizer que esses 41 mil, os quais começam no ano um, chegarão ao ano sexto com seu itinerário formativo completo. Obviamente, os dados precisam ser mais esmiuçados em relação a esse ponto.

A base e a tônica da minha intervenção serão em relação aos dois modelos, às duas vias que existem. Elas sempre coexistiram no Ministério da Educação. E, pelo poder discricionário do Poder Executivo, simplesmente pela prática da política pública, veremos que existem momentos de priorização de uma delas e a coexistência desse mesmo sistema juntamente com a Lei nº 12.871.

Então, o que nós temos de levar em consideração? A Lei nº 12.871 trata de uma política pública indutiva, onde o Estado fala para os interessados que ele quer chegar a um determinado espaço e, ao mesmo tempo, o processo transcorre também, na sua prática, pela Lei dos Sinaes, como verificaremos e que foi colocado e é ponto.

O chamamento público - está nesse item dois que colocamos aqui - vai até a fase final de monitoramento, que são os anos em que o MEC faz as visitas e acompanha o processo de implantação desses cursos. Obviamente, logo depois, inicia-se também a fase Sinaes, com processo de reconhecimento e processo de renovação de reconhecimento desses cursos. Ou seja, a avaliação não deixa de existir em momento algum pelo Ministério da Educação. Leva-se sempre em consideração o acompanhamento durante a implantação desses cursos, seja no primeiro edital de 2014, o Edital 6/2014, seja no edital de 2017, no edital complementar e, consequentemente, por aí.

Então, nós temos uma figura que, se a levarmos em consideração também, poderemos ter três sistemas de processos de autorização e de convivência de cursos de Medicina no Brasil. Se levarmos em consideração o poder - mais uma vez, eu estou enfatizando isso - discricionário de abertura de curso de Medicina nas instituições federais de ensino superior - que é uma vontade do Ministério -, ele não segue a Lei do Mais Médicos, ele não segue a Lei do Sinaes. Obviamente ele vai se submeter à Lei do Sinaes, mas o ato de criação é discricionário do Ministério.

Assim, temos aqui tanto o ato discricionário do Ministério da Educação e o ato de colocar o edital à mesa segundo os seus critérios vigentes.

Portanto, eu gostaria de apresentar essas questões que são importantes e, ao mesmo tempo, levantar uma linha do tempo com alguns argumentos, que são importantes para entendermos como nós chegamos até aqui.

O Tribunal de Contas da União, no ano de 2015, no ano de 2014, já se debruçara sobre o tema. Nós podemos entender que, no ano de 2014, a Ministra Ana Arraes suspendeu o edital do Mais Médicos e indicou caminhos para o MEC realizar. E houve uma contestação.

Então, essa lei é contestada, basicamente, desde o seu nascimento, desde a sua inauguração como medida provisória. Não é novidade, hoje, o processo de judicialização ou, pelo menos, essa discussão no âmbito do Poder Judiciário, que nós enfrentamos aqui.

O TCU já compreendeu, em relatório, em manifestação de voto, que existem as duas vias: que o MEC preconiza uma política pública pela qual ele quer induzir a presença de cursos de Medicina; mas, ao mesmo tempo, não ele pode restringir direitos - que é o que nós estamos trabalhando aqui hoje - e , obviamente, durante as gestões que precederam, desde 2013 até os dias de hoje, debruçam-se sobre essa mesma temática.

Então, colocando alguns pontos importantes:

O ambiente regulatório da Medicina. Nós temos todas essas leis de que falei, mas uma questão sobre a qual eu gostaria de me debruçar,

especificamente, é que a Lei nº 12.871 não altera a LDB. Ela cria um fluxo próprio, cria a modalidade de chamamento público e, curiosamente, ela já sofreu alterações, principalmente retirando ali um ponto que foi falado anteriormente aqui pela Doutora Ludhmila, salvo engano, que é a própria avaliação de dois em dois anos.

Quando saiu, quando a lei foi modificada, nós não tivemos processos judiciais, nós não tivemos o chamamento do Poder Judiciário para retornar à política de avaliação que foi colocada aqui.

Contudo, o que eu quero mencionar é que o Decreto nº 9.235/2017 indica que o MEC poderá estabelecer - poderá no sentido não imperativo da palavra, de ser o único, a única via, o único meio, a única forma. E, obviamente, a portaria que o regulamentou, que ajudou nesse processo de regulamentação, cria também alternativas de exceção, destaca, entre vírgulas, o que o MEC pode fazer, o que poderá fazer e o que ele pode escolher fazer. Essa é a questão de política pública sobre a qual nós nos debruçamos.

O ambiente continua com a Portaria nº 328, essa portaria da moratória, em que tivemos aí a suspensão de novos editais, mas não foi ao léu, não foi ao léu. O que que aconteceu para termos a suspensão?

Alguns falaram aqui rapidamente, outros enfatizaram de forma mais dura o processo de aumento de número de cursos, de vagas; mas o processo Mais Médicos, lá em 2017, cumpriu o seu objetivo. Os editais cumpriram os seus

objetivos na criação de novas vagas de curso de Medicina, comparados os ditames da OMS, do Ministério da Saúde, do PNE, criando mais de 11 mil novas vagas de Medicina, sendo pouco menos de 1.500 vagas no ambiente dos editais e mais de 10 mil vagas no ambiente de aumento de vagas para todo o sistema. Vou repetir: 1.500 vagas no Edital Mais Médicos - os quatro: os dois regulares, um especificamente do qual nós tivemos uma instituição hospitalar vencedora e outro para complementar algo que o TCU pediu para o MEC fazer em relação ao que foi judicializado de três municípios anteriormente.

Então, nós tivemos dois de ampla concorrência, sendo que o primeiro não foi suficiente para suprir a demanda porque ele ficou restrito muito à área Sul e Sudeste. E os outros foram incorporados, digamos assim, à Região Norte, Centro-Oeste e Nordeste do país de forma mais rápida ou, pelo menos, mais precisa.

Então, no ambiente regulatório da medicina, o MEC não deixou de processar pedidos de aditamento de vagas pelo sistema regular de oferta desde a vigência da lei. Houve um processo de aumento de vaga, houve o processo de reconhecimento de cursos, de renovação de reconhecimento, dizendo que a Lei Mais Médicos, a nº 12.871/2013, convive com a lei do Sinaes.

Nós ouvimos aqui muito falar de Sistema Único de Saúde, que é algo maravilhoso, que pertence ao Brasil. Mas o Brasil tem algo tão maravilhoso

quanto para educação superior que é o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. Isso é uma conquista de todas as mais de 3 mil instituições de ensino de educação superior que nós temos no Brasil.

Nós estamos deixando essa discussão. Os educadores, os gestores e diretores, dirigentes, gestores públicos da educação estão deixando de falar nesse sistema para dar vazão a um programa que, no meu entendimento, já está com dia e hora para acabar. Por quê? Nós vamos falar sobre isso.

A Lei nº 12.871 não aborda nenhum ponto sobre processo de aditamento de aumento de vagas, apenas do processo de autorização pela via do chamamento público. E, obviamente, ela não indica a lei dos Sinaes, ela não apresenta nenhuma outra norma que assim fez ela se apresentar.

Outro ponto do ambiente regulatório: uma nota técnica que, inclusive, está sendo utilizada, neste momento, para fechamento do processo que foi retomado - e isso é louvável por parte da equipe ministerial do Ministro Victor. A retomada, depois de quatro longos anos, desse sobrestamento que nós tivemos em relação à política de formação médica no Brasil e que, até agora, não chegou, em momento nenhum, não foi apresentado nada de novo ainda para comunidade ou para a sociedade. Mas a nota técnica já atesta esse meio do qual eu falei, que, em 2018 - inclusive, assinada por mim nessa época -, mostrava que os objetivos do edital Mais Médicos, objetivos da Lei nº 12.871, foram preenchidos.

Nós apresentamos isso para o Ministério da Saúde, nós apresentamos isso, à época, enquanto dirigentes do Ministério da Educação, para o Conselho Nacional de Saúde, do qual eu fui conselheiro, e também apresentamos para o Ministério Público Federal, que cobrou medidas, e cumprimos um acórdão do Tribunal de Contas da União, que já se debruçou sobre esta questão do art. 3º da Lei nº 12.871 e, ali, indicou caminhos para o MEC. E o MEC prestou contas: falamos que foram criadas, naquele momento, as vagas necessárias para atingir a meta estabelecida.

E, por final, eu costumo dizer, como cientista político, também, que a política pública é ação dos governos. E, se os governos não agem, quer dizer que ele deixou aquela política pública num patamar de menos importância e está cuidando de outras questões mais relevantes para o processo decisório e discricionário que compete ao Poder Executivo para tomar as medidas próprias.

Eu trouxe algumas evidências entre o modelo Mais Médico e o Médicos pelo Brasil. Isso, em 2018, o MEC vem e suspende os editais, suspende os editais da política pública indutiva. Ele não suspende a lei do Sinaes, ele não age de forma revocatória da LDB. Ele suspende os editais, fazendo com que, no ano seguinte, em 2019, já na vigência do atual governo, cria-se um novo modelo de programas, substituindo o modelo Mais Médicos. E é aí que eu quero dizer que esse é o fim daquele programa, porque o próprio art. 37 da lei do modelo novo, da

lei que nós chamamos aqui do Médicos pelo Brasil, ele apresenta essa prerrogativa de transicionariedade, ou seja, de transição, de substituição do modelo Mais Médicos.

O Ministério da Saúde está abandonando esse modelo, criando um novo patamar de contratação de profissionais de carreira de Estado, como foi falado aqui. E, obviamente, o modelo que compete ao capítulo 2 da Lei nº 12.871, ele está sobrestado, ele está suspenso. Não existe via, nem para um lado, nem para o outro, para questão dos cursos de Medicina no Brasil.

Então, o programa Mais Médicos atuou em mais de 26 ciclos no Ministério da Saúde. No MEC, como falei anteriormente, tivemos quatro editais, um para hospitais, dois para nacionais.

Em 2018, já cumprindo o ciclo da política pública instituído pela lei, o MEC suspende para uma reavaliação e cria o GT.

Foi feito naquele momento, senhoras e senhores, uma reavaliação, um momento de suspensão. Uma consultoria foi contratada pelo Ministério da Educação. Lembro até mês que foi entregue, recebido, um relatório transcrito, muito bem feito, pelo professor Dr. Carlos Del Nero e sua equipe, indicando o *status* e o *status quo*, e o momento, o estado da arte do curso de Medicina no Brasil.

Por que que não foi aproveitado, deste então? Nós retomamos, ainda bem, retomamos, e isso deve ser louvado no ambiente do Ministério da Educação - esse grupo de trabalho, para que cheguem a cabo novas iniciativas e novas reflexões sobre o processo de formação médica.

Então, em 2019, houve a transição do modelo através da Lei nº 13.958, instituindo o Programa Médicos do Brasil, alternando substancialmente a forma de seleção e de contrato com os profissionais médicos.

E foi falado, aqui - desculpe pelo tempo adicional, senhores, mas é preciso -, foi falado sobre o espírito da lei, sobre como que a lei, em 2013, ela foi formulada, ela foi redigida e ela foi comportada em relação à sociedade naquele momento. E a sociedade, em 2019, pediu outro modelo, e foi apresentado outro modelo.

O modelo de contratação médica que está na lei de 2013 foi substituído. E o modelo que está, da abertura de editais, foi suspenso.

Então, essa é a comparação que eu trago para vocês em relação ao que pode acontecer: uma política que já está suspensa, em processo de transição, como propriamente diz a lei - e falo de uma forma muito respeitosa, respeitando todas as posições contrárias; uma vigência transitória - falei que a exclusividade da abertura de cursos.

E algumas evidências, para finalizar.

O MEC retoma a formação médica criada em 2018, em 2022, quatro anos de inatividade da temática. Nós tivemos, não deixou de processar pedidos de aditamentos de aumento de vagas pelo sistema regular de oferta dos Mais Médicos ou pelo sistema normal, até, obviamente, a vigência de 2018.

No Poder Executivo, cria-se programas. Criam-se programas de abreviamento ou, pelo menos, de antecipação de formação dos médicos para atender a Covid-19, e vários outros pontos discricionários de atuação do Poder Executivo.

Então, enfatizo: o Ministério atuou nas duas vias, o programa foi substituído pelo modelo, o programa Mais Médicos atingiu as metas estabelecidas, a Portaria 328 não sofreu contestação no plano do Poder Judiciário. Nunca sofreu, eu desconheço, eu posso até estar falando algo errado, equivocado, mas a portaria de suspensão dos editais não sofreu nenhum revés.

Não houve avanço, em 4 anos de GT de formação, e a retomada, em maio, através da tomada de subsídios, obviamente, do grupo de trabalho, sendo assim feito.

O Tribunal de Contas da União liberou o Edital 6, de 2014, depois de dois anos de julgamento, de sobrestamento, indicou caminhos para o MEC. E o TCU entendeu, em parecer técnico, que as duas vias são viáveis e devem coexistir.

Além do mais, as mantenedoras do Edital 6, de 2014, e o Edital 1, de 2018, assinam compromissos com o Ministério da Educação. E um deles, por exemplo, menciona que é proibida a transferência de mantenças até o processo de reconhecimento dos cursos. Ou seja, trazendo mais uma vez a lei dos Sinaes para o ambiente da Lei dos Mais Médicos.

Além disso, o poder discricionário do Poder Executivo, frente aos problemas apresentados, faz com que essa solução hoje, senhores, ela pode ser trabalhada, e ela poderia ser trabalhada, no ambiente do Poder Executivo, no ambiente discricionário do Ministério da Educação. E assim não foi.

Agora, temos a oportunidade, que foi colocada pelos Ministros, aqui falada pela Secretária de Regulação, que está sendo trabalhada, e vamos apresentar, vamos conhecer o que vai ser apresentado. Mas esse problema aconteceu porque não existiam caminhos tanto para a livre iniciativa quanto para eu exercer direitos que são amplamente consagrados na Constituição e na legislação infra.

E, por final, o entendimento que eu acredito que esse ponto seja uma eventual *sham litigation*, que esteja sendo utilizado o ambiente do Poder Judiciário para resolver problemas concorrenciais ou, pelo menos, que poderiam ser trabalhados num outro ambiente, numa outra discussão que não simplesmente ou meramente o ambiente no qual se apresentam, mas tem a sua grande valia.

De todo caso, eu agradeço imensamente a oportunidade de apresentar esses tópicos e esses temas. E reforço que o Ministério da Educação assim como o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior possuem normas que acompanham os cursos de Medicina. Se elas não são suficientes no olhar da sociedade civil organizada, do poder público local, municipal, estadual, que fazem muito da gerência particular desses cursos, elas devem ser revistas em todos os momentos. E o que foi colocado aqui, que eu gostaria até de enfatizar, é que tudo isso, a verdade transitória de uma ciência, assim como é a Ciência Política, assim como é a Medicina, assim como é a regulação educacional, ela acontece permanentemente nos seus processos de revisão.

É isso que eu gostaria de deixar como nossa contribuição e experiência em relação a esse caso. Eu agradeço imensamente a oportunidade e o tempo adicional.

Obrigado.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Doutor Henrique Sartori, muito obrigado pelas contribuições. Passo a palavra ao Doutor Luiz Carlos Sobania, que falará pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

O SENHOR LUIZ CARLOS SOBANIA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) - Primeiramente, gostaria

de cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Ministro Gilmar Mendes, por essa convocação tão importante para decisões que se tornam urgentes - não emergência, mas urgentes com toda a certeza.

Foi grande a minha felicidade em ouvir todas as pessoas até esse momento sobre o assunto e acredito que o Ministro vai ter subsídios suficientes para tomar uma decisão.

Estou representando aqui o Presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o Professor Doutor Jorge dos Santos Silva, e a Comissão de Políticas Médicas da nossa sociedade, por isso que eu estou aqui. Como foi muito comentado, vou tentar ser breve.

Sou um Professor Titular aposentado da Universidade Federal do Paraná, ex-Diretor do Hospital de Clínicas da Universidade Federal e, no momento, sou membro da Comissão de Saúde da Justiça Federal do Paraná, representando o Conselho Regional por ter sido presidente no passado.

O ensino médico passa por uma transição, provavelmente, por um mercado de trabalho complicado. Muitos dos egressos de faculdades de medicina tradicionais, após se graduarem, não querem exercer a profissão de médico - médico mesmo! -, muito bem definido pela Ludhmila e pelo Lutaif, o que é ser médico. E isso é realmente muito preocupante.

Muitos médicos vivem apenas de Pronto Atendimento. Um plantão aqui, um plantão lá, um plantão em outro lugar, e ele tem um sustento suficiente para não fazer mais nada. Ele só faz um atendimento. E, cada vez esse cara que está ali atendendo, quem é? É o residente da ortopedia e traumatologia, que faz o plantão na UPA ou na UBS para que o sistema diga "eu tenho atendimento 24 horas". E ele apenas indica o fulano ao especialista, e os planos de saúde estão satisfeitos porque dão, em 24 horas, o atendimento especializado.

Isso preocupa tremendamente quem viveu a medicina.

Trabalhei mais de 40 anos no serviço público e privado também, 8 horas no público e 4 horas no privado, 12 horas tranquilamente num dia meu passado.

Somos mais de 600 médicos, 2.6, escola de medicina e 116 hospitais universitários onde se vai ter formação. Eu fui professor no hospital universitário, batalhamos para ter um pronto-socorro e lá nós procurávamos ensinar. Hoje, o residente que vem, o candidato à residência que vem ao nosso serviço para trabalhar como residente não sabe nem o que é a abrangência da traumatologia e ortopedia.

Traumatologia é atenção primária de urgência e emergência, isso é atenção primária; e se eles não tiverem alguém capacitado, nós iremos ter problemas. E é só nós olharmos. Na traumatologia, a maior intensidade de morte

de 5 a 14 anos é no trauma; no acidente de trabalho, também nós vamos ter uma enormidade. E ele não sabe nem o que é isso?

E, aí, nós temos a atenção básica de saúde, a UBS. O médico que está lá, acredita-se que ele teve uma formação médica suficiente para atender na UBS.

Não tem! Porque, se tivesse, eu, cirurgião, não teria que fazer uma série de procedimentos que a UBS poderia resolver tranquilamente na minha área, seja aquela dor de ombro que está começando, seja na lombalgia que está começando, seja no túnel do carpo que está começando. Tem medidas conservadoras que tem de saber. Se nós não tivermos uma educação continuada dos médicos da UBS, nós estaremos muito, muito...

E nós temos uma formação ainda na ortopedia. Um residente de ortopedia leva três anos para se formar em ortopedia e em traumatologia. Nos outros países (eles vivem comparando com outros países), o ensino da ortopedia já está em 4 a 5 anos.

E nós vemos isto que eu já falei agora: o que se paga para a bolsa do residente ficar no serviço é pouco. E o que ele vai fazer? Esses plantões de primeiro atendimento nos hospitais públicos e privados.

Não temos uma avaliação para os egressos de curso de Medicina como tem qualquer outro produto que se disponibiliza no mercado. Existem regras enormes. Se hoje vai num supermercado, você tem regras de produção, regras claras do que tem de entregar, se não entregar, eu entro na justiça como um consumidor. Nós, não! Não estamos preocupados com essa saída. Esse egresso não tem importância**.**

E aquilo que foi falado: fazer uma avaliação depois de formado? Não, meu Deus do céu! A avaliação tem de ser intramuros, dentro daquilo que se falou: dois anos, quatro anos, que a Ludhmila falou, seis anos. E, se não estiver passando nessa avaliação, a escola que segure. Ela vai trabalhar para que eu possa expulsar esse aluno, o que acontece normalmente, desde o meu tempo de formação. Dos 120 que entraram na Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Pará, todos se formaram. Todos, portanto, eram excelentes profissionais, o que não acreditamos.

E mais isso que eu falei: atender o público sem o conhecimento aprofundado da profissão. Praticamente todos os alunos que entram na faculdade se formam numa profissão que cuida e cura seres humanos.

Após a avaliação de órgãos de controle, muitas escolas, a meu ver, tratam esses alunos como mercadoria. E eu fico preocupado, porque a indústria

também, na minha área, na área de metais de ortopedia, placa para cá, placa para lá; se for examinar hoje as placas para uma fratura simples no punho, tem mais de 50 placas pra mesma coisa. E, no meu passado, dois fiozinhos de Kirschner resolviam com uma anestesia local. E mostram os trabalhos recentes, por evidência, que o resultado é praticamente o mesmo.

Temos um país gigantesco, sem política de descentralização. Milhares de ambulâncias cruzam o nosso país levando o paciente do SUS com doença de média complexidade a grande para os centros. Falta uma política de descentralização. Foi a fala de todos que aqui estiveram. Falta isso aqui.

Aí, eu lembrei que o Juscelino Kubitschek criou Brasília, e no meio do oeste brasileiro. Como é que ele trouxe as pessoas aqui? Foram descentralizados, vieram médicos do Rio, médicos de São Paulo, médicos de Belo Horizonte, centenas de profissionais. Como ele fez isso? Deu condições de trabalho. A primeira foi uma remuneração bem maior: "Bom, eu vou lá, porque eu comecei, recém-formado, não tenho família ainda, vale a pena eu começar".

Aí, eu lembro que esse grupo de médicos na minha área formou o Sarah Kubitschek, e quem cuidava era o Campos da Paz, já falecido. Criaram, enviaram aqui, e muitos deles estão vivos até hoje, mostrando que a descentralização é possível. Há necessidade de um desejo político.

E aquilo que já foi falado aqui: a remuneração. Uma consulta médica especializada no SUS, 20 reais, tirando imposto de renda e mais um pouquinho, não vai querer. Então, não tem médico querendo atender SUS. Se possível, ficará na área privada.

Então, é isso. Também deve-se olhar esse lado. Eu, falando com o candidato que conseguimos que fosse eleito para a Câmara Federal, médico: quatorze anos sem reajuste e um sistema de contratualização com o hospital do qual o médico não participa. A direção decide quantas cirurgias ele vai fazer. Ele vai conseguir fazer?

Eu representava, na universidade - e nós criamos isso -, eu, médico, estou presente na discussão do que nós podemos ou não podemos fazer. Nós sabíamos que, se fizéssemos um transplante de fígado, o Hospital de Clínicas ganhava vinte mil a mais para fazer isso. Agora, não dava tempo, nós tínhamos que atender toda a atenção secundária do estado, enquanto outros hospitais faziam só a alta complexidade porque pagava melhor.

A avaliação de alunos. Necessita avaliação enquanto estudantes.

A qualidade de seus professores, autorizando cursos sem professores. Foi falado várias vezes aqui. Ninguém está formando mestrado. Para ensinar, não é um médico normal. Para ensinar, tem que ser um médico diferente.

E estão formando, nesses hospitais, profissionais que não têm nenhuma consciência de fazê-lo

Esperamos que o Supremo Tribunal Federal nos ajude a melhorar a qualidade da medicina brasileira. No trabalho encaminhado a esta Corte, a Sociedade fez várias considerações para chegar a várias conclusões, que foram encaminhadas também como documento.

Não há falta de médicos - e alguma coisa se discutiu -, mas está faltando qualidade indiscutivelmente! Eu sou profissional, e faço cirurgia da mão, e vejo que eu atendo um montão e perco tempo cuidando de coisinhas que a atenção primária tinha que resolver, quando eu sou o indivíduo que vai cortar, que vai operar, que vai fixar fratura,

E olhem: nós temos a telemedicina. Eu, na universidade, posso ser o amparo do cara que está lá na UBS. Liga para mim! Nos Estados Unidos se faz isso, em outros países se faz isso.

Então, entendemos que há, no Brasil, número mais do que suficiente de vagas em curso de medicina. Temos convicção de que a prioridade do MEC deva ser a de garantir a qualidade dos cursos oferecidos pelas escolas médicas, formando bons profissionais, sejam eles generalistas, sejam especialistas. Cabe ao Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde organizar um modelo de assistência médica, oferecendo condições adequadas para o trabalho

médico e das equipes multiprofissionais, favorecendo a interiorização dessas equipes multidisciplinares.

É responsabilidade da esfera federal, estadual e municipal facilitar e promover a qualificação dos médicos generalistas envolvidos na atenção básica, que não estão [ininteligível], porque não se formaram o suficiente para isso.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia se coloca à disposição para contribuir no que for necessário para a melhoria da assistência.

E aí, como falou Socorro, eu vou lembrar o que você me disse que você não conseguiu falar. Falou-se aqui: não é mais médico generalista, precisamos de mais especialista. E nós ficamos preocupados: cursos de pós-graduação de 360 horas para formar um especialista, quando nós levamos três, quatro anos para formá-lo. Médico: seis anos de medicina, três a quatro anos de residência, depois disso é que ele entra no mercado de trabalho. Não é fácil a vida do médico atual.

Espero que este Tribunal ajude a resolver esse problema e está bem subsidiado por todas as apresentações que eu vi até agora.

Obrigado por me aguentarem!

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor Luiz Carlos e, desde já, passo a palavra ao

Doutor José Lúcio Machado, que falará pela Associação Nacional dos Centros Universitários.

O SENHOR JOSÉ LÚCIO MARTINS MACHADO (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS) - Boa tarde a todos e a todas!

Excelentíssimo Ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, demais autoridades presentes.

Sou professor doutor em cirurgia há 35 anos. Trabalho como especialista e pesquisador em educação médica, há 25 anos, apoiando a implantação de cursos de Medicina, entre os quais já apoiei 56 cursos de Medicina funcionantes no país. Atuei na capacitação de 3.200 professores de Medicina e metodologias ativas. Atualmente, dirijo, como diretor médico, um *cluster* de 14 escolas médicas, intitulado Inspirali, e cursos de pós-graduação ligados ao IBCMED.

Minha fala vai tentar responder a três questões, solicitadas pelo Excelentíssimo Ministro, que dizem respeito à escassez de médicos, à Ação Direta de Constitucionalidade 81 e à qualidade na formação médica.

Estou aqui representando a Associação Nacional dos Centros Universitários, na pessoa do seu Presidente, Professor Arthur Sperandéo Macedo.

A escassez de médicos é um problema de amplo conhecimento público, retratado também nas políticas da área de saúde e educação. A criação do Sistema Único de Saúde reconhece o direito à saúde em todos os níveis de assistência em nosso país. Desde 1990, a formação de profissionais médicos, por parte das instituições de educação, não preenche as reais necessidades do Brasil com, aproximadamente, 215 milhões de habitantes.

Em uma perspectiva histórica mais recente, nos últimos 10 anos, mais de 1.900 municípios possuíam, em 2012, menos de um médico para cada três mil habitantes. Hoje, a proporção de médicos para atender a população brasileira ainda é bem inferior à meta da OCDE de 2012, de 2,7.

Em agosto de 2022, estavam atuando no sistema de saúde brasileiro um total de 478 mil médicos. De modo geral, 41% dos médicos atuam nas 27 capitais, onde residem, aproximadamente, 24% da população, restando para os demais municípios brasileiros, onde residem 76% da população, o percentual de 59% dos demais médicos em atuação nos serviços de saúde.

As instituições públicas e privadas formam médicos generalistas e especialistas por meio da residência médica. Os 388 cursos de graduação em Medicina, conforme dados do cadastro do e-MEC do Ministério da Educação, com 41.825 vagas autorizadas, ainda estão longe de formar profissionais para atender o

parâmetro de 3,5 médicos por mil habitantes, de acordo com os novos parâmetros, de 2022, da OCDE.

O Programa Mais Médicos não alcançou ainda o proposto na Lei nº 12.871, pois segue em curso a desigualdade na distribuição de médicos - apesar da melhora dos indicadores -, evidenciada com a pandemia da covid-19, com a falta de atendimento a boa parte da população brasileira.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID estima que América Latina e Caribe terão que formar um significativo número de novos médicos e enfermeiros até 2040 para suprir as necessidades de sua população advindas da modificação de suas pirâmides etárias.

Nesse sentido, estima-se que só o Brasil precisará ter em torno de 1 milhão e 240 mil médicos em 2040, para dar conta da demanda decorrente da mudança de perfil epidemiológico da população, devido ao seu envelhecimento, à prevalência de doenças crônicas degenerativas e também às doenças emergentes originárias das mudanças climáticas e da degradação do meio ambiente.

Acerca do caso da Ação Direta de Constitucionalidade 81, em curso no Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, partindo-se do princípio de que a Lei do Mais Médicos cria apenas e tão somente um programa governamental, vinculado às políticas públicas de saúde e balizado pelos princípios

que regem o direito à saúde, não há razão alguma para discutirmos a constitucionalidade da Lei do Mais Médicos.

Considerando o dispositivo legal do art. 3º da Lei do Mais Médicos, que institui o denominado programa como norma constitucional, que possui hierarquia maior e há de ser observada pela legislação infraconstitucional, observa-se que, em princípio, não padece de inconstitucionalidade - embora deva ser interpretada em conformidade com nossa Carta Magna.

Em simples análise do texto constitucional, a teor dos arts. 22 e 24, respectivamente, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e, concomitantemente, sobre educação, sendo que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de leis inferiores no que lhe for contrário.

Adicionalmente, verifica-se, no Capítulo III, que trata especificamente da educação, que a Constituição também prevê expressamente, no art. 206, VII, que um dos princípios que regem o ministério do ensino é a garantia do padrão de qualidade.

A Constituição, nos arts. 22 e 206, remete-nos às normas gerais da educação nacional, em que serão afixadas diretrizes e bases. Há que se buscar na referida lei, a LDB, os critérios e requisitos para autorização de cursos superiores e respectiva avaliação, tendo em conta inclusive a autonomia universitária

assegurada pela Carta Magna. Acerca do tema, a LDB é clara ao prever, no art. 53, que:

> "Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
>
> I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;
>
> [...]
>
> IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;"

Portanto, o art. 3º da Lei nº 12.871/2013 não padece, em princípio, de inconstitucionalidade, mesmo porque, em momento algum, prevê que somente por meio de chamamento público previsto no Programa Mais Médicos dar-se-á o processo de autorização e reconhecimento de cursos de graduação em Medicina.

A via do chamamento público, ao que nos parece, é apenas uma das portas possíveis para postular a autorização de um curso de graduação em Medicina. Jamais poderia a lei específica de um programa, o Mais Médicos, revogar ou restringir direitos constitucionais e legais assegurados às universidades, seja na Constituição, seja nas leis gerais de educação em que fixadas as diretrizes e bases.

Pensar o contrário é conceder ao poder público poder tirânico, puramente discricionário e arbitrário, que, na prática, inviabilizaria a autonomia universitária e revogaria, por lei específica, normas gerais da educação, outorgando

ao Estado o poder de impor, a seu mero alvedrio, as praças e condições mercadológicas em que poderiam funcionar cursos de Medicina - interpretação que colidiria também com as garantias constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, consagradas no art. 170 da mesma Carta Magna.

Nesse sentido, há que se registrar por último que, pra não violar tais princípios, deveria o poder público uniformizar essas políticas públicas, estabelecendo os mesmos requisitos e condições, seja no processo de autorização/renovação, previsto na LDB, seja naquele previsto no Programa Mais Médicos - cuja adesão é voluntária -, de forma a não gerar disparidade de armas no processo de livre iniciativa e livre concorrência, de forma a privilegiar alguns competidores e seus estudantes em detrimento de seus concorrentes.

Por fim, propomos as seguintes questões:

A Lei do Mais Médicos traz ambiguidades por não excluir taxativamente a possibilidade de haver outros processos que contemplem a abertura de novos cursos de Medicina ou de ampliar o número de vagas nos cursos preexistentes.

O Programa Mais Médicos prevê editais de chamamento público para municípios a serem pré-selecionados e, posteriormente, editais de

chamamento público para mantenedores privados que queiram se candidatar a ter cursos de Medicina na área pré-selecionada

Há cinco anos não há mais editais. Na ausência de políticas públicas necessárias, é natural que a sociedade busque resguardar seus direitos e necessidades na Justiça. É natural e legítimo.

Os mecanismos regulatórios do Estado, dentre os quais a formulação e implementação de políticas públicas, devem cumprir o papel de induzir processos de mudança que garantam os interesses da sociedade brasileira - no caso a ampliação do acesso à população a recursos de saúde com qualidade e acesso à população a médicos com formação de qualidade, orientada às necessidades do SUS.

A nosso ver, no mundo atual, a regulação do Estado deve ser orientada para a qualidade da formação médica e as necessidades sociais, sustentada pelas seguintes bases:

I - critérios de qualidade estabelecidos pelo MEC tomando por base a política do Mais Médicos, previstos nos editais de chamamento público, tanto para a seleção de locais necessários quanto para instituições de ensino superior que se candidatem aos editais para abertura de novos cursos em locais de necessidade social;

II - critérios de qualidade estabelecidos pelo MEC - SINAES na avaliação das proposições sustentadas por projetos apresentados pelas IES de implantação de novos cursos em locais por elas sugeridos e seguindo os mesmos critérios dos editais do Mais Médicos;

III - provas de licenciamento e habilitação profissional, por meio da certificação e recertificação profissional, a serem propostas e implementadas pelo Conselho Federal de Medicina, no sentido de dar fé pública aos médicos diplomados e garantir a segurança das pessoas que estarão sob cuidado dos recém-formados;

IV - implantação efetiva do sistema de acreditação das escolas médicas, por meio de um SAEME com funcionamento contínuo, ágil em sua consecução e direcionado pelo Conselho Federal de Medicina.

Com essas quatro ações, não excludentes, ganham todos: o país, com escola médicas funcionantes com qualidade; a população, atendida com segurança; a livre iniciativa, que vê seus direitos de propor locais e projetos de abertura de cursos onde haja necessidade; o MEC, que continua a exercer seu legítimo direito de induzir a formação médica por meio de políticas públicas e de criar e implementar critérios unificados de avaliação de projetos de novos cursos, baseados na qualidade e na necessidade social.

Não somos contra a política do Mais Médicos. Somos contra o controle de mercado proposto pela Anup, que defende a política do Mais Médicos como a única forma de acesso à avaliação de novas propostas.

A Lei nº 12.871, que institui a política do Mais Médicos, a nosso ver, só será inconstitucional se fechar a possibilidade da livre iniciativa de propor projeto de criação de novos cursos sem ao menos avaliar as propostas à luz dos critérios de qualidade que o próprio MEC venha a criar e aplicar aos processos. Garante-se ao Estado traçar políticas pública, regular ofertas, avaliar e receber a postulação de novas iniciativas de projetos.

O que impediria o MEC de estabelecer os mesmos critérios de avaliação de projeto de novos cursos, vindos de vias e possibilidades distintas? Tanto por editais de chamamento quanto por postulações da livre iniciativa, utilizando-se o mesmo arcabouço avaliativo para ambos os processos, caberá sempre ao MEC estabelecer critérios de avaliação e dizer que a régua de aferição é uma só para as duas portas de entrada de processos. É nisso que a Associação Nacional de Centros Universitários acredita e postula ao Supremo Tribunal Federal.

Muito obrigado!

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor José Lúcio Machado!

Passo a palavra ao Doutor Dante Escuissato, que falará pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, na modalidade virtual.

O SENHOR DANTE ESCUISSATO (COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA) - Antes de mais nada, quero agradecer muitíssimo a oportunidade de participar desta audiência pública. Saúdo o Ministro Gilmar Mendes por essa iniciativa extremamente válida, de um assunto tão relevante para a sociedade como um todo.

Não irei repetir muito daquilo que já foi colocado por vários dos palestrantes anteriores, mas frisarei algumas questões que nós, do Colégio Brasileiro de Radiologia, o qual represento como vice-presidente, consideramos ser muito importantes.

Em relação aos cursos de Medicina - a Doutora Lúcia Braga frisou também -, assim como outros cursos da área de saúde, é fundamental que se tenha parâmetros de qualidade periodicamente auditados. Os cursos devem desenvolver necessariamente não apenas a educação, mas também a pesquisa e extensão, que também são parte das atividades da universidade e dos cursos universitários. Consequentemente, todas essas atividades deverão ser constantemente controladas.

O que recomendamos é algo que já foi colocado anteriormente, tanto na avaliação de alunos, com provas - como o Doutor Sobania colocou

anteriormente - ao longo do curso de Medicina, dos estudantes, e também ao término do curso, quanto avaliação das estruturas dos cursos, de tal forma que se verifique se todos os instrumentos necessários para que o aprendizado seja atingido de forma adequada estejam presentes e sendo fornecidos para esses estudantes.

Os docentes - isso também foi comentado pelo Doutor Sobania - devem ser adequados tanto em número quanto em formação. Muitas vezes, em muitos locais, considera-se que há condições de abertura de um curso de Medicina, levando-se em consideração a presença de especialistas naquela cidade. O problema é que muitos desses indivíduos não necessariamente estão qualificados para o exercício do magistério. Se você não fornece profissionais em número e qualidade adequados, necessariamente será comprometida a formação desses novos profissionais.

É fundamental que saibamos o que eles têm de aprender. Há habilidades básicas, e essas habilidades também deverão ser monitoradas, e isso deve ser monitorado pelas instituições do governo, por aqueles que certificam e também permitem a manutenção ou não dessa certificação.

Entre essas habilidades, na área de saúde, cito não apenas conhecer a doença, mas também formar e estruturar o diagnóstico dessas doenças e o tratamento adequado. Isso vai levar os indivíduos a serem indutores da saúde naquela comunidade em que estão incluídos.

De outra forma, indivíduos, mesmo em número grande, mas mal formados, serão indutores mais da doença do que da saúde. Essa é uma situação muito importante.

Todos temos o direito à saúde, mas de qualidade, ou seja, indivíduos com formação. Acho que temos que ampliar não apenas os médicos, mas os outros profissionais da saúde: enfermeiros, dentistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos. Todos esses profissionais devem ter formação adequada, para que entreguem à população aquilo que é necessário, não apenas na rede pública, mas também na rede privada. Na rede pública, isso é fundamental, porque é onde a população mais carente será atendida. Se ela for atendida por profissionais qualificados, isso vai, inegavelmente, reduzir os custos para o Estado como um todo. Ou seja, o nosso sistema SUS não vai ser sobrecarregado por mais um fator de estresse - profissionais não qualificados que, por exemplo, não saibam formular um diagnóstico e levem a situações em que, quando esse diagnóstico for feito, será em condições inadequadas para um tratamento que seria, eventualmente, curativo.

Como representante de uma sociedade médica de especialidade, observamos que, ano após ano, as instituições que têm formado ou fornecido melhor formação são aquelas que entregam profissionais para entrar em um programa de residência. Também aí criamos situações em que os profissionais mais bem formados nas faculdades também terão acesso aos melhores programas de

formação de especialistas. Nesse sentido, aqueles que estão em cursos em locais menos qualificados, sem estrutura, realmente vão ser duplamente penalizados.

Nesse sentido, temos que olhar para todo esse conjunto, pensando também nessa questão, porque a quantidade de médicos não necessariamente representa a qualidade do serviço entregue.

Como o Colégio Brasileiro de Radiologia é uma das entidades associadas à Associação Médica Brasileira, quero reforçar nossa posição, em sintonia com a própria AMB, como nas posições colocadas pelo Doutor José Eduardo Dolci, que falou na sessão anterior.

Mais uma vez, quero agradecer muitíssimo ao convite. Espero e coloco o Colégio Brasileiro de Radiologia à disposição para qualquer posição ou contatos que sejam considerados adequados.

Estamos à disposição realmente para colaborar.

Muitíssimo obrigado!

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor Dantes Escuissato pela contribuição e já passo a palavra à Doutora Cristina de Menezes, que falará pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

A SENHORA CRISTINA MENEZES (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA) - Eu gostaria muito de agradecer ao Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes pelo convite a nossa sociedade.

Meu nome é Cristina Menezes, eu falo como Vice-Presidente, em nome da Doutora Professora Lydia Masako, que é a nossa presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Como eu já estou, lá, no final, e a nossa especialidade é uma subespecialidade, a gente não está dentro da área básica, eu gostaria de resumir, um pouco e não ser tão repetitiva. Então, eu vou reduzir aqui a minha fala.

Eu estou representando, já falei, a Sociedade. Esta audiência, realmente, é uma audiência extremamente importante. Nós ficamos muito felizes pelo convite. E quero dizer que nós concordamos com todos os comentários que são favoráveis à necessidade da regulamentação do ensino médico através de políticas públicas com o auxílio, ou não, da iniciativa privada, porque, uma vez que a iniciativa privada está instaurando faculdades, escolas de Medicina, por que não participar, com o Governo, com a atividade pública, e favorecer um pouquinho esses hospitais que a gente tanto necessita? E isso, tanto dentro da área básica quanto na formação dos especialistas, os nossos especialistas, em subespecialidade, que é o nosso caso.

Então, eu vou me resumir, um pouquinho, aqui, o que é a nossa sociedade, o que nós fazemos.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, atualmente, tem uma média de 6.500 participantes no Brasil. Eu falo uma média porque existem cirurgiões plásticos, poucos, pouquíssimos, que não estão vinculados à sociedade.

Dentro da sociedade, nós temos 88 serviços de formação de serviços de residência, credenciados tanto pelo MEC quanto pela Sociedade, e nós somos vinculados à AMB. Então, os nossos residentes são avaliados, no final da formação, pela Sociedade, com aval da AMB.

Então, no final dessa formação, o que que nós temos de mais importante? A cirurgia plástica, na verdade, não é só cirurgia estética. Nós damos muito mais importância à cirurgia reparadora, que é a base para a cirurgia estética.

Então, dentro da cirurgia reparadora, nós necessitamos de especialistas em queimaduras, trauma. Como o doutor falou, no trauma, na ortopedia, a cirurgia plástica entra muito em trauma. Então, nós necessitamos dessa formação básica em trauma, em emergência, em urgência, porque faz parte da formação da gente e faz parte da nossa atividade mesmo, em si.

Queimados, traumatologia, que eu já falei, na oncologia, que é, assim, muitíssimo importante. E eu acho que atualmente é a área que mais falta

especialista. Na verdade, talvez, nem especialistas, o que falta são unidades para que a gente possa dar suporte aos oncologistas, aos cirurgiões oncológicos.

Então, cirurgia de cabeça e pescoço é importantíssimo, porque os pacientes são realmente mutilados. Mutilados, entre aspas, porque os tumores... muitas vezes as pessoas não têm acesso aos centros maiores e, quando chegam, já chegam com tumores enormes, atingindo a face. Que, aí, eles perdem olhos, nariz, boca, tudo de uma vez. E, aí, necessita do microcirurgião, que é o cirurgião plástico especialista em fazer os transplantes. Então, a gente tira tecidos da perna com a parte óssea, muscular, pele, e reconstrói toda a parte da face. Tanto quanto mama, cirurgia oncológica geral, mastologia, enfim todos os oncologistas necessitam, no final, de um cirurgião plástico.

E na área de queimados, por exemplo, nós necessitamos também dos centros de tratamento de queimados, nós necessitamos de banco de pele. Nós já temos dois bancos de pele no Brasil, todos dois no Sul.

E a formação do crânio-maxilo-facial, que é o cirurgião plástico que trata das deformidades congênitas nas crianças. Então, todo neurocirurgião pediátrico, na verdade, trabalha com um cirurgião plástico formado em crânio-maxilo-facial.

Bom, essa é a explanação que eu gostaria de dar a vocês. Concordamos com a opinião da AMB, em que a qualidade, no momento, é mais

importante do que a quantidade. E eu gostaria muito de agradecer a participação, nesta audiência pública, e já deixei o nosso recado.

Muito obrigada.

Passo a palavra ao Doutor Paulo Chanan, que falará pela Associação Brasileira de Mantenedoras das Faculdades Isoladas e Integradas.

O SENHOR PAULO CHANAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DAS FACULDADES ISOLADAS E INTEGRADAS) - Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, a quem aproveito e cumprimento todas as autoridades aqui na Mesa, meus queridos colegas, senhoras e senhores.

Primeiro, agradecer o convite feito à Abrafi e, por conseguinte, a possibilidade de conhecermos aqui mais profundamente, pelas explanações do primeiro bloco todo da manhã, a real condição em que se encontram determinados cursos de Medicina e a preocupação que as associações e todos os conselhos têm em tratar a questão que, seguramente, dependerá de novas políticas públicas, que não me parece ser o caso da presente ADC. É por isso que a Abrafi vai se concentrar em tratar essa questão.

Então, o que se observa nesse processo, de fato, é a busca por uma declaração de constitucionalidade, até porque a ADI 5.035 já deu conta disso quando declarou a constitucionalidade através do indeferimento daquele pedido.

O pano de fundo, de maneira inequívoca, é uma tentativa de impedir que se amplie a oferta de cursos de Medicina, a despeito de tudo que se sabe sobre a falta de médicos no Brasil, para garantir uma fatia de mercado para aqueles que já detêm a maior parte desse mercado.

Isso fica claro quando o pedido da ADC se preocupa sobremaneira em paralisar e colocar fim a todas as ações judiciais em curso sobre o tema, inclusive alcançando reflexos em processos administrativos correlatos.

Ora, se existiam dois caminhos para se conseguir autorização de um curso de Medicina no Brasil - que era o Mais Médicos, a partir de 2013, e, antes dele, o Protocolo e-MEC -, se os dois foram fechados, o que resta ao administrado, senão o Poder Judiciário?

Fica perturbadora a pergunta de por que uma associação de classe se volta contra a maioria do setor ao qual está inserida. Resposta, por evidente, aproxima-se do questionável desejo de se criar uma reserva de mercado de controle concentrado de constitucionalidade.

Por oportuno, frise-se que a autora dessa ADC não fala nem poderia falar em nome de todo o setor. Objetivando concentrar o mercado, o que a autora busca é obter uma solução pública e coletiva a um problema que é individual e privado. Buscando acabar com ações em curso e seus efeitos, a autora pretende se

ver livre de enfrentar caso a caso as ameaças que o próprio mercado faz aos seus interesses comerciais.

Para tentar evitar argumentos já trazidos nesta audiência pelos outros participantes, e muito bem colocados, a Abrafi vai colocar foco na questão da qualidade da oferta dos novos cursos. Como afirma a inicial, o processo regular pelo caminho da Lei do Sinaes promove uma desordem no sistema e a oferta sem qualidade de novos custos se comparado à oferta advinda da pela via do Mais Médicos.

Ora, somente quem está a ler os processos que envolvem autorizações de cursos de Medicina no Brasil pode expor tamanho absurdo. Primeiro, porque a convivência do chamamento público da Lei do Mais Médicos e as autorizações pela via do Sinaes nunca foi inviabilizada. Podem conviver de maneira harmoniosa, sem qualquer prejuízo à população e ao mercado de ofertas. Aliás, é salutar que convivam.

Nesse sentido, o Governo Federal, a qualquer momento, através do MEC, pode identificar municípios a serem beneficiados pelo chamamento público, lançar o edital, e as instituições que tiverem interesse poderão participar da concorrência pública. Nem por isso há que se falar em precariedade de oferta. Importante um parêntese aqui para afirmar que nenhuma decisão judicial concedida - e isso preocupa, porque foi colocado diversas vezes pela manhã -, todas

as que a Abrafi tem conhecimento, e são mais de 100, todas as decisões, nenhuma delas, que são condenadas aqui nessa ADC, ordena a abertura de novos cursos de Medicina sem qualidade. Nenhuma ordem a abertura de curso sem qualidade. Muito pelo contrário.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Doutor, um segundo por favor. Queria pedir à plateia que, como já orientado algumas vezes, não se manifeste enquanto as pessoas estiverem discursando, mesmo que seja em apoio, é uma falta de respeito com o Tribunal e com todos que estão aqui assistindo. Por favor, doutora?

O SENHOR PAULO CHANAN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DAS FACULDADES ISOLADAS E INTEGRADAS, ABRAFI) - Muito ao contrário, as decisões somente determinam que o Ministério da Educação abra e percorra todas as etapas inerentes ao processo de autorização de curso. A decisão de autorizar ou não, após o curso processual regular pelo Sinaes, é exclusivamente do MEC. Em outras palavras, as decisões não fazem mais do que reconhecer direito de petição, determinando que o administrado avalie os pedidos formulados dentro dos parâmetros de qualidade e dos instrumentos de avaliação de cursos vigentes no MEC. Cenário muito diverso do caos generalizado que a autora tenta defender na peça inicial.

Dizer que o MEC não tem condições de verificar, pela via do processo regular, a qualidade de oferta de um curso de Medicina é condenar toda a formação médica brasileira até aqui, porque os médicos formados e que atuam no país são advindos, em sua esmagadora maioria, de cursos que foram autorizados pela via regular. Pela via do Mais Médicos, ainda não se tem massa de formados, porque é muito recente, é uma lei de 2013. Por mais que se diga, a avaliação de curso regular pelo Sinaes tem a princípio cinco importantes etapas, até para o conhecimento daqueles que não estão tão afeitos à regulação da educação superior brasileira. A primeira delas é uma verificação documental da oferta, envolvendo projeto pedagógico do curso, confrontando o projeto com as DCNs que envolvem o curso de Medicina no país, com a Lei do Sinaes, verificação documental e instrumental do imóvel onde vai ser colocado aquele curso. Somente se essa etapa for vencida, e ali já tem um momento que o MEC pode se pronunciar e encerrar o processo de autorização de um curso pela via regular, é que se avança para uma segunda etapa, que é a etapa da avaliação feita pelo Inep. Esse é o momento mais crucial do processo e o que diferencia da regulação pelo Mais Médicos. Lá no Inep, avaliadores experientes, treinados, médicos ou da área de saúde, num processo duplo cego de escolha eletrônica e aleatória, promovem uma visita *in loco* presencial para a observação das condições gerais da oferta. Essa verificação envolve uma nova avaliação do projeto pedagógico do curso, agora confrontando-o com as reais

condições físicas, de laboratórios, de campos de estágio, toda a infraestrutura tecnológica, de pessoal, da instituição que deseja ofertar. São 55 indicadores, divididos em três dimensões, que a comissão de avaliadores disseca as condições da oferta, conversando com professores, técnicos administrativos responsáveis pelo projeto pedagógico do novo curso para a produção de um relatório final conceituando cada indicador. Conceitos de um a cinco, as médias propõem o resultado final dos conceitos das dimensões e um conceito global final. Reparem que, numa esfera de 1 a 5, somente os relatórios que contêm 4 ou 5 avançam para a próxima etapa, ou seja, só aqueles que são avaliados com excelência.

A partir daí mais três etapas, vão passar por uma verificação de impugnação ou não de relatórios, depois, parecer do Conselho Nacional de Saúde e uma etapa final do parecer produzido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Avaliação da Educação Superior, onde se encaminha para emissão de portaria de autorização ou de portaria de indeferimento.

Por outro lado, senhores, quando se observa o processo pela ótica do Mais Médicos, o que se tem é uma etapa do certame onde se escolhem os municípios e, de fato, verificam-se as questões instrumentais para aquilo e recebe uma etapa documental classificatória, onde as instituições apresentam as suas propostas. Da simples verificação dos documentos, escolhe-se um ganhador e já lhe é conferida autorização sem que haja qualquer verificação prévia *in loco* das

condições, até porque, em alguns casos, sequer há instalações físicas constituídas, existindo apenas a promessa de se construir as instalações.

A nova ofertante somente será visitada para uma verificação do Ministério da Educação aproximadamente dois anos depois do início da oferta do curso por professores convidados pela Sesu, diferentemente do Inep, que tem professores treinados e capacitados para avaliar.

Ora, evidentemente que a verificação pela via do Sinaes é que possibilita a oferta de um curso de Medicina com mais qualidade. Certamente por isso, todas as decisões judiciais legitimamente proferidas combatidas nessa ADC ordenam a abertura de um processo pela via do Sinaes com respeito a todas as etapas a ele inerentes.

Assim, com os processos pela via do Mais Médicos do Sinaes não são conflitantes, podem coexistir em benefício da ampliação com qualidade da oferta.

Como a via do Sinaes, por conter a avaliação *in loco* para verificação das condições de oferta, é seguramente o roteiro que mais permite a colocação de um novo curso de Medicina com qualidade em funcionamento; como os números brasileiros, especialmente, a pandemia do coronavírus (que deixou muito claro pra gente a explanação do Doutor Flávio, da Sociedade Brasileira de

Epidemiologia) deixaram evidenciado, existe uma carência nacional de médicos, chegando-se ao cúmulo, como se assistiu ao longo dos anos de 2020 e 21, do Governo Federal através da MP nº 934, convertida posteriormente na Lei nº 14.040, permitir que se adiantasse a formatura de estudantes de Medicina sem a devida conclusão do curso para que fossem utilizados nos hospitais de maneira profissional; como a escassez da oferta de vagas de Medicina vem produzindo distorções no mercado educacional como anunciado pela empresa Afya, associada da autora da presente ADC, na quinta-feira passada, dia 13/10, de uma aquisição por ela promovida em duas instituições ao custo de 2,4 milhões de reais por vaga de Medicina, conforme informado pelo jornal *Valor*; como incremento de novas de Medicina possibilitará a democratização de acesso a mais alunos com mensalidades mais acessíveis, garantindo a inserção de pessoas que estão excluídas puramente por sua condição econômica, já que a gente sabe o tamanho das mensalidades que se cobra no Brasil; como a autora tenta o uso estratégico da jurisdição constitucional para fins meramente particulares; como a Lei do Mais Médicos não revogou sob nenhuma hipótese e nenhuma interpretação nem a LDB, muito menos a Lei do Sinaes; como, em função do julgamento da ADI 5.035, fora do Programa Mais Médicos, com a autorização do MEC, cursos foram abertos, empregos diretos e indiretos gerados, vestibulares realizados, alunos matriculados, aulas ministradas e serviços à comunidade também, entende a Abrafi, que dar guarida à pretensão

da Anup nessa ADC é fulminar de morte o ordenamento jurídico brasileiro, lesando os direitos fundamentais não só dos alunos como o dos docentes contratados e das próprias entidades mantenedoras de educação superior, garantindo privilégios econômicos, alguns grupos educacionais, em detrimento de uma população que sofre a falta de médicos, frequenta filas intermináveis, às vezes por meses, em busca de uma simples consulta médica.

É como a Abrafi se manifesta.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) – Doutor Paulo Chanan, muito obrigado!

Passo a palavra ao Doutor Diego Muñoz, que falará pela Federação Interestadual das Escolas Particulares.

O SENHOR DIEGO FELIPE MUÑOZ DONOSO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES) – Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, Excelentíssimo Doutor Lucas Faber, por meio do qual cumprimento todas as autoridades, todas as pessoas aqui presentes.

Há quase vinte anos, o Ministro Gilmar Mendes traduziu um livro do professor constitucionalista alemão Peter Häberle sobre a sociedade aberta da interpretação constitucional. É uma felicidade ver uma audiência pública como esta, que traz exatamente essa perspectiva, passados vinte anos, na qual você ouve

toda a sociedade e não deixa que um intérprete, um juiz, um julgador simplesmente, em um ambiente, como diria o Professor Lenio Streck, solipsista, individual, no canto do seu gabinete, decida uma questão tão crucial quanto esta, sem ouvir toda a sociedade.

Queria começar dizendo: quem seria contra a melhoria de educação na área de saúde? Quem seria contra a melhoria do atendimento do cidadão? Alguém poderia ser contra os cursos terem mais qualidade? Não só os cursos de Medicina, qualquer curso. Creio que ninguém seria contra isso.

Tivemos a oportunidade de ouvir inúmeras autoridades. Até o Doutor Sandro Schreiber, que falou agora há pouco, um orador, perguntou: mas não é o SUS quem organiza e equaciona toda essa questão de saúde? A resposta é não, Doutor.

Essa é a questão crucial e essa é a questão que está sendo trazida à Suprema Corte nesta audiência pública. Ouvimos inúmeras autoridades da sociedade brasileira sob o viés da saúde, sob o viés médico, e é muito importante ouvi-los, mas creio que também é importante que a gente destaque que não há como equacionar a saúde sem que você entenda que isso tem que se equilibrar com a educação. Em vez de dizer educação, melhor dizer ensino. O ensino no Brasil não é pura e simplesmente uma questão estatal.

Gostaria de regredir um passo na questão que está sendo discutida hoje aqui porque o ponto central da ADC - e o ponto central da ADI - que está sendo colocado não é a saúde do brasileiro, não é a qualidade dos cursos, e sim a possibilidade, ou não, de o Estado, mediante ato legislativo, impor uma restrição absoluta à possibilidade de as entidades privadas atuarem nesse setor, no setor privado de ensino de Medicina. Poderia ser outro, poderia ser de Direito, poderia ser qualquer outro.

Essa é a delicadeza do tema, porque, se começarmos a pensar que essa intervenção - e foi colocado aqui pelos que me antecederam -, feita sutilmente para alguns e, para outros, de forma expressa, prevalecer, ela estará dizendo: o Estado, sem explicar por que ou dizendo, em meias palavras, genericamente, quais são as finalidades, poderá simplesmente estatizar o curso de Medicina. Esse é o nome, vamos dar o nome claro para isso. Quando olhamos a nossa Constituição, vamos perguntar: o ensino é público? Todo ensino é público! Tem natureza jurídica de direito público. Aliás, foi afirmado aqui no julgamento do Tema 548 há alguns meses. O ensino é público, a sua prestação é que é diversificada. Ela pode ser desenvolvida pelo Estado - e aí é estatal, as pessoas não gostam da palavra, mas é estatal - ou ela é promovida pelo setor privado.

Nesse ponto, gostem ou não, nossa Constituição, nosso constituinte, quando foi falar sobre o tema, não disse: "Olha, o Estado talvez te conceda a possibilidade de atuar no setor privado". Não é uma concessão. Ele teve a oportunidade de dizer isto: só o Estado pode promover o ensino. Não disse isso. Ele também poderia ter dito: "só o Estado poderá promover o ensino de Medicina, porque a saúde é importante demais para o país." Os outros também são importantes, mas ele poderia ter dito isso. Não disse.

Se ele não disse, o que foi que ele disse? Ele disse que o ensino privado tem a liberdade de promover a sua atuação. Com restrições? Com restrições, que estão no art. 209 da Constituição. Então, tem que seguir as normas gerais de educação? Com certeza. Tem que ter qualidade? Com certeza.

Escutamos inúmeras autoridades médicas falando sobre a fixação dos profissionais em seu local, sobre a promoção do melhor ensino, sobre a qualidade e a fiscalização, como se o MEC, quando usava o sistema antigo, não fiscalizasse a qualidade do ensino. Essas normas estão mantidas, elas têm que ser respeitadas por todos. Nesse ponto, se a titularidade do serviço pode ser do Estado - e ele que promova - ou pode ser do particular, qual é o caminho? O caminho é a autorização.

Quando esta lei determina um caminho único para a promoção do ensino de Medicina, é isso que ela diz. E, se ela disser isso, ela é inconstitucional. Se ela não diz isso, temos o duplo caminho, que foi muito bem exposto pelos outros - vou chegar lá sobre a questão da eficácia das duas medidas. Mas se ela diz que estão fechados para qualquer outra promoção do interesse privado no setor de ensino de Medicina, há possibilidade de você usar recursos privados, construir seu hospital, construir sua escola, contratar seus professores, e não puder? Estou falando de cursos de qualidade - não vou discutir a falta de qualidade porque já foi dito por todos, eu também defendo a qualidade.

A questão é: alguém que se proponha a pôr qualidade nos cursos e quer empreender no curso de Medicina, com essa lei que está vigendo hoje, poderá? A resposta é: o Supremo vai ter que dizer se ela é constitucional. Digo eu que não é, até porque o art. 174 da Constituição diz claramente sobre essa diferenciação - eu, que vivo há 30 anos do setor de educação, vejo todo dia se falar em concessão do Estado, e não há concessão no setor público.

Na ADI 319, que o Ministro Moreira Alves relatou, na década de 1990, discutiu-se a natureza jurídica do serviço privado. É um serviço concedido ou é um serviço privado de interesse público? Lá, foi dito que é um serviço privado de interesse público, ou seja, somente com o preenchimento de requisitos - como o Professor Ingo falou de manhã - é que se poderá intervir e restringir a atividade.

Foi feita, naquela ADI 319, uma restrição, mas se disse: para ter essa restrição, alguns pré-requisitos têm que estar presentes. Isso foi reforçado na ADI 1.226, de relatoria do Ministro Eros Grau. Lá, nos debates, em que pese o Ministro Eros Grau ter dito que o serviço educacional é um serviço público, mas não privativo, isso foi só - como diriam os doutos - *obter dictum*. Não foi julgado isso, foi só dito.

Todos os outros Ministros, quando falaram sobre o assunto, também em *obter dictum*, disseram: não, não é serviço público. Se não é serviço público, há limites, e reitero os limites que o Professor Ingo colocou de manhã. Tem que haver necessidade; tem que haver adequação; tem que haver proporcionalidade. Como foi dito pelos próprios médicos que vieram falar aqui, há necessidade.

O Ministro Gilmar Mendes questionou a vários dos oradores se a Lei do Mais Médicos, em seu art. 3º, nos requisitos de qualidade alocados, alcançaria, ainda que em tese, os objetivos propostos. A resposta dos três foi: não. Nem em tese havia a possibilidade daquela lei prosperar, no sentido de atingir o que se propunha.

Vi que muitos falaram sobre a fixação do profissional no local. Estamos falando de questões constitucionais. Vamos restringir a zero a atividade privada, e a atividade privada não poderá fazer nada, porque temos uma lei que

atingirá os objetivos de fixação. O que foi dito nesta audiência pública? Todos foram uníssonos em dizer que não atingiu. Nem poderia atingir porque o médico não quer ficar lá. A Lei do Mais Médicos não prevê que ele tenha que ficar lá. Adianta termos uma lei que reduz e restringe a zero, que não é adequada, que não se mostrou necessária - muito menos proporcional - e que não atinge seus fins? É possível que ela seja mantida em seus exatos termos?

Indo para minha abordagem final, temos uma discussão aqui sobre liminares. Ouvi muito bem os pronunciamentos da manhã falando que estas liminares estariam promovendo a autorização de cursos, a autorização de vagas. Desculpem-me, não é isso que está ocorrendo nas liminares. O que ocorre nas liminares é simplesmente o que se está pedindo que o Supremo diga aqui: ou o sistema é inconstitucional, porque fecha uma possibilidade, sem poder contornar o art. 209 da Constituição, ou ele estaria dizendo que os dois métodos são possíveis. Se os dois métodos são possíveis, o que os juízes estão fazendo é dando liminar para abrir o protocolo para que os processos tramitem.

O MEC sempre fiscalizou autoridades médicas. Muitos profissionais que falaram aqui hoje provavelmente se formaram, fizeram residência e foram fiscalizados sob o manto da legislação antiga, sob o manto da regulação do MEC antigo, o qual zelava pela qualidade. Não digo que essa qualidade é do tipo A ou do tipo B, porque não conheço o setor sob esse perfil - aprendi muito hoje -,

mas, sob o perfil jurídico, ficou muito claro que o MEC sempre fez e continua fazendo. Como foi dito sobre a discricionariedade da regulamentação, ele pode mudar a matriz curricular, sugerir alterações na fiscalização dos cursos, na fiscalização do egresso e muitas outras coisas mais. Então, para que precisa fechar em 100% a atuação do setor privado? Essa é uma questão que sei que a Corte sempre tem julgado, na ponderação sobre os limites da intervenção.

De minha parte, gostaria de agradecer a oportunidade ao Ministro Gilmar e pleitear que seja declarada a inconstitucionalidade do texto. Se não for declarada a inconstitucionalidade do texto, que seja dada interpretação conforme para que se entenda que os dois mecanismos são possíveis, tanto o sistema MEC, do protocolo direto, como muito bem exposto pelos que me antecederam, como as políticas públicas do Estado. Ele que as faça, ele não precisa pedir autorização para promover políticas públicas. Ele pode criar cursos estatais de Medicina com o arcabouço que quiser, mas não pode fechar, de forma constitucional, a liberdade que o empreendedor privado tem de empreender nesse setor.

Muito obrigado!

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor Diego Muñoz e passo a palavra à Doutora Anna

Gilda Dianin, que falará pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino.

A SENHORA ANNA GILDA DIANIN (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, digno Relator da ADC 81 e da ADI 7.187, demais autoridades que compõem a Mesa, senhores e senhoras no âmbito de suas respectivas representações.

Nas exposições que me antecederam, restou evidenciado, principalmente na dicção do Professor Ingo Sarlet, na parte da manhã, que o art. 3º da Lei do Mais Médicos não sobrevive ao teste de constitucionalidade.

Números foram expostos com valores opostos e antagônicos por aqueles que tentam justificar a constitucionalidade de uma norma em razão das circunstâncias.

E eu quero lembrar aqui que a Constituição da República, no art. 209, quando fala em qualidade, ela o faz em relação a todos os níveis de ensino, e não especificamente aos cursos de Medicina. Portanto a busca pela qualidade não é uma tarefa exclusiva da Medicina, como se quer fazer crer, porque a Medicina salva vidas.

E aí eu trago à reflexão: o que dizer do piloto mal formado que corre o risco de levar mais de 300 vidas de uma só vez ao fundo do oceano? O que

dizer do engenheiro civil que faz o cálculo estrutural mal feito e coloca em risco de uma vez só todos os moradores de um edifício?

Senhores, se a Medicina salva vidas, outros profissionais mal formados destroem vidas. E a Medicina nada poderá fazer para nos salvar, por melhor que seja o curso de Medicina. É preciso ter isso em mente. É preciso ter em mente que, como já nos lembrava o poeta John Donne, nenhum homem é uma ilha.

Ou nós brigamos pela qualidade de formação profissional, desde a mais tenra idade... Aí, é preciso dizer que é irrenunciável a tarefa do Estado de fiscalizar os serviços prestados no campo da educação. Por que estamos chegando a esse ponto aqui hoje, de ter que convocar uma audiência pública por conta dos cursos de Medicina, se todo o nosso ensino, desde a educação infantil, apresenta *deficit* estrutural em termos de qualidade? Que aluno recebemos no curso de Medicina? Que aluno recebemos no curso de Engenharia? Que alunos recebemos no Direito, como foi dito aqui mais de uma vez, que saem sem saber escrever uma petição? Isso também mata. Uma defesa mal feita conduz à destruição de famílias, à destruição dos sonhos. É bem verdade que o que se discute aqui hoje são os cursos de Medicina, mas a Confenen quer ampliar essa discussão para dizer e reforçar aquilo já dito aqui: em primeiro lugar, quando o legislador constituinte assegurou a liberdade da iniciativa privada ao particular, ele o fez estabelecendo condições. E compete ao Estado, de forma irrenunciável, fiscalizar essas condições.

Portanto, discutir se é chamamento público, ou não, é chover no molhado. A Constituição já nos dá os caminhos para a fiscalização, para a autorização e para a avaliação da qualidade do ensino, mas não é só - como direi daqui a pouco - a Constituição que assegura essa liberdade de ensino.

Antes de passar a esse ponto, quero dizer que não é através de defesas corporativistas da constitucionalidade do art. 3º, advogando a necessidade de intervenção do Estado para proteger determinados interesses, que se encontrará a solução para a deficiência de formação educacional no Brasil, incluindo aí os cursos de Medicina. A Confederação Nacional entende que a constitucionalidade de uma norma não pode, nem deve, ser aferida por circunstâncias, muito menos pelo protecionismo reclamado por determinadas categorias, porque, hoje, é a Medicina, amanhã, o Direito, depois a Odontologia, Engenharia e tudo o mais que vier pela frente.

É certo que o Estado, nos limites de sua competência, ele tem a liberdade para implementar as políticas públicas que julgar mais adequadas, conforme as carências ou necessidades de estímulos ao desenvolvimento no âmbito nacional ou regional. É induvidoso também que a preservação da saúde do cidadão através da disponibilização de mais médicos por todos os rincões do Brasil possui um apelo muito forte quando o assunto é formação do profissional de Medicina. Nem por isso a Constituição autoriza a interferência na livre iniciativa, sob o

argumento que se está a fazer política pública. Isso não se faz sem ofensa à Constituição.

Não se pode confundir, de maneira nenhuma, o Estado indutor com o Estado interventor. Toda vez que isso acontece, a gente verá essa balbúrdia relatada aqui por todos os profissionais, quer os a favor do chamamento público, quer os contrários. Por quê? Porque o Estado interferiu, e criou-se essa balbúrdia que vemos. Uma indústria de liminares não favorece em nada a segurança jurídica. Isso é fruto da intervenção estatal, é fruto da má ação do Estado, é fruto da falta de clareza na legislação, a qual permite que um juiz interprete da forma "a" ou da forma "b", porque uns dizem que a Lei do Mais Médicos já teria cumprido seu papel, outros dizem que ela ainda tem um papel a cumprir. Então, volto a afirmar isto: não se pode confundir, estabelecer critérios de qualidade é uma função, é um dever, mas desde a mais tenra fase da educação.

Nós queremos formar cidadãos aptos para exercer a sua cidadania, para viver uma vida em sociedade plena, sem depender de favores ou de políticas públicas. O ideal é que cada um consiga alcançar os seus próprios caminhos, termos um PIB *per capita* razoável, para que não se tenha que ficar dependendo dessa ou daquela política pública.

E, finalmente, eu quero dizer, com relação à criação e à gestão de estabelecimentos particulares de ensino e o seu correlato, que é a abertura de

cursos, antes de mais nada, é preciso observar que o direito à educação, por direito à educação deve-se compreender a disponibilidade da educação de qualidade, sendo acordes, aquilo que eu já disse, os doutrinadores, que é tarefa irrenunciável do Estado a fiscalização sobre os serviços prestados.

Dentro daquele escopo da Constituição Federal, do art. 209, que fala dos cumprimentos das normas gerais da educação (inciso I), autorização pelo poder público (inciso II) e avaliação de qualidade pelo poder público (também no inciso II), a liberdade de atuação da iniciativa privada, na área educacional, nos limites impostos pela Constituição, compreende, pelo menos, duas faces: a metodologia do currículo *stricto sensu*, de metodologia de currículo; e a liberdade de criar e gerir instituições de ensino.

E, como eu disse, neste campo, que a Constituição do Brasil não anda só, é preciso lembrar aqui que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e, sobretudo, o art. 13 do Pidesc, nos seus §§ 3º e 4º, ele coloca, com clareza, que os pais e os alunos têm o direito de escolher uma escola diferente daquela pública ofertada pelo Estado, que melhor lhe atenda os interesses. E, no § 4º, ele afirma que nenhuma das disposições, bom, e, no § 3º, além de dizer isto - que tem direito de escolha -, ele afirma que esse direito de escolha dos pais e dos alunos, a escola privada, ela tem que obedecer aos padrões mínimos do Estado exatamente como está no art. 209 da Constituição Federal.

E mais: o § 4º do mesmo art. 13, do Pidesc, ele assegura que nada, nenhuma ação estatal poderá ser interventiva, no sentido de limitar essa liberdade.

Então, o que colocamos aqui, não obstante, volto a dizer, o apelo dos cursos de Medicina, ele seja muito grande, mas nem por isso se há de abrir essa exceção - estou encerrando -, nem por isso se há de abrir essa exceção em nome de uma pretensa política pública.

É mais fácil trabalharmos - penso eu - de maneira que o Estado aprimore a qualidade desde a educação infantil, e nós certamente teremos resolvido muitos dos problemas que estamos enfrentando aqui hoje.

Eu agradeço, e passei um pouquinho do tempo.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço à Doutora Anna Dianin. E passo a palavra ao Doutor Bruno Coimbra, que falará pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular.

O SENHOR BRUNO CAETANO AMÂNCIO COIMBRA (FÓRUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR) - Boa tarde, quase boa noite, a todos vocês! Certamente, tivemos um dia muito produtivo. Aqui, em nome do Professor Celso Niskier, secretário executivo do Fórum das Entidades, eu agradeço imensamente o convite do

Ministro Gilmar Mendes. E aqui, na pessoa do Doutor Lucas, cumprimento os serventuários da Justiça, os demais colegas aqui presente, senhoras e senhores.

Doutor Lucas, eu venho representar o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular.

Aqui, de forma evidente, parece-me que só existem dois lados para esta discussão: ou estamos contra, ou estamos a favor do art. 3º, do chamamento público, ou da sistemática, eu ouso dizer que, talvez, nós já tenhamos um substrato muito evidente de que os dois sistemas podem existir de forma concomitante. Ou seja, não há dúvidas, pelo menos me parece que não existe dúvida de que, para aquelas instituições que já estão no sistema, que já têm um curso de Medicina autorizado, no processo em que elas possam pretender o aumento de vagas - e eu explico por que estou dizendo possam pretender: porque, desde 2018, Portaria nº 328, nem o aumento de vagas, as instituições que já estão no sistema, podem pretender.

Essas instituições se submetem à regra do Sinaes**.** E, a partir de abril de 2018, se o Ministério da Educação entender que é possível tirar o sobrestamento e possa se restabelecer, por exemplo, o aumento de vagas das instituições que já estão no sistema, esse aumento de vagas, a toda evidência, ele não é obstaculizado pela Lei do Mais Médicos, ou seja, parece-me evidente que a coexistência dos dois sistemas é admitida, sim, pelo Ministério da Educação.

Então, é em cima dessa premissa - e, aqui, talvez, importante apresentar para aqueles que não conhecem - esse registro me pareceu importante para que a gente evoluísse na discussão, situar o Fórum das entidades representativas do ensino superior particular. O objetivo do Fórum, Excelência, é defender os legítimos interesses do ensino superior particular. A sua missão, do Fórum, é formular propostas que visem assegurar o direito da livre iniciativa das instituições educacionais de maneira a privilegiar o desenvolvimento do setor, sempre dentro dos princípios da qualificação, da oferta de seus cursos e do melhor atendimento aos estudantes. É isso que preconiza o Fórum, Excelência.

E, com todo respeito, seguramente, nós chegamos a uma audiência pública no Supremo Tribunal, porque talvez não tenhamos feito nosso dever de casa, dever de casa do setor, dever de casa do Ministério da Educação, das entidades representativas, porque se considerarmos diversas falas, aqui, pela manhã, dos colegas e dos especialistas que me antecederam, críticas ferrenhas foram feitas ao chamamento público. O chamamento público não interiorizou, o chamamento público não é livre de qualquer crítica a respeito do perfil do egresso desses cursos.

E, como alguns já disseram também que me antecederam, a gente não tem grandes insumos ainda para avaliar, porque, no chamamento público, desde 2013, abre-se o edital, judicializa-se o edital, as instituições têm um

prazo para implementar. Alguns desses cursos iniciados nos primeiros editais, ainda existem até processos de judicialização que discutem aqueles editais.

Eu já laborei, no início de carreira, com licitação e contratos. Então, longe de se imaginar que processos licitatórios ou o chamamento público, ele tenha como efeito a impossibilidade de se criticar esse chamamento público.

Então, aqui, pela manhã, muito foi dito sobre, talvez, a ineficiência desse chamamento público; talvez, o não a tingimento daqueles objetivos que foram ali trilhados; e, talvez, seja também uma circunstância dos dez anos. A LDB é de 2004, então ela está por fazer 20 anos. A Lei do Mais Médicos é de 2013.

Então, é sempre uma oportunidade de se fazer diagnósticos. Políticas públicas são de diagnóstico. A gente precisa entender quais foram os efeitos, quais foram os erros, e sempre aprimorar essas políticas.

Parte disso foi feito nos chamamentos públicos. Tinha-se uma regra, viu-se que essa regra não seria salutar para o processo, teve a revisão desse regramento. E assim é a política pública.

Então, talvez, Excelência, estejamos diante de uma circunstância de revisitar a Lei do Mais Médicos. Talvez, sirva até de provocação ao próprio Congresso Nacional essa revisão da Lei do Mais Médicos.

Dois reparos também, Doutor Lucas. Eu acho oportuno que, quando se diz que os referenciais de qualidade, em relação aos padrões decisórios do sistema - eu vou pegar um copo de água... Dois reparos eu acho importante que sejam feitos aqui para, de certo modo, corrigir algum *deficit* de informação. É uma audiência pública, ela está sendo transmitida no YouTube, alunos estão assistindo, candidatos a cursos de Medicina estão assistindo, então, não vou ser redundante, já foi feito um reparo aqui, que eu entendo importantíssimo, fundamental, de se dizer.

Estão abrindo curso por liminares. Isso não é verdade. O que se está abrindo é o protocolo para que as instituições se submetam a um processo avaliativo, com base na Lei do Sinaes, esse processo passa por um despacho saneador, a Seres encaminha ao Inep, o Inep forma uma comissão, a comissão visita a instituição, esse relatório é submetido tanto à crítica da instituição quanto à crítica da Seres. E a Seres, com base nos regulamentos existentes, ela pode autorizar, ou não, e essa autorização vai chegar, ou não, ao Conselho Nacional de Educação, que vai revisitar, revisar, ou não, esse ato autorizativo. E esse parecer é submetido ao Conselho Nacional de Educação.

Nós passamos pela Seres, nós passamos pelo Inep, nós temos referências da Conaes, nós passamos pela CTAA que é Comissão Técnica de Aprimoramento da Avaliação, nós passamos de novo pela Seres, que vai dar o ato

autorizativo, ou não. E se ela negar, isso pode subir ao Conselho Nacional de Educação. No Conselho Nacional de Educação, essa não autorização pode ser submetida ao Conselho Pleno e, depois disso tudo, ainda é submetida à homologação do Ministro, que conforme de certo modo jurisprudência do STJ, é quem detém a palavra final sobre o processo regulatório em que há a atuação do Conselho Nacional de Educação.

Eu, particularmente, Excelência, e todos que nos ouvem aqui, confio nessas instituições, confio nessas entidades. E, talvez, dizer sobre a existência exclusiva do § 3º, nós estejamos fazendo uma sinalização de que não confiamos nessas entidades.

Um reparo importantíssimo, que eu reputo aqui também, é sobre o que foi dito em relação a que os referenciais de qualidade, o padrão decisório do processo, que não é conduzido no âmbito do chamamento, ele é defasado, ele é antiquíssimo. Salvo melhor juízo - e aí, só se eu estiver errado nas datas -, a Portaria nº 20, que é o padrão decisório que o Ministério da Educação se vale nos processos que são conduzidos no âmbito, em decorrência das liminares que permitem o protocolo do processo - eu acho que é importantíssimo ser enfático nisso - as liminares permitem protocolar um processo. Se tiver uma manifestação do CNS, se se tiver uma análise da Seres de que naquele município não existe a menor condição, ou que aquela instituição não tem sustentabilidade financeira, que

o projeto pedagógico do curso não é adequado, a Seres pode indeferir, Excelência, esse processo.

Não é que a judicialização garanta o resultado último de autorização do curso. É falacioso dizer isso, e tem que se ter muita responsabilidade ao dizer isso. O processo garante o protocolo e a tramitação. Se a Seres assim entender, que aquele curso não é adequado, ela não só pode como deve indeferir esse curso. E o padrão decisório, Excelência, o padrão decisório da Portaria nº 20, ele é de dezembro de 2017.

A Portaria nº 572, que é o padrão de monitoramento do Mais Médicos, é de junho de 2018. Nós contamos, aí, cerca de seis meses. Inclusive, cronologicamente, são padrões estabelecidos de forma bastante contemporânea.

Vou fazer só mais um comentário, Excelência, e encaminho para o final da minha fala.

O instrumento de avaliação, que para mim é o grande documento, a fase avaliativa do processo de autorização, ela se encerra do Inep. O Professor Paulo Chanan já descreveu aqui como é que funciona esse processo, a seleção dos avaliadores, tudo auditável no Inep que, de certo modo, fica fora dos muros do próprio Ministério da Educação, ali se encerra o processo de avaliação. E o instrumento de avaliação é de 2017.

Então, dizer também que estaria defasado todo esse arcabouço avaliativo, é preciso ter ciência de que tanto a portaria do padrão quanto os instrumentos são contemporâneos às regras ali estabelecidas.

Um outro comentário que eu acho de suma importância, Doutor Lucas e demais aqui presentes, eu particularmente tendo a confiar muito e acabei registrando aqui, com todo o respeito e apreço, penso que esta audiência pública nos faz avançar muito e seguramente nós não estaríamos aqui, no âmbito da Suprema Corte brasileira, discutindo esse ponto se não fossem as judicializações. O Ministério da Educação não estava discutindo essa situação, o Ministro teve oportunidade de dizer aqui que retomou essa discussão em abril deste ano, portanto, ficamos quatro anos sem nenhum horizonte, sem nenhum cenário, inclusive as instituições que já estavam no sistema e pretendiam aumentar a suas vagas. E aumento de vagas - repito -, ele não está sob o pálio da Lei do Chamamento, a Lei do Mais Médicos, ele vai acontecer pela outra sistemática. Perfeito? Então essa situação do Ministério da Educação, esta audiência pública, que tivemos a riquíssima oportunidade de ouvir aqui todos que trouxeram as suas contribuições, ela decorre da provocação que veio dessas liminares.

Eu vou me permitir aqui, para encaminhar o final da minha fala, e aqui aproveitando a presença da Conselheira Amábile Pacios, do Conselho Nacional de Educação, eu confio muito, Excelência, em órgãos de Estado com

membros eleitos que possam discutir verdadeiramente, de forma perene, a qualidade da educação, que é o que foi dito aqui. E cabe ao Conselho Nacional de Educação o documento, que tanto quem está no chamamento, tanto quem conseguiu o seu protocolo, e está sendo ou já foi avaliado pelo Ministério da Educação, um referencial único, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais. Só existe uma, só existe um perfil de egresso, só existe uma diretriz tanto para os cursos do Mais Médicos quanto para os cursos que eventualmente venham a ser autorizados pelo Ministério da Educação por força das liminares.

O Fórum destaca a importantíssima oportunidade de hoje estarmos em audiência pública, perante a Suprema Corte, a fim de discutir essa temática de extrema relevância, ponderando e perquirindo não apenas o seu conteúdo meritório, mas também, com a salutar oportunidade de desencadearem estímulo aos demais interlocutores nos mais diversos campos, a fim de que também pensem a política pública com particular enfoque à qualidade.

O Fórum confia que o extrato das discussões, no âmbito da comissão de estudos lançada para análise dos aspectos regulatórios, avaliativos e de expansão de cursos de Medicina no Brasil, conduzida pela Câmara de Educação Superior, o Conselho Nacional, Excelência, está debruçado sobre isso. Há uma comissão discutindo toda essa situação da formação, conduzida pela Câmara de Educação Superior no Conselho Nacional de Educação, somado ao que vier a

produzir o grupo de trabalho, no âmbito da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, foi editada uma portaria recente para resgatar aquilo que não foi feito durante quatro anos, para que um grupo de trabalho da Seres discuta o porvir, discuta o formato de eventual restabelecimento, de restabelecimento das visitas a fim de autorizar o aumento de vagas daquelas instituições que estão no sistema.

O Fórum compreende resultar, neste momento, oportuna provocação, inclusive ao Congresso Nacional, para que maneje eventual revisão da lei, que se aproxima do seu 10º aniversário, que talvez já dê sinais de que precisa ser revisitada.

Por fim, importante reafirmar que o Fórum tem como valor inarredável a proteção da livre iniciativa - e esse é o grande mote da minha fala, Excelência. E, nessa linha, mantém o olhar atento a possíveis interesses corporativistas que possam ter o real intento de excluir ou restringir o pleno exercício dessa garantia constitucional, qual seja, a livre iniciativa. Fundamental que o diálogo democrático a respeito dos números da educação tenha como norte a ampliação do acesso à educação superior de qualidade.

O Fórum agradece a oportunidade e permanece à disposição desta Corte para seguir contribuindo para a discussão.

Muito obrigado, Doutor Lucas.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor Bruno Coimbra e passo a palavra à Doutora Laina Passos, Secretária de Saúde do Município de Alagoinhas, na Bahia. A Doutora se manifestará virtualmente.

A SENHORA LAINA GABRIELE RAMOS PASSOS LÔBO (SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, BA) - Boa noite, gostaria de cumprimentar o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, em nome de quem eu cumprimento todos demais presentes, todas as autoridades.

Eu sou Laina Passos, enfermeira, sanitarista, epidemiologista, especialista também em gestão de saúde pública. Atuo no Município de Alagoinhas, município do interior da Bahia. E gostaria de dizer que muitos daqueles que me antecederam contemplaram, mas saliento a importância da interiorização do curso de Medicina.

A partir do edital de chamamento, entendemos que o curso tornou-se de Alagoinhas, e não da instituição da Faculdade Estácio de Sá.

E também gostaria de salientar a importância do Coapes. Gostaria que a minha apresentação ilustrasse para vocês principalmente a importância que venho trazer ao Coapes e à interiorização da mão de obra médica aqui em nosso município, que é polo de macrorregião de saúde, compreende aí 33

municípios e seu entorno. E a importância do município, ele se destaca aí entre os 10 maiores nomes municípios do Estado da Bahia. E vou ilustrar através da minha apresentação aquilo que destaco de fundamental importância.

A Faculdade de Medicina teve o seu ato regulatório através do credenciamento, a Portaria nº 274, de 27 de março de 2018; a autorização do curso de Medicina através da Portaria nº 221, de 27 de março de 2018.

No ano de 2018, participamos do credenciamento da Faculdade Estácio, a autorização do curso de Medicina para sua instalação. Em 2019, a implantação do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral. Já no ano de 2020, a implantação do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. No ano de 2021, tivemos a ampliação da estrutura física da instituição Estácio de Sá. E, em 2022, o início do internato [ininteligível] cirurgias eletivas aqui em nosso município.

A parceria entre a Secretaria de Saúde e a Faculdade de Medicina através do Coapes. Eu julgo de fundamental importância ressaltar que o Coapes é um instrumento de transformação para qualificação da rede de atenção ao país. Através do Comitê Gestor do Coapes, desenvolvemos um plano de ação para, como linha de atenção e cuidado, priorizarmos aqueles problemas vindos da saúde pública como principais bandeiras a serem levantadas, implementadas e

também valorizadas em relação a maior financiamento, a maior investimento em saúde, a exemplo das dietas básicas e trabalhadas dentro o Programa de Saúde da Família, como hipertensão, *diabetes mellitus*, enfim.

Através do Coapes, nós também fizemos a aquisição da torre de vídeo para a realização da primeira cirurgia de videolaparoscopia pelo SUS na macrorregião Nordeste aqui em nossa Alagoinhas.

Também fizemos a reforma da maternidade municipal. Essa maternidade atende os 33 municípios. [ininteligível] Alagoinhas é polo de macrorregião de saúde como eu disse anteriormente, isso soma uma população de aproximadamente um milhão de habitantes. Então, entendam o porquê de trazer aqui a este debate a importância do curso de Medicina em nosso município e, portanto, a necessidade da interiorização da mão de obra médica através da formação desses profissionais aqui.

Através dessa parceria entre a faculdade e a Secretaria de Saúde, nós também fizemos a reforma geral de um centro cirúrgico, que compreende aí três salas cirúrgicas completamente equipadas através do Coapes, o nosso Centro de Cirurgias Eletivas.

Também estamos finalizando a reforma total de uma policlínica municipal. Ela hoje está em um processo final de reforma e ampliação, e isso só nos

é possível por conta do Coapes. Ela atende Alagoinhas e também os 33 municípios do entorno de Alagoinhas.

Através do Coapes, nós também desenvolvemos diversas outras atividades, diversas outras ações, como capacitação, treinamentos, qualificação da nossa mão de obra, além das construções, da aquisição de mobiliário, material, equipamentos, enfim.

No momento da pandemia do covid-19, fizemos, inclusive, aquisição de EPIs através do Coapes e também de equipamentos.

Essa foto ilustra os discentes do curso de Medicina junto aos profissionais de saúde em mais um momento de capacitação e integração da rede de atenção à saúde e da faculdade de Medicina. Nós aqui tecemos também qualificação através do curso de ACLS para os alunos egressos dos cursos de Enfermagem e Medicina que atuam no Samu, que atende toda a região também de Alagoinhas, os 33 municípios. O Samu de Alagoinhas é regional.

Nós também tivemos aqui no nosso município, por meio da faculdade, uma capacitação realizada para docentes do curso de Medicina e, através disso, tivemos a participação da Secretaria de Saúde nesse congresso.

Nós também participamos dos projetos de pesquisa e extensão e isso envolve toda a macrorregião de saúde, envolve projetos voltados a criança, idosos e comunidades quilombolas.

Mais ilustrações dos eventos que nós estamos realizando, das ações que nós estamos realizando.

Aí eu trago agora - está muito ruim de ver o *slide* agora -, mas eu gostaria de salientar a integração da faculdade com a Secretaria de Saúde no atendimento à comunidade quilombola, à doença de anemia falciforme e a todas as doenças, como hipertensão, diabetes e aquilo que nós julgamos prioritário dentro dos programas que atendemos na atenção básica. Nós também temos projetos de pesquisa e extensão voltados à variação sazonal e aspectos clínicos e epidemiológicos de zoonoses em toda a macrorregião nordeste e perfil epidemiológico e análise da sobrevida em pacientes.

Esses são alguns projetos de pesquisa que estarão... A minha apresentação vai ficar à disposição. Estou preocupada com o tempo, mas eu gostaria de salientar a importância da parceria entre a faculdade e a Secretaria Municipal de Saúde.

Esses são eventos voltados aos alunos do curso de Medicina, que sempre participam das nossas conferências. Aqui nós temos a Conferência em Saúde Mental do nosso município e esse evento voltado às hepatites virais, o

Sihepa. Ele foi realizado há dois meses aqui no auditório da Faculdade Estácio, envolvendo toda a rede de atenção à saúde e trazendo qualificação para toda a rede de atenção à saúde.

O que está aqui em discussão, na verdade, não é apenas o modelo de implantação das escolas médicas em nosso país, mas o modo de interação dessas escolas em nosso sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde. Por um lado, pode-se optar pelo modelo tradicional dissociado do SUS e voltado a atender unicamente a demanda de formação de profissionais. Por outro lado, há a oportunidade de acolher, em definitivo, o modelo Mais Médicos, uma estratégia concatenada, integrativa, inclusiva e simbólica, que atua, sobretudo, na qualificação do Sistema Único de Saúde.

Agradeço aqui a participação e me coloco à disposição dessa Corte para qualquer esclarecimento a respeito da minha apresentação. Defendo o programa que foi desenvolvido ao longo de todos esses anos, e o curso de Medicina - eu continuo aqui defendendo - é do município de Alagoinhas.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço à Doutora Laina Passos pelas contribuições e passo à palavra a Sua Excelência o Senhor José Jair Franzner, que é o Prefeito do Município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

O SENHOR JOSÉ JAIR FRANZER (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC) - Boa noite, Vossa Excelência Gilmar Mendes e autoridades aqui presentes! Boa noite a todos!

Sou José Jair Franzner, prefeito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. Agradeço a oportunidade de estar aqui, no dia de hoje, para falar um pouco da minha cidade e do curso de Medicina na modalidade Mais Médicos que temos em nossa cidade.

Jaraguá do Sul é uma cidade muito próspera do Norte de Santa Catarina, fica a 200 quilômetros de Florianópolis e a 165 quilômetros de Curitiba, colonizada por negros, alemães, italianos, poloneses e húngaros. Temos um PIB *per capita* de R$ 51.652,44; IDH de 803; população, estimada pelo IBGE de 2020, de 181.173 habitantes. Possui diversificação industrial e é destaque na economia, destacando os setores metais mecânicos, têxtil, alimentício entre outros. Possuímos grande número de acadêmicos em 17 universidades, porém não tínhamos, até pouco tempo, curso de Medicina. E mesmo sendo uma das melhores cidades para se viver no país, com enorme oferta de emprego e educação de destaque, tínhamos muita dificuldade em atrair médicos e profissionais da área da saúde.

Em 2013, Jaraguá recebeu a habilitação para o curso de Medicina na modalidade Mais Médicos. Foram muitos anos de lutas pela aprovação, toda a sociedade civil organizada envolvida, além do poder público, foram dezenas de

visitas, elaboração de documentos e conversas com os órgãos de controle e ensino federal.

Em 2015, começou com residência médica. Em 2017, assinou o contrato do Coapes com a Faculdade Estácio. Em 2018, o curso foi autorizado, inicialmente, com 50 acadêmicos e a prefeitura começou a receber repasse de 10% do valor das mensalidades. Em 2021, inauguramos uma Clínica de Especialidades na cidade com os alunos fazendo prática junto com médicos da Prefeitura. Em 2022, renovamos o contrato com a Faculdade.

Em Jaraguá do Sul, seguimos à risca o que está previsto no Programa Mais Médicos. Temos reuniões dos comitês, reuniões do contrato organizativo de ação pública de ensino-saúde, sendo que todos os atos são publicados pelo *site* da prefeitura para consulta de qualquer cidadão, e uma parceria muito forte com os dois hospitais filantrópicos de nossa cidade: Hospital São José e Hospital Jaraguá, que - aliás, convido todos para conhecerem os hospitais de Jaraguá do Sul -, com ajuda de empresários, da comunidade e da prefeitura, são hospitais de primeiro mundo.

Na pandemia de coronavírus, os acadêmicos da faculdade fizeram monitoramento dos casos suspeitos e ativos de covid por telefone, totalizando mais de 6 mil atendimentos. O programa de triagem criado para

atendimento aos cargos suspeitos e positivos de covid, sendo destaque no Laboratório de Inovação da Região Sul para a Organização Panamericana de Saúde.

Então, os alunos ajudaram a desafogar as filas de espera do SUS, sempre monitorados, acompanhados por médicos, que eram acionados em casos mais graves.

Temos em Jaraguá do Sul bolsa-medicina para alunos da rede pública, bolsa integral, sem pagar nada. Seis alunos da rede pública conseguiram realizar este sonho.

De janeiro a junho deste ano, a Clínica de Especialidades feita pela prefeitura e Faculdade Estácio já atendeu mais de 5 mil moradores, num total de mais de 11 mil atendimentos.

Estamos ampliando oito unidades de saúde básica com recursos do Coapes em nossa cidade, um investimento de 1,6 milhão de reais, sendo que essas unidades terão uma estrutura própria para a educação de Medicina, e com isso estamos dobrando o tamanho dessas oito unidades de saúde municipal.

Além disso, temos vários programas em parceria com a faculdade, que capacitam nossos professores para primeiros socorros utilizando recursos do Coapes e a estrutura da faculdade.

Temos ainda cursos voltados para os profissionais da rede pública de saúde municipal, como reanimação cardíaca, entre outros, além de

diversos outros programas que atendem a comunidade, entidade sem fins lucrativos e alunos de Jaraguá do Sul.

Na tela dos valores repassados, temos um quadro com os repasses da faculdade ao município, ano a ano, totalizando 7,5 milhões reais.

Bem, era isso o que eu tinha para dizer. Jaraguá do Sul precisa do curso de Medicina. A comunidade precisa abraçar o curso em nossa cidade. Temos uma organização que se destaca. Todas as decisões têm ampla divulgação e, efetivamente, em nossa cidade a comunidade acadêmica é integrada à comunidade. Não temos somente um prédio com alunos que pagam mensalidades e lutam por um diploma. Temos em Jaraguá do Sul um modelo de sucesso com grandes reflexos sociais.

Muito obrigado pela oportunidade e conto com o apoio dos colegas e do Judiciário para a manutenção do curso de Medicina em nossa cidade e desta modalidade em todo o país.

Obrigado.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Senhor Prefeito Jair Franzner e passo a palavra à Senhora Valéria de Oliveira Lima, que é Secretária de Saúde no Município de Cruzeiro do Sul, no Acre, e falará virtualmente.

A SENHORA VALÉRIA DE OLIVEIRA LIMA (SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC) - Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer a oportunidade, quero cumprimentar o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes e as demais autoridades aí presentes.

Eu quero falar sobre dois pontos que até então eu não vi serem abordados, que acho que são de extrema importância. Eu quero falar sobre o papel social, eu quero falar sobre o vínculo.

Você elaborar a parte econômica, ela é importante? Ela é de extrema importância, sem sombra de dúvida, mas nós não podemos perder o contexto do vínculo e jamais do papel social.

Eu quero falar do Município de Cruzeiros do Sul, que fica no Acre. É um município com distância da capital, Rio Branco, de 630 km. A estrada, a BR, dificulta muito o acesso. Nós temos de 8 a 12 horas para chegar na capital. Pela via aérea, se tivermos algum problema, teremos que arcar com 1.500 a 2000 reais em uma passagem de certa urgência. E quero falar sobre a importância, hoje, desse curso de Medicina, do ensino de aprendizagem no modelo Mais Médicos, hoje pertencente ao Município de Cruz do Sul.

Eu queria bater a seguinte reflexão: Cruzeiro do Sul teria a oportunidade de ter esse ensino? De jeito nenhum. Com a população de 89 mil habitantes, certamente que não. Então, hoje, temos uma oportunidade, uma

população maior de 30 seringais que percorrem o Município do Cruzeiro do Sul. Estou falando de rios, do Rio Valparaíso, do Rio Mirim, do Rio Juruá, do Rio Liberdade. Essas pessoas, para chegarem ao acesso de saúde pública, muitos caminham até 9 horas. Entram num batelão, em uma canoa - nós colocamos canoas emergenciais - para chegarem ao hospital ou para chegarem a nossas unidades básicas de saúde. São 9 horas de viagem, dentro de um batelão, doente, exposto a sol e chuva. Estou falando de um trabalho social - o modelo Mais Médicos - que, através do Copaes, traz para o município. Esse modelo Mais Médicos obedeceu a todo o processo regulamentado, trabalhou em todos os parâmetros.

Eu quero falar sobre a importância dessa faculdade quando você tem a contrapartida. Eu vou falar de uma contrapartida de recurso, e ele cai de verbas anuais, dos quais recebemos o valor de 1,6 milhão, que o modelo Mais Médicos traz para esse município, para as unidades básicas de saúde.

Estou falando de um papel social, o qual retorna às unidades básicas de saúde, através de equipamentos, de caminhonetes. Se vocês viram nesses *slides*, nós precisamos de caminhonete para que essa vacinação chegue aos locais de difícil acesso; nós precisamos de caminhonetes e de carros para que possamos levar tanto os nossos profissionais quanto os residentes de Medicina para que possam ver a realidade do que é, hoje, o nosso território. Então, é importante que haja esse vínculo, porque tudo é feito desde a parte da base - estou falando de base de

territorialização; é feito um trabalho de mapeamento com os agentes comunitários de saúde; visitas domiciliares; palestras nas unidades básicas de saúde; um trabalho com acompanhamento; um trabalho de mapeamento. Além desse mapeamento, estou falando de um plano de trabalho que não chega somente ao queixoso, ao usuário, mas sim à família; estamos falando de um trabalho feito com uma equipe de saúde da família, juntamente com os seus residentes. Esses residentes ficarão muito mais de seis anos conosco. Nós temos residentes de Cruzeiro do Sul, moradores de Cruzeiro do Sul, que ficarão conosco. Além disso, dessa contrapartida, essa faculdade entra com o modelo de bolsistas para a nossa cidade, bolsistas de 100%, que não teria realmente condições de fazer um curso Medicina.

Eu estou falando também de uma qualidade de serviço melhor aos meus médicos, que hoje são pessoas que trabalham nas nossas unidades básicas de saúde e são efetivas, que, para poderem fazer qualquer curso de qualificação ou que possam melhorar as suas especializações, teriam de ir para fora. Hoje, não, com essa contrapartida do trabalho social que esse modelo de ensino Mais Médico traz, essas pessoas não precisam sair daqui, elas fazem suas especializações e isso melhora também o plano de cargo, carreira e salário desses profissionais.

Então, estou falando que é importante que não se perca de vista o que uma faculdade vai trazer tanto na sua parte social para aquele município, para aquela unidade básica de saúde. Eu estou falando de retorno. Estou falando

que, muitas vezes, nós fazemos atendimentos itinerantes, em locais de difícil acesso, que nós não temos aparelho de ultrassom. E, hoje, nós vamos ganhar, com esse convênio, vamos ganhar aparelho de ultrassom, vamos ganhar caminhonete, vamos ganhar motocicletas, que é no trabalho que fazemos em controle e erradicação da malária, eu estou falando de modelos de van, que é para levar todos esses profissionais de saúde que trabalham nas unidades e também os residentes de Medicina. Eu estou falando de todo um trabalho que nós podemos fazer juntamente com essas faculdades. Não é só chegar, elaborar uma faculdade e pronto! Não é dessa forma que as coisas são montadas. As coisas têm que ser montadas com vínculo, sem o qual nós não vamos ter esses profissionais de maior qualidade.

Estou falando que nós temos que obedecer, sim, a parâmetros. Estou falando que temos, sim, um modelo, hoje, bem forte, no que chamamos de modelo Mais Médicos. Estou falando em eficácia, em efetividade, falando de retorno.

As faculdades particulares, quando elas inserem esses profissionais, parece que o vínculo, o vínculo, ele nunca é trabalhado. E precisamos, sim, desse modelo de vínculo, porque é importante que esses profissionais, ao saírem da faculdade, eles conheçam toda a parte que adentra o Sistema Único de Saúde, quando eu estou falando desde a parte da visita ao acolhimento, estou

falando desde a parte da consulta, estou falando das palestras, estou falando da imunização, estou falando da vigilância epidemiológica, estou falando de tudo.

Então, sou a favor sim! Eu defendo o modelo Mais Médicos. Eu defendo, sim, a importância do Coapes, porque isso é de extrema eficácia. E falarei sério: se nós não tivéssemos esse modelo, hoje, nós não teríamos como comprar esses materiais, porque, de recurso próprio, não há condições, ou, então, somente por meio de emendas parlamentares.

Cruzeiro do Sul, de acordo com o nível populacional que hoje nós temos, já defasado, segundo o IBGE, de 89 mil habitantes, que, atualmente, acredito que nós tenhamos uma população maior de 120 mil pessoas, teríamos, de jeito nenhum, essa contrapartida social, se não tivéssemos uma faculdade dessa, hoje, implantada no nosso município.

Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade, agradeço de falar, de poder falar do Município de Cruzeiro do Sul e poder falar, ainda mais, da importância dessa faculdade hoje para o meu município! Eu falo meu município, porque eu moro aqui. Eu defendo o SUS. Nós trabalhamos um modelo, sim, social, nós trabalhamos, sim, o vínculo, nós queremos desenvolver muito mais o modelo de saúde. A saúde, ela não é feita somente através do adoecimento, e sim da prevenção.

Eu acredito que, com essa faculdade, nós podemos, sim, trabalhar o que é realmente a saúde que é a prevenção.

Obrigada a todos!

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço à Doutora Valéria! Vamos suspender a audiência para um breve intervalo, mas peço que todos permaneçam aqui, porque será um intervalo bem breve mesmo, apenas para ajustar os próximos expositores.

Retomamos por volta de 19h30, está bem?

[INTERVALO]

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Boa noite! Cumprimento novamente a todas e a todos, agradecendo a presença por prestigiar a nossa audiência. Declaro reaberta nossa audiência pública, passando diretamente a palavra ao Doutor Sílvio Pessanha Neto, médico, professor e avaliador do Ministério da Educação e do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas.

O SENHOR SILVIO PESSANHA NETO (MÉDICO, DOUTOR, PROFESSOR E AVALIADOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO SISTEMA DE ACREDITAÇÃO DE ESCOLAS MÉDICAS) - Boa noite a todos e todas. Excelentíssimo Doutor Lucas Faber, gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de participar desta importante discussão e reflexão, que é tão cara,

tão relevante para a nossa sociedade e para a população brasileira. Cumprimentando Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos demais presentes.

Excelência, em que pese a grande relevância da discussão sobre se temos ou não cursos médicos em número suficiente, eu entendo que hoje os cursos de Medicina no Brasil totalizam 388 cursos. Desses, 250 são cursos privados, portanto, representam aí 65%, e aqueles oriundos dos editais do Mais Médicos, da Lei nº 12.871, representam 61 cursos, portanto 16% do total.

Então, gostaria de começar trazendo um conceito importante, que muito se falou aqui durante o dia sobre a questão do aumento indiscriminado dos cursos de Medicina. Então, vale ressaltar que, quando se fala de cursos autorizados no âmbito do Mais Médicos, estamos falando de uma representatividade de apenas 16%. Além disso, sem dúvida, é relevante nós trazermos à discussão o mais importante que é, na eventualidade de se ter uma autorização do curso de Medicina, se o modelo ou se a forma deveria se dar por meio de edital ou chamamento público, ou utilizando o fluxo regulatório existente até a publicação da lei. E é sobre isso que eu gostaria de dedicar os próximos minutos.

É importante dizer que o chamamento traz alguns diferenciais importantes e que, na minha visão e na visão dos colegas com os quais nós

conversamos, vem com um grande diferencial que é colocar o gestor público municipal como protagonista do processo de construção do curso.

Nós vimos há pouco aqui alguns exemplos de secretários de saúde, de prefeitos que vêm falar do curso médico claramente entendendo esse curso como sendo parte de um processo que se inicia na articulação entre a instituição de ensino pleiteante e o município que, anteriormente, de forma prévia, foi selecionado para receber o curso.

Nesse contexto, Excelência, esse gestor público precisa se comprometer, se implicar e garantir que, ao longo dos seis anos que se passarão, certamente os investimentos sejam feitos para garantir a qualidade do curso e as condições mínimas para que esse curso possa ser implantado no município em questão.

Claramente, na condição de médico, avaliador e gestor, eu tenho oportunidade de conhecer diversas escolas médicas, tanto do âmbito do chamamento público quanto aquelas que foram autorizadas antes da lei. E posso garantir aos senhores que a discussão sobre qualidade da formação médica não é sobre ser novo ou antigo o curso, ser público ou privado, mas a grande diferença, o que vai garantir que esse curso médico está de forma adequada é a sua capacidade de se integrar à rede de saúde.

E é sobre isso que eu gostaria de falar quando nós comparamos os modelos. É em relação à questão de que o município é o primeiro a pleitear e garantir a possibilidade de se implantar o curso.

Quando os editais de chamamento público foram desenvolvidos, eles foram feitos, claro, em obediência ao que previa o art. 3º, da Lei nº 12.871. E eu posso dizer que um dos pontos mais relevantes é que ele foi construído para que, além da avaliação do projeto pedagógico, do corpo docente, da infraestrutura, também esse município se implicasse em atender ao que tem de planejamento com base nos repasses que são feitos, que é até 10% do faturamento bruto mensal da IES é repassado, e um comitê gestor do Coapes organiza e disciplina esses investimentos, olhando e mirando na garantia de que esse curso possa se implantar de forma adequada.

Além disso, os editais de chamamento público, o que não acontece em modelos diferentes do edital, garantem a oferta de bolsas integrais para munícipes de baixa renda no município.

E, por fim, também a obrigatoriedade da implantação de programas de residência médica, estes que devem ser implantados desde o primeiro ano do curso e que, sem dúvida nenhuma, são alavancas de fixação dos médicos.

E aí nesse ponto, Excelência, eu faço um destaque importante que muito se falou aqui que o edital de chamamento público como política pública não provou ser eficiente, ou não provou que é capaz de fixar médicos. Aí, eu faço um parêntese importante.

Os primeiros cursos do Mais Médicos foram autorizados em 2017; dois, o segundo semestre de 2017. Portanto, dado que o curso é de seis anos, não temos ainda sequer um médico formado nesse novo modelo. Então, como não podemos dizer com números que, na verdade, com base na demografia, que esse programa não é capaz de fixar médicos se sequer formamos no Brasil um médico oriundo desses programas?

Ou seja, esse balanço sobre a efetividade do programa ainda está por vir. Precisamos avaliar se esses médicos egressos vão de fato ocupar as vagas de residência produzidas por eles e se esses médicos vão ou não permanecer na região, dado que os investimentos que são feitos melhoram as condições de trabalho desse médico. E que, sem dúvida nenhuma, quando foram idealizados em 2013, tinham um único propósito: buscar ferramental e buscar formas de tentar fixar e descentralizar a oferta de serviços médicos no nosso país, que, sabidamente, estão concentrados nos grandes centros e nas capitais.

É importante dizer também que, quando a gente analisa profundamente a Lei do Mais Médicos e os editais de chamamento, fica evidente que temos avanços inquestionáveis que, quando se comparam com os modelos tradicionais ou anteriores à lei, são ganhos e evoluções. Seria, sem dúvida nenhuma, um retrocesso a gente acreditar que a via fora dos editais é capaz de garantir as mesmas condições.

É importante, Excelência, que a gente observe o seguinte: diferentemente do que se pode imaginar, as liminares judiciais não são, atualmente, as decisões não são simplesmente de abertura do sistema eletrônico do MEC para que aquele mantenedor se submeta aos critérios regulatórios de avaliação, não. Muitas decisões, na verdade, explicitam e obrigam que se utilize a Portaria nº 20, que é a portaria que estabelece os padrões decisórios para autorização de cursos, mas sequer tem previsão do padrão decisório para a Medicina, porque já existia a Lei do Mais Médicos, e a própria Portaria nº 20 tem um dispositivo que diz que, para a autorização de cursos de Medicina, deve-se respeitar o procedimento do Mais Médicos.

Claro que, no momento em que há uma decisão judicial que exige a abertura do protocolo e a Portaria nº 20 é adotada, na prática, o que ocorre é extrapolar o procedimento do reconhecimento de curso para que ele seja utilizado para autorização. E aí nós temos, sem dúvida nenhuma, uma grande discrepância.

Por quê? Porque hoje, diferentemente de tudo o que eu falei aqui sobre critérios e autorização de cursos pelo chamamento, na Portaria nº 20, basta que essa visita *in loco* resulte numa nota, num conceito global quatro ou mais, que é um critério de reconhecimento de curso e não de autorização, que cada uma das três dimensões tenha o conceito três ou mais e apenas dois indicadores sejam suficientes - estrutura curricular e componentes curriculares.

Eu quero dizer com isso, que, se todos os indicadores do instrumento referentes ao SUS forem considerados insuficientes, ainda assim, atendendo ao que está previsto no padrão decisório, o curso é autorizado. Então, nós estamos falando de dois mundos, onde o SUS é o verdadeiro laboratório do curso, onde ele é implicado na fase inicial de construção, e um outro modelo.

Nós estamos discutindo aqui que tanto se falou de qualidade ao longo de todo o dia, falou-se em novos critérios, em um novo instrumento, mas nós estamos diante de uma urgência, a urgência que é enquanto nós não temos esses novos elementos, esses novos padrões que estão sendo discutidos, no MEC, pela Seres, em um grupo de trabalho que foi previsto na Portaria nº 328, do qual eu tenho o prazer de fazer parte também, da reflexão sobre novos critérios. Mas, enquanto isso ocorre, na prática, toda essa articulação com o SUS, que é fundamental no edital de chamamento público, é absolutamente desconsiderada quando se abre um protocolo e se adota a Portaria nº 20.

Então, a preocupação que nós deveríamos ter é olhar de forma macro e entender como esse novo curso pode desorganizar o binômio ensino/serviço e refletir sobre uma pergunta que eu gostaria de fazer: por que, enquanto se discutem novos critérios, enquanto, eventualmente, se define como deveria ser um novo edital, atendendo ao que está previsto na Lei nº 12.871, essa urgência de abrir cursos de Medicina, adotando-se um padrão obsoleto, que sequer, como eu disse, tem previsão para autorização de curso de Medicina e que, sem dúvida, desorganiza, como já foi dito várias vezes aqui, a rede de saúde, a qualidade, porque aqueles cursos ali existentes acabam tendo que compartilhar, aqueles que investiram na rede, aqueles que, de fato, estão integrados à rede de saúde local, acabam sendo, muitas vezes, comprometidos pela presença de cursos que, simplesmente, por parte da mantenedora, entende-se que há um desejo e ele, portanto, passa por um processo, porque, se a gente comparar os dois, ainda que se discuta que um não é tão rígido quanto o outro e tal, o mais importante a gente perde, a gente perde a possibilidade dessa integração íntima do curso com a rede de saúde.

Por fim, eu entendo que nós deveríamos, nesse momento, em caráter de urgência, entender que, até que o GT do MEC, da Seres, conclua o que seja os novos padrões regulatórios para a autorização de curso Medicina, nós deveríamos respeitar a lei, consolidar os avanços dos chamamentos públicos - que

citei vários aqui - e sentar à mesa para discutir os termos dos novos editais que virão, se entendermos que são necessários.

Portanto, é legítimo o direito de qualquer mantenedora pleitear um curso médico, mas por que não se submeter a esses mesmos critérios? Evitando que a gente tenha hoje esse comportamento anti-isonômico, onde alguns passam por um processo mais longo, que demanda a seleção do município, a articulação obrigatória com esse gestor público local e em contraste de outros que, muitas vezes, acabam se instalando na região sem os mesmos compromissos.

Portanto, ao invés de discutirmos *bypasses* e a constitucionalidade da lei, deveríamos estar discutindo aqui respeitar a lei e pensar nos termos dos próximos editais.

Obrigado! Boa noite!

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço as contribuições do Doutor Silvio Pessanha e passo a palavra ao Doutor Rodrigo Matos, que é médico e provedor da Santa Casa de Misericórdia do Município de Feira de Santana na Bahia.

O SENHOR RODRIGO MATOS (MÉDICO E PROVEDOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/ BAHIA) - Boa noite a todas as pessoas presentes! Na figura do Doutor Lucas, eu

cumprimento a todos que trouxemos um debate plural, vale ressaltar, e isso fortalece a Democracia.

As instituições estão ouvindo quem? Estão ouvindo justamente a sociedade civil organizada. Sabemos que há interesses difusos, mas todos estão aqui apresentando argumentos técnicos, que certamente serão muito importantes para o convencimento do juiz, e isso me deixa muito feliz.

É um desafio falar, eu também tinha feito, assim como Doutora Socorro, uma fala, a gente modulou nossa fala de acordo com as diversas colocações que foram brilhantemente aqui sinalizadas.

Então, eu vou focar em um aspecto que eu acho muito importante. O foco do debate era: qual é o melhor modelo de expansão de vagas de Medicina? O modelo tradicional? Ou modelo que a gente entende que veio a partir da Lei do Mais Médicos?

Praticamente a maioria dos expositores colocaram como ponto focal a qualidade do curso médico e se há ou não o número de médicos suficiente. Faz sentido. Porque, em tese, se você pensa que há um número reduzido de médicos, faz sentido flexibilizar as normativas para que a gente possa aumentar o número de médico e aí podemos sacrificar a qualidade? Então, eu acho que faz uma discussão interessante.

Mas, como foi dito, inclusive, pelo próprio representante do Cade, Doutor Augusto, um médico que é mal formado não economiza, ele certamente custa mais caro! E por que custa mais caro? Porque ele tende a pedir mais exames, como o próprio Presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo colocou.

E será que seria um abalo meramente econômico? Não, isso é desafiador para o SUS. Por que é desafiador para o SUS? Porque se você entende que uma consulta de um paciente que tivesse uma cefaleia - a gente tem muito médico aqui - e que ele tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, por uma, duas semanas e, muitas vezes, se ele fosse numa consulta de um indivíduo que foi bem formado, que passou por uma residência estruturada de saúde da família e que entendesse que aquela dor de cabeça, aquela cefaleia, era meramente uma cefaleia primária e que não eram necessários exames complementares, pelo menos *a priori*, aquela consulta seria um determinado valor.

Se ele vai para o indivíduo que é mal formado, ou que não teve a oportunidade de ter uma formação adequada, ele vai encaminhar para o cardiologista, para neurologista, enfim, vai pedir uma tomografia de crânio. E o que é que isso vai gerar, Doutor? Isso vai gerar uma coisa muito negativa. A credibilidade do SUS vai ser colocado em risco, porque ele não vai conseguir. Se é

difícil a gente fixar médico na atenção primária à saúde, quão mais difícil será a gente ter o cardiologista, o neurologista, o exame de tomografia!

Isso gera uma sensação de insegurança, de impotência. Os mais vulneráveis entendem o quê? Entendem que eles não têm direito e não têm acesso à saúde por exames e encaminhamentos que seriam efetivamente evitados, se uma boa formação médica fosse colocada. Então, dito isso, é uníssono, aqui todo mundo entende que a qualidade é prioridade, a qualidade da formação médica, mas é esse ponto que eu quero pegar.

Ninguém aqui discordou que o modelo de expansão, seja via Mais Médicos, seja via metodologia tradicional, possa ser adquirido a partir de pré-requisitos bem colocados. O que está se discutindo aqui é que a revolução do Mais Médicos foi justamente a possibilidade de trazer contrapartidas.

Vivemos hoje num país onde o gasto público é crescente. E as soluções inteligentes são justamente trazer a iniciativa privada para poder dividir esse investimento, claro, buscando sempre um resultado. Existe um prêmio para o risco do capital. Então, quando a gente entende que existe um modelo que é de responsabilidade do poder público, sim, a formação do trabalhador do SUS é de responsabilidade do gestor do SUS, é uma política pública muito importante. O legislador, lá na Constituição, colocou o SUS como Sistema Único de Saúde. Se ele é único e tem como seu pilar a formação de profissionais, a gente entende que é

função, sim, não só função, mas um dever dos gestores e das instituições que são constituídas. Por isso me preocupa muito quando a gente fala de conselho de especialistas. Nós temos as instituições, temos que fortalecer as instituições. Quem é o gestor da educação, quem é o gestor da saúde, quem são as entidades representativas. Então, a gente tem que ter clareza de quem são as responsabilidades. Dito isso, é importante que a gente absorva que é papel, sim, não só uma função, algo interessante, mas é uma obrigação de que o gestor estabeleça critérios.

Dentro desses critérios, nada mais interessante que você coloque contrapartidas sociais, essa coisa que gente viu ali que o prefeito colocou, as apresentações do secretário de saúde, onde sistemas municipais de saúde foram transformados.

Olha, a gente entende que precisa aumentar o número de vagas de faculdades de Medicina. Lá em Feira de Santana, temos uma faculdade estadual com 30 vagas por ano. Eu não tenho esses números, mas sei que o gasto público é muito alto para formar 30 pessoas, mas é importante para aquela região. Uma faculdade, como foi dito aqui, Jaraguá do Sul, se não me engano, ela disponibiliza 10% de bolsa. Quer dizer que, se eu tiver quatro ou cinco faculdades como Jaraguá do Sul, o número de bolsas equivale a uma faculdade de Medicina. Isso não é trazer a iniciativa privada? Por isso que eu não entendo essa dualidade hoje, onde a

iniciativa privada está sendo alijada do processo. Todas as faculdades aqui são privadas. O que se colocou foram requisitos de que tivessem, para além do resultado, porque volto a dizer, a iniciativa privada precisa de um prêmio para o risco do capital, mas precisa ter uma função social. É mais inteligente eu investir na construção de uma faculdade ou trazer as faculdades de Medicina que têm um resultado robusto financeiro e poder viabilizar que pessoas pobres daquela região possam estudar Medicina e efetivamente transformarem a realidade de suas regiões.

Então, eu digo que o modelo do Mais Médicos é um modelo transformador, é um modelo que deu certo, é um modelo que não pode concorrer com outro. Dizer que tanto faz, o modelo do Mais Médicos pode conviver com o modelo tradicional, não. Porque quando eu concorro com o modelo tradicional, eu deixo de ter o prêmio social. Qual prêmio social? As contrapartidas que estão estabelecidas.

Eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde desse Município de Alagoinhas. Eu assinei o Coapes. E lá, 10% de toda a renda, do faturamento bruto das faculdades iam para um Coapes. O Coapes é um grupo. Esse grupo tem maioria da Secretaria Municipal de Saúde. É ela que define as prioridades e as políticas públicas junto com a faculdade. E pode parecer - a gente está em Brasília -, que um aparelho de videolaparoscopia não faça sentido para

gente, mas faz muito sentido para o pobre, para o vulnerável que está em Alagoinhas, que não tinha a oportunidade de ter um tratamento que é eficaz, que é de mais baixa morbidade e que só é viabilizado por causa da contrapartida, Doutor. Sabe por quê? Porque, para além da obrigação de dar vagas e para além da obrigação de ter 10% de repasse do faturamento bruto, é obrigado a ter residência médica. Lá tem residência médica de cirurgia geral. E para ter residência médica de cirurgia geral é preciso ter o aparelho de videolaparoscopia. Então, com isso, profissionais se fixaram em uma cidade com menos 200 mil habitantes, que a cidade de Alagoinhas, possibilitando com que essas pessoas tivessem efetivamente uma construção de um núcleo médico muito mais qualificado. Então, eu não entendo essa dualidade. As faculdades que estão lá são privadas. Simplesmente participaram de um concurso, de um chamamento público e todas puderam se colocar, e, em cada chamamento público, teve um vencedor.

Dessa forma, eu queria também salientar - e o Doutor Sílvio colocou - com relação à fixação de médicos. Não só seis anos, Doutor Silvio, a formação do médico é longa. Só poderemos avaliar isso depois de nove anos, porque a residência médica, geralmente, dura três anos, e a fixação do médico, a carreira do médico começa depois da residência médica. O médico que está lá no posto de saúde, na estratégia da saúde da família, na unidade básica, também deve ser especialista, precisa de dois anos de formação em especialidade.

Então, a construção de aumento de vagas de Medicina casada com o aumento de vagas de residência médica é o que é transformador. Não tenho dúvida aqui, não terá um uma audiência pública para discutir quem fornecerá residência médica. Por que não terá? Porque, na residência médica, o estudante recebe; na graduação, ele paga. Então, por que não casar isso e diminuir esse gasto público que é eminentemente do Estado, seja federal, municipal, estadual?

Por fim, queria comentar mais duas coisas, e sei do avançado do tempo. Com relação ao perigo de algumas relações causais por observações epidemiológicas. Foi dito aqui que, por ter um número baixo de médicos, as pessoas, no Brasil, morreram mais. Acho isso muito perigoso.

Eu tive uma aula no 4º semestre de Medicina de epidemiologia, e me disseram o seguinte - é clássico para quem estudou epidemiologia: o cafezinho dá câncer de pulmão. Mas ele dá câncer de pulmão, mas com associação. Associação é uma coisa. Ou seja, quem tem o hábito de tomar café, tem o hábito correlacionado de fumar. E o fumo, o tabaco é que dá o câncer de pulmão. Então, não podemos nos esquecer dos vieses. Os estudos observacionais são muito importantes, porque eles chamam atenção para que possamos nos aprofundar nos estudos. E obviamente, em uma pandemia, onde ninguém sabe muita coisa ainda, temos de ter a cautela para não estabelecer relações causais onde é impossível ser estabelecida, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo.

Como já estourei o tempo - se tivesse lido, poderia ser até mais rápido -, eu queria dizer que amanhã é o Dia do Médico. Como médico - e quantos médicos aqui estão presentes -, eu queria parabenizar a todos antecipadamente e dizer que o Mais Médicos é transformador. Deixar de ter essa opção, onde não há contrapartida... A pergunta do Ministro Gilmar foi: há possibilidade de ter qualidade sem ter o edital do Mais Médicos? Há. A questão é a contrapartida que existe, feita através de uma lei, votada no Congresso Federal, e que tem um impacto social gigantesco. Eu, sinceramente, não consigo entender a dualidade entre isso e efetivamente a livre iniciativa ou a liberdade econômica. Se houvesse, não tenho dúvida, a supremacia do interesse público seria muito mais relevante e, obviamente, a Justiça modularia isso sem dúvida nenhuma.

Muito obrigado

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor Rodrigo Matos.

Passo a palavra ao Doutor Vitor Rufino, que falará pela Associação de Mantenedores Independentes e Educadores do Ensino Superior.

O SENHOR VICTOR SANTOS RUFINO (ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR) - Prezado Doutor Lucas Faber, juiz instrutor desse gabinete; prezado Doutor Paulo de Sávio Nogueira, chefe de gabinete, a quem cumprimento o Ministro Gilmar

Mendes por essa audiência, em nome da minha, do meu cliente, a Amies, e dos meus colegas, o Doutor Esmeraldo Malheiros e o Doutor Pietro Lorenzoni, que gentilmente me cederam espaço para conversar com vocês.

Doutor Lucas, eu queria começar aqui falando sobre a minha perplexidade, de certa forma, sobre uma falsa dicotomia, uma falácia que vem sendo repetida o tempo inteiro aqui: a de que haveria um certo conflito entre a qualidade e a quantidade de vagas.

Esse conflito, ele não deve derivar, necessariamente, do número de cursos, ele deveria derivar - isso sim - da qualidade da regulação, da supervisão, da formatação das regras.

Ninguém está aqui dizendo que se vai abrir cursos no Brasil a trouxe-mouxe, a qualquer velocidade, com qualquer número. A regulação não permite!

O Brasil tem uma capacidade máxima, hoje, de vagas utilizáveis que estão ditadas por requisitos regulatórios; infraestrutura, você tem que ter cinco vagas, leito/SUS, para cada curso (para cada vaga, cinco leitos; para cada vaga, cinco leitos).

Se - se - o Brasil, em algum momento, chegar ao ponto de ter que discutir se vamos ter que ter mais leito para ter que ter mais vaga de Medicina, o Brasil deveria querer chegar a esse momento.

Essa dicotomia não existe.

Há uma outra que é ainda mais grave! Há uma outra falácia, uma segunda, que é ainda mais grave; a de que, por alguma razão qualquer, o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir se nós temos que escolher entre o sistema de chamamento, previsto na Lei do Mais Médicos, ou pelo sistema da Lei do Sinaes.

Essa dicotomia é falsa.

Essa dicotomia, curiosamente, está sendo colocada pelos autores da ação. São os autores da ação que vêm a essa tribuna, um após o outro, sem dizer diretamente, muitas vezes, que o Supremo deveria decidir entre o modelo da Lei de Chamamento e o modelo da Lei do Sinaes. Daí defendem a Lei de Chamamento, a Lei do Mais Médicos, atacam o regime do Sinaes.

E ouvimos aqui, ouvimos argumentos dos dois lados. Muita gente boa, muita gente boa dizendo que a regulação do Sinaes é suficiente, tem qualidade, é capaz de oferecer segurança para o sistema médico brasileiro, para a formação dos nossos médicos. Muita gente dizendo que a Lei do Chamamento é superior; e o contrário, também. Entretanto, essa dicotomia, ela só existe na cabeça dos autores da ação.

Eu quero deixar bem clara a posição da Amies, ela não quer que o Supremo decida entre um e outro. Ela não quer dizer que, necessariamente, deva-

se formar, devam-se abrir cursos, aumentar vagas pelo sistema de chamamento ou pelo sistema da Lei do Sinaes. Os dois podem e devem coabitar! E não pode ser justificativa, do ponto de vista de política pública e do ponto de vista de lógica jurídica, que a gente impeça um ou outro modelo, porque a gente tem medo de que haja uma inação das autoridades no controle de qualidade, quando as autoridades têm as ferramentas jurídicas, de recursos humanos e capacidade demonstrada de oferecer bons cursos, por um modelo ou por outro - por um modelo ou por outro.

Todos os cursos que vieram pelos modelos do Sinaes têm nota 4 ou 5 em qualidade. O de chamamento eu deixo para minhas contrapartes, que já vieram aqui e falaram dos benefícios do regime de chamamento.

Não se precisa decidir entre um e outro. Ponto! Deixem os dois coabitar - isso do ponto de vista de política pública, eu ainda irei chegar ao ponto de vista de lógica jurídica e de boa interpretação hermenêutica do nosso sistema constitucional.

Eu gostaria de, em primeiro lugar, alertá-los para esses dois pontos. Um terceiro ponto para o qual gostaria de alertar, Doutor Lucas, não dá para falar que não existe um problema sério de disponibilidade de médicos no país.

Foi falado sob vários ângulos: do ângulo regional, do ângulo de especialistas, do ângulo de médias comparadas com países desenvolvidos. Contudo, apelo, antes de mais nada, à consciência de cidadão de cada um, não dá

para dizer que o Brasil está numa situação confortável do ponto de vista de oferta de médicos. Não tem, em sã consciência, como se dizer isso.

Teremos uma discussão sobre números e essas discussões vão acontecer; nós vamos trazer os nossos. Mas como muito já foi falado, aqui, eu não vou reiterá-los para os senhores. Eu apenas apelo à consciência das pessoas para dizer se a gente tem ou não tem esse problema.

Qual que é o problema que a gente tem de qualidade? É curioso como tudo está vindo aqui: qualidade, qualidade, qualidade, qualidade. A qualidade é derivada da opção por um sistema ou por outro? Qual o sentido disso? Você só pode acreditar que a adoção por dois sistemas, a adoção comum dos dois sistemas vai levar uma queda da qualidade se você estiver apostando na inação das autoridades. Só isso justifica. Nem se você disser que apostar pelos dois modelos vai ter vaga demais, você pode chegar essa conclusão, porque, como eu falei, existe um redutor de infraestrutura na regulação. Nunca vai aumentar muito. A não ser que a gente queira que aumente, que o país discuta e deseje isso. Mas se ele chegar a essa discussão - eu repito - a gente deveria querer chegar essa discussão. E por que que nós deveríamos querer chegar essa discussão? Porque o Brasil tem o capital financeiro, o Brasil tem o capital - eu gostaria que se pedisse que se respeitasse a minha fala, Doutor Lucas, para as pessoas não ficarem... por favor.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Pode prosseguir, Doutor, por favor.

O SENHOR VICTOR SANTOS RUFINO (ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR) - Doutor Lucas, nós não precisamos fazer esse tipo de decisão que se está forçando o Supremo a decidir, porque o Brasil tem o capital. O Brasil tem as pessoas, o Brasil tem tanto o capital intelectual e financeiro, que a gente está exportando estudante de Medicina. Dados do Itamaraty: 65 mil estudantes de Medicina no Paraguai, Bolívia e Argentina. As pessoas estão saindo do Brasil para fazer o curso e, depois, tentar voltar; e, depois, tentar voltar.

O Brasil, que foi um país que se constituiu como um farol, um país de imigração, um país de construção de vida para gente de fora, está na situação insólita de exportar estudante de Medicina. Essa é situação que o Brasil está e é disso que está se tratando aqui, porque, no final do dia, o que se está propondo é se regular a qualidade pela escassez. Isso é um perigo, é um erro, é um erro que se decorre, pelo menos, da timidez, se não da covardia. Não se regula qualidade por escassez; se regula qualidade por competição.

É óbvio que ninguém vai abrir indefinidamente os cursos de Medicina - e nem deveria -, porque não vai ter capital humano, intelectual para isso.

Mas algum tipo de pressão competitiva tem que existir. É importante, vamos colocar as coisas em pratos limpos aqui.

Um predecessor meu citou o dado: houve uma fusão segunda-feira, sexta-feira, perdão, anunciada na Bolsa. Um custo de uma vaga de Medicina, no *evaluation,* estava de 2,4 milhões.

Existe, hoje, por causa da escassez, um aumento vertiginoso dos custos para o curso de Medicina, uma concentração em quatro grupos econômicos. Uma concentração perigosa, a longo prazo, para o país, porque um dos efeitos conhecidos de concentração é diminuição de qualidade e aumento dos custos, projeções de tíquetes aumentando.

A gente não precisa nem entrar, aqui, nas questões sociológicas, nos riscos sociológicos de você elitizar o curso de Medicina via preço. A gente tem que tomar cuidado com isso.

Então, eu faria, do ponto de vista de política pública, esse apelo: não há muito da dicotomia que se está tratando aqui. Tem formas de você fazer esses dois sistemas coabitarem no plano de política pública, as ferramentas estão dadas, e os exemplos práticos estão demonstrando isso. Há bons cursos nos dois modelos; há bons cursos, recém autorizados, nos dois modelos.

Mas, por fim, a gente não está num Congresso discutindo qual é a opinião melhor, nós não estamos fazendo política pública só, é política jurídica também. Nós temos a Constituição aqui.

Eu subscrevo tudo que foi falado pelo meu colega Doutor Diego Muñoz do ponto de vista de hermenêutica. A Constituição, quando trata de livre concorrência, livre iniciativa e de requisitos autorizatórios para a abertura de um curso, ela privilegia a iniciativa privada, no sentido de que ela tem a capacidade e a possibilidade de buscar o curso, ela estabelece a necessidade de autorização, coloca a qualidade como um dos requisitos de autorização. A gente tem uma lei que vem, e a gente tem uma lei especial para um programa que tem um significado muito particular e que deve continuar existindo. Essa lei não entra no sistema de antinomia com a Lei do Sinaes, e não precisa, como as partes querem pretender por meio dessa ADC, que o Supremo seja colocado na posição insólita de decidir por um modelo e outro.

E é por causa disso e com essas razões que a gente pugna que essa ação seja declarada, numa interpretação conforme da Lei do Chamamento, para que os dois sistemas - o Sistema de Chamamento e o Sistema da Lei do Sinais - coabitem o sistema jurídico brasileiro, como deve ser. E que o MEC, o CRM e todos os demais responsáveis pela supervisão coloquem seus esforços para que o ensino se dê com qualidade e o país, ao invés da timidez, aposte na ousadia, na nossa

capacidade de fazer frente a esse problema que, mais uma vez, existe, é grave, e é conhecido por todos nós.

Obrigado.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor Victor Rufino pelas contribuições e passo a palavra à senhora Iara de Moraes Xavier Braga, que vai falar virtualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.

A SENHORA IARA DE MORAES XAVIER BRAGA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR) - Bom, inicialmente eu quero cumprimentar a todos. Boa noite. Parabenizar o Ministro, o excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes por promover esta audiência pública. Agradecer a todos.

Eu fiz uma apresentação, que está aqui disponível, mas eu vou deixar a apresentação à disposição de todos. Dado o adiantado da hora, eu pretendo fazer uma síntese mais integradora de todos os pontos que eu ouvi aqui. E a apresentação fica, então, à disposição.

Eu quero inicialmente dizer que eu represento a Associação Brasileira de Mantenedoras da Educação Superior, que é uma entidade que completou 40 anos agora em agosto de 2022. É uma entidade que tem mais de 5 mil instituições de educação superior vinculadas a ela, associadas a ela. O presidente

da Associação Brasileira, da ABMS, é o Doutor Celso Niskier. E tem um grupo grande, nós temos um grupo grande, um grupo técnico, da área da saúde e da Medicina, discutindo conosco essa questão que é extremamente importante. E como muito bem foi mencionado, ela não é específica para Medicina. Todo curso de graduação, seja licenciatura, bacharelado, superior de tecnologia, tem que primar pela qualidade, pela inovação e pela criatividade.

E muito mais do que isso, os cursos precisam garantir o empreendedorismo e a visão verde, segundo os 17 objetivos de sustentabilidade ambiental da própria ONU. Então, assim, não é uma coisa específica do curso de Medicina. Mas esse dia foi muito produtivo, eu aprendi muito.

Eu quero rapidamente me apresentar, eu sou conselheira do Conselho de Administração da ABMS, sou doutora em saúde coletiva pela Fiocruz, trabalhei quase 40 anos em duas grandes universidades federais, por concurso: a Universidade Federal do Estado Rio de Janeiro, e me aposentei, em 2010, pela Universidade Federal de Brasília. E mais, também tive a oportunidade de ficar de 2004 a 2006 como coordenadora-geral de avaliação, implantando o Sistema Nacional de Avaliação, o Sinaes.

Eu fico muito abismada em ver que determinados expositores têm a coragem pública de chamar o Sinaes como modelo tradicional.

O Sinaes, como o SUS - o SUS é a Lei nº 8080, de 1990 -, não é uma lei tradicional. Tanto o Sistema Único de Saúde quanto o Sinaes são construções do povo brasileiro, leis aprovadas no Congresso Nacional, certo? Então, não tem essa coisa do novo, do antigo, do tradicional, são adjetivos que não cabem nesse debate.

Uma outra coisa que eu queria trazer também para nossa reflexão, muito bem foi apresentado, agora, pelo expositor que me antecedeu, é a questão da escolha de Sofia. Eu faço aqui, remeto a esse filme, *A Escolha de Sofia*, por que que nós temos que escolher o modelo do Mais Médico ou o modelo do Sinaes, que é uma construção coletiva e que é muito bem conduzida pelo Mistério da Educação? E que é, através do Sinaes, que todos os demais cursos são autorizados, reconhecidos, e renovados seus reconhecimentos.

O Sinaes é de 2004, já tem uma trajetória histórica importante. O único ano que o Sinaes não ocorreu foi 2020, por conta da covid. É uma série histórica do Enade, a cada três anos, os cursos fazem Enade. São avaliações institucionais, avaliações de curso, tem uma CPA com representação externa, que faz a autoavaliação e que posta, anualmente, no e-MEC, esse relatório da autoavaliação, que é um texto muito importante de avaliação das políticas públicas.

Então, o Sistema Nacional de Avaliação não é tradicional, não é antigo, é uma construção nossa, dos educadores, dos brasileiros, e ele, a cada ano,

se aprimora. Tanto é verdade que, no dia 13 de outubro de 2022, equivocadamente, como alguns expositores falaram, que está caducado, que os padrões são antigos, no dia 13 de outubro, a Seres publicou a Portaria nº 921, uma portaria importantíssima, publicada pela secretária Diana, da Seres. Essa portaria dispõe sobre as diretrizes para elaboração dos novos instrumentos de avaliação, os institucionais e os de curso. Então, ali nessa portaria, nós vamos observar a modernidade desses padrões, publicada agora, essa semana passada, esta portaria no Diário Oficial. E o Inep já tem grupos de trabalho reconstruindo os seus instrumentos.

A série dos instrumentos, como eu fui coordenadora durante três anos de implantação do Sinaes no Inep, esses instrumentos, eles são renovados a cada dois anos, só não foram ainda por conta da pandemia. Então houve um atraso nesse calendário, mas o Inep já vem trabalhando intensamente, todo o MEC, na elaboração de novos instrumentos de avaliação.

Os instrumentos de avaliação de 2017, dezembro de 2017, foram aplicados a partir de 2018 e são inovadores. Eles trazem, como critérios de análise, a inovação. Eles trazem a criatividade, os instrumentos são extremamente bem elaborados, testados e trazidos para o debate, também pelo Inep, de audiências públicas.

Os avaliadores têm total autonomia, porque, além de atribuir um conceito, tem um campo aberto onde os avaliadores podem escrever tudo o que eles desejarem, os avaliadores têm autonomia, têm transparência para avaliar *in loco* autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento.

Então a ABMS defende claramente que há possibilidade sim da conjugação de vários modelos de autorização, até porque, é só na autorização que se dá essa dualidade; já no reconhecimento, é totalmente pela lógica do Sinaes e a renovação de reconhecimento é totalmente pela lógica do Sinaes. Então, não temos que fazer essa escolha de Sofia. Há sim um grupo que defende fortemente a qualidade no Mais Médicos, mas seria importante também trazer experiências do Sinaes - aqui só foi dada a experiência dos três que falaram, basicamente agora o prefeito e as secretárias, da lógica do Mais Médicos -, mas eu tenho absoluta certeza de que, se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir também gestores de cursos de Medicina e de outros cursos da saúde vinculados ao Sinaes, nós teríamos também depoimentos riquíssimos.

E essa questão do ensino de serviço, de repasse de recursos não está na lógica do Mais Médicos, ela está nas diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares de 2014 - e eu aqui parabenizo o colega que falou, Doutor José Lúcio, que foi um dos autores, parabenizo o Conselho Nacional de Educação pelas diretrizes de 2014, que todas as bases da integração teoria-prática, ensino de

serviço, todas essas bases estão contempladas nas diretrizes, e são as diretrizes comuns para todos os cursos na lógica do Mais Médicos, na lógica do Sinaes, no setor público, no setor privado.

Além das diretrizes, tem uma outra normativa do Conselho Nacional de Educação, que eu acho muito apropriado trazer para o debate. Que normativa é essa? É a Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação, e lá nessa resolução está estabelecido que um curso de Medicina tem que ter, no mínimo, uma carga horária total de 7.200 horas e ele tem que ter, no mínimo, um tempo de integralização de 6 anos ou 12 semestres, independente da natureza da instituição ou do modelo de autorização. Rotular o Sinaes como modelo tradicional, modelo antiquado, modelo ultrapassado é negar os reconhecimentos dos cursos, porque os reconhecimentos se dão pelo Sinaes e não pelo Mais Médicos.

Eu acho que o Mais Médicos tem sim qualidade, contribuiu muito para o Brasil, mas o próprio Governo viu que o Mais Médicos já estava saturado, como o Doutor Henrique Sartori mencionou hoje de manhã, tanto que não se tem mais o Mais Médicos. O que nós temos hoje é Médicos pelo Brasil, e o Mais Médicos não é uma política de formação médica, nem de cursos de Medicina; o Mais Médicos é uma política, o objeto, o propósito principal da lei é trazer médicos do exterior para atuarem no Brasil, os cubanos, os espanhóis, os portugueses sem a necessidades de eles fazerem o Revalida, que é uma prova que

é feita para médicos do exterior atuarem aqui no Brasil. Então, a política do Mais Médicos tem esse propósito, não era trabalhar a educação.

E essa nova legislação que foi aprovada em 2019 do Mais Médicos pelo Brasil revoga dois artigos da Lei do Mais Médicos, exatamente os artigos que tratam da residência médica.

A residência médica não é uma característica, nem uma especificidade do Mais Médicos, ela sempre existiu. E os cursos aprovados pelo e-MEC, de forma administrativa pelo Sinaes também preconizam o repasse e também preconizam a questão das residências médicas.

A questão me parece clara, como muito bem foi mencionado. O Supremo Tribunal Federal não deve ter essa questão de ter que decidir pela escolha de Sofia: fica com o menino ou fica com a menina. E aí, o filme nos mostrou a barbaridade de uma decisão dessa natureza nessas condições.

Uma outra questão que eu queria pontuar, já para encerrar, é que a avaliação foi muito falada aqui. A avaliação é indutora da qualidade, sempre foi. E eu sou uma pesquisadora que estudo muito sobre a avaliação da educação superior. Então, a avaliação, no mundo inteiro, é indutora da qualidade, independentemente do Mais Médicos, ou do Sinaes, ou de outro modelo.

A questão é que nós estamos falando da avaliação em várias dimensões. E foi dito aqui por alguns expositores, e eu respeito, mas foi dito que os cursos de Medicina não são avaliados. Nós temos avaliação do sistema e temos a avaliação do processo ensino-aprendizagem, que ocorre pelo corpo docente. E são os professores, é uma prerrogativa didático-pedagógica. Quem avalia o desempenho do aluno, o nível de competência, de habilidade, de atitude, de amadurecimento são os professores que atuam naquela matriz curricular, naquele projeto pedagógico. Então, há, sim, um sistema de avaliação.

O Brasil, eu sou muito otimista, às vezes, um pouco criticada por isso, mas, há mais de 40 anos, atuando na educação superior na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu cheguei a vice-reitora, e, na UNB, onde eu me aposentei em 2010, eu digo assim: eu sou muito otimista! Eu vejo que os cursos do Brasil, principalmente os da saúde e de Medicina têm, sim, qualidade.

A maioria dos médicos que falou aqui hoje foi formada por esse modelo, pelo Sinaes, e eu tenho absoluta certeza de que eles têm muita qualidade.

Cursos bons e ruins têm nos dois modelos. Nós vamos encontrar no Mais Médicos e vamos encontrar também no modelo do Sinaes, do e-MEC.

E queria, por fim, dizer que eu concordo com o Doutor Bruno Coimbra e com o Doutor Paulo Chanan, que falaram hoje à tarde, fizeram suas

exposições, quando eles mostraram que nenhuma liminar está dando, autorizando curso de Medicina. As liminares estão, e a ABMS vem acompanhando com muito cuidado essa matéria, as liminares dão o direito de instituição, a mantenedora abrir um processo de autorização no e-MEC. E a Seres abre e não fala que tem que ser pelo padrão da 20, da 40, coisa nenhuma.

Por último, eu queria dizer que, na verdade, o e-MEC não foi fechado com a Portaria nº 328, de 2018. O e-MEC foi fechado para as instituições privadas abrirem seus processos de autorização do curso de Medicina em 2013, antes da Lei do Mais Médicos, por uma portaria que definiu o calendário, e essa portaria é publicada anualmente, o calendário regulatório da secretaria. Então, o e-MEC foi fechado em janeiro de 2013 e, em 2018, veio a Portaria nº 328, que, na verdade, estabeleceu uma moratória, muito mais até para o Mais Médicos, dos editais, porque o e-MEC já vinha fechado desde 2013 e as instituições privadas não podiam postar o pleito de uma autorização de Medicina.

Muitos já falaram dessa questão jurídica - por que a judicialização? Deve-se pensar também que o Brasil realmente precisa de mais médicos. Não é à toa que o programa se chama Mais Médicos, a lei também. E precisa, sim, porque a OCDE hoje tem um indicador de 3,5 dos 37 países que a

integram, e o Brasil agora está com 2,3 médicos por mil habitantes, esse nosso país, que é um continente, é imenso, está entre os seis maiores países do mundo.

O IBGE projetou um dado muito importante em 2021. Nós temos mais de 203 milhões de brasileiros que carecem de saúde, que carecem de educação e que carecem de políticas públicas que possibilitem, cada vez mais, o crescimento e o desenvolvimento do nosso país, e isso só se dará por educação e pela educação.

Muito obrigada!

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço as contribuições da Doutora Iara Xavier e passo a palavra ao Doutor Ricardo Tonassi Souto, que falará pelo Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação.

O SENHOR RICARDO TONASSI SOUTO (FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS E DISTRITAL DE EDUCAÇÃO) - Desejo uma boa noite ao Juiz Instrutor Lucas Faber e ao Chefe de Gabinete Paulo Sálvio!

Uma boa noite a todos que nos assistem na TV Justiça, os que ficaram até tardiamente aqui.

Já que estamos no tardio da noite, oito e meia da noite, proponho um exercício de criatividade em que, neste exato momento, no

hemisfério norte, na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, nas melhores faculdades de Medicina do mundo, o reitor da Universidade de Harvard, o reitor da Universidade de Yale, o reitor da Universidade Johns Hopkins, o reitor da Universidade de Stanford estivessem reunidos e falando: "De que forma a gente pode ajudar o Brasil?" E um deles falasse assim: "Vamos escolher um de nós para que possamos abrir o curso de Medicina, levando nosso selo de qualidade para lá". Um menino, no fundo da sala, descendente de brasileiros, antenado com o que acontece no Brasil, fala assim: "Reitor, não é possível, não, eles não estão recebendo inscrições, não há vagas". É absolutamente risível. Aqui me aparenta - antes de me apresentar - que o ovo da serpente está na suspensão do pedido de ampliamento de vagas, de credenciamento, de autorização. Aí é que está o grande problema e vou falar por quê.

Aqui me apresento. Meu nome é Ricardo Tonassi. Sou Presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação do país. Com exceção do MEC, as únicas instituições e órgãos públicos que podem abrir cursos de Medicina somos nós. Autorizamos cursos de Medicina.

Os incautos que não conhecem a legislação - e isso não é um pecado - falam assim: "Como é que é? Há órgãos públicos que podem abrir cursos de Medicina que não o MEC?" Há. Os cursos de instituições que se encontram na seara dos sistemas estaduais e distrital de educação.

As duas maiores universidades do país, USP e Unicamp, não estão no sistema federal de educação. A USP e a Unicamp, assim como a minha UERJ, por exemplo, do Rio de Janeiro, estão atreladas a seus sistemas estaduais. Quem trata da criação, ampliação, autorização, credenciamento não é o MEC, quem trata é o conselho estadual de educação daquele estado.

Aí está a prova - aqui fica muito claro, não há mais crianças aqui - de que há por trás dessa ação judicial, óbvio, um embate bilionário, de bilhões de dólares, que envolve os cursos de Medicina do país. Há aqui, óbvio, uma intenção - como foi dito aqui por um colega, uma *sham litigation* - de tratar de assuntos concorrenciais nesta seara, em que acho que ela não deve ser tratada. Obviamente, o Ministro Gilmar Mendes - e aqui eu já o saúdo e o Supremo Tribunal Federal por nos permitirem esta audiência pública - vai saber tratar muito bem do assunto.

O assunto é tão complexo e a percepção dessa complexidade se dá mesmo que você não tivesse nenhum conhecimento da matéria, se tivesse vindo aqui hoje e tivesse ouvido um representante do Ministério da Saúde dizer que o Brasil não precisa de mais médicos. Em quarenta anos, ganhamos cem milhões de habitantes, mas, sob a ótica dele, não precisamos de mais médicos e o Revalida é fácil.

Sem nenhum tipo de arrogância, afirmo: sessenta por cento dos médicos do país não passariam no Revalida. Faço essa alegação sob a mesma ótica

de que 85% dos alunos que saem da graduação não passam no exame da Ordem. Com todo respeito ao que disseram, não é uma provinha, não! Assim como o Revalida também não é uma provinha, não!

A gente vê a complexidade do assunto quando o representante da Associação Nacional das Universidades Privadas cita Paulo Freire. Aí realmente é complexo; não são amadores que compreendem esse tipo de coisa. Vi aqui, nessa discussão, pesquisadores públicos, lado a lado, com capitalistas convictos. Também não é simples de compreender.

Vi críticas à qualidade dos cursos de Medicina do país na frente do Ministro da Educação. Se pudesse haver um grito é: feche-as! Feche-as! Feche as universidades de má qualidade, ontem! Ninguém aqui vai ter universidade de má qualidade de estimação! Pode fechar! Não faz falta nenhuma nesse país! Mas feche-as! Então, aqui a gente tem uma situação absolutamente complexa.

No país, temos mais de quarenta universidades estaduais, que não estão sob o julgo do sistema federal de educação e mais de setenta instituições municipais de ensino. Elas também têm Medicina e, geralmente, a um custo muito mais baixo do que as privadas - as que podem cobrar, obviamente, porque instituições municipais criadas antes de 1988 podem cobrar, sim, e existem no país, em Tocantins, em Pernambuco, em Goiás, em Santa Catarina.

E não temos problemas com liminares. Não fomos processados. Não há discussão alguma com relação a vagas ofertadas pelo sistema estadual de ensino de cada um dos estados. Então, óbvio que aqui é uma discussão com relação ao mercado! É óbvio! E ela pode ser de forma periférica ou um efeito colateral da decisão que vai ser concedida.

Vi aqui afirmações de que se busca o Judiciário para permitir liminares para abertura de cursos - já foi dito aqui que não é verdade. Homens de bem costumam buscar o Judiciário quando precisam resolver problemas, é assim que funciona. Eu não acredito e não quero crer que magistrados sérios tenham proferido liminares de forma irresponsável. Se proferiram as liminares é porque a sua compreensão é de que alguma norma ali estava sendo violada e foi apontada por aquele que buscou o Judiciário para resolver seu problema.

A quem beneficia a concentração de vagas em cursos de Medicina por grandes grupos financeiros? Aos educadores não é; aos médicos também não é.

Temos três grandes grupos no país, que controlam quase 40 mil, das 140 mil ofertadas. Isso é um grande negócio! Óbvio que é! Não vou nominar porque não precisa cair no campo da indicação nominal. Um dos grandes bilionários deste país, que vende *ketchup*, comprou 50 escolas no Rio de Janeiro na

pandemia. E já as vendeu! Porque vislumbrou ali um bom negócio. É justo? Óbvio que é!

Vamos colocar, cada um, a sua cara a tapa, para dizer o que deseja. Uns desejam educação; outros desejam Medicina; outros desejam lucro. É assim que funciona o mundo. Mas não vamos camuflar os personagens dessa história, porque não há crianças aqui!

A gente falou sobre o problema da interiorização do país. Por mais drástica que seja, a figura do serviço militar obrigatório está presente. Todos aqueles que saem da faculdade de Medicina são obrigados a fazê-lo. Óbvio que é uma discussão absolutamente dura, e vamos entrar na igualdade de gênero, mas há uma solução, que tem obrigatoriedade sobre ela gigantesca.

Reclamou-se da ausência de docentes de Medicina dando cursos ou aulas para alunos de Medicina. Vamos discutir então a quebra dessa excrescência chamada "dedicação exclusiva" por parte das universidades federais e estaduais.

Os mais qualificados docentes academicamente se encontram nas federais e nas estaduais, por força de concursos absolutamente exigentes, em que se necessita titulação acadêmica. Mas não podem sequer clinicar, ou, no campo do Direito, advogar, sem incorrer em improbidade administrativa ou peculato. Por quê? Porque possuem dedicação exclusiva e não podem auferir nenhum tipo de

renda, a não ser em pouquíssimas exceções, como direitos autorais, palestras ou qualquer coisa que o valha.

Já me encaminho para o fim.

"Ah, que os médicos não tenham medo da prova de proficiência! Não vai matar ninguém, muito pelo contrário, vai impedir que maus profissionais estejam atuando no mercado, assim como acontece com a advocacia". Se é bem verdade que existem advogados que mal sabem escrever, existem médicos que não sabem clinicar. Se é bem verdade que há advogados que comprometem a qualidade de vida dos seus clientes, há médicos que fazem a mesma coisa. É necessário que cortemos na carne, mas há uma diferença. Nós, advogados, vivemos de apontar o erro do outro. Não há grande corporativismo na nossa profissão. Nós apontamos o erro do outro e é assim que funciona a vida.

Por fim, agradeço imensuravelmente a oportunidade de me dirigir aqui. A gente vê o tamanho da confusão desse problema quando, no templo maior do Poder Judiciário do país, vejo médicos palestrando sobre a constitucionalidade de normas. Sinto-me como se estivesse no Israelita ou no Einstein falando sobre o sistema cardiorrespiratório.

Muito obrigado!

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor Ricardo Tonassi e passo a palavra ao Doutor

Raphael Carneiro, que falará pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Ceará.

O SENHOR RAPHAEL CARNEIRO ARNAUD (SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ) - Muito boa noite a todos.

Na oportunidade em que cumprimento as autoridades aqui presentes, na pessoa do Juiz Instrutor Doutor Lucas Faber, também do Chefe do Gabinete do Ministro Gilmar Mendes, eu registro o agradecimento do SINEPE-CE à louvável atitude de Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes em realizar a audiência pública que hoje vivenciamos. Ela representa, para a sociedade que nos assiste, fielmente, a preocupação que a Suprema Corte deste País tem com o povo do Brasil. Essa convocação é a apresentação à população de que o Supremo Tribunal Federal reconhece as dores das pessoas mais necessitadas e está disposto a ouvir a sociedade nos seus reclames, para melhor fundamentar as suas decisões.

Todos nós reunidos e que falamos nessa sala falamos através da transmissão da TV Justiça para milhares de brasileiros que conhecem mais do que deveriam as dificuldades em exercer um direito que pede urgência, Doutor Lucas, aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa Constituição, no seu art. 196, assegurou a todos indistintamente: o acesso a uma saúde pública de qualidade.

Falamos nesta oportunidade também às futuras gerações de médicos que serão formados em território nacional, sem os quais jamais será possível realizar as políticas sociais de enfrentamento às enfermidades previstas pela nossa Carta Magna.

Hoje buscamos oferecer subsídio para dois caminhos possíveis, para duas estradas possíveis de serem pavimentadas. Deveremos escolher se trilharemos o caminho promotor da livre iniciativa, que nos conduz a um acesso mais democratizado à saúde, a uma educação superior de qualidade; ou se hipotecaremos o nosso futuro, em nome de grandes grupos educacionais, como aqui se falou, que se valem de uma interpretação restritiva e inconstitucional da norma para consolidar oligopólios do ensino privado.

Através da contribuição dos qualificados *amici curiae* que por aqui passaram, recebemos valiosas informações sobre medidas essenciais ao funcionamento adequado dos cursos de graduação em Medicina no País. À guisa de exemplo, cito o discurso da Doutora Diana Guimarães Azin, representante do e-MEC, que, pela manhã, proferiu esclarecedora fala a respeito da fundamental função regulatória e fiscalizatória do poder público sobre a qualidade de ensino.

O SINEPE-CE não se contrapõe de maneira nenhuma à ideia de que, para oferecer vagas em cursos de Medicina no Brasil, as instituições de ensino

necessitam atender às condições de exercício dessas ofertas e devem, sim, ser fiscalizadas com o máximo de rigor possível.

Chamo a atenção, todavia, Doutor Lucas, que o art. 3º da Lei do Mais Médicos esteja servindo de amparo para que o poder público obste o simples protocolo, como aqui se disse, do pedido de abertura de cursos, o que viola, como também já se falou, o direito de petição, prejudica a livre iniciativa, a autonomia universitária, reduz a concorrência e, aqui sim, atinge de forma insofismável a qualidade dos próprios cursos que pretendemos proteger.

Por tudo que já ouvimos no dia de hoje, eu me sinto absolutamente à vontade para afirmar que o Brasil tem condições de formar, em território nacional, mais médicos, de modo a um dia atender com dignidade a sua população, hoje desamparada não em algumas regiões, como querem alguns fazer parecer, mas em todas as regiões do País.

Segundo dados do e-MEC, publicados agora, na última quarta-feira, dia 12, o Brasil possui 388 cursos de Medicina ativos atualmente. Somando as instituições públicas e privadas, são exatas 41.825 vagas anuais de medicina. Para fins de comparação, o número de vagas em enfermagem é quase cinco vezes maior: são 188.495; são mais de 128 mil vagas para fisioterapia; 102 mil para nutrição; 41 mil para Medicina. Para que tenhamos um correto parâmetro do que representa

388 cursos de Medicina em um País com dimensões continentais como o nosso - e já fora dito aqui -, é preciso analisar os números em perspectiva.

Um escritor português, até hoje único ganhador de um prêmio Nobel de literatura em Língua Lusófona, José Saramago, escreveu em uma de suas obras que pra ver a ilha é preciso sair da ilha. Por isso, saiamos na nossa ilha e entendamos, de uma vez por todas, a complexa realidade da educação nacional.

Segundo o último censo da educação realizado em 2020, há dois anos nós possuíamos, por exemplo, 2.173 cursos na área de Comunicação e Informação para formar jornalistas; 6.522 cursos em Engenharia, Produção e Construção. Repito, são 388 cursos de Medicina para todo o País.

A crise sanitária que nós enfrentamos nos últimos anos precisa ter nos deixado alguma lição, Senhoras e Senhores. Hoje, somos menos 700 mil brasileiros vitimados por uma única doença. Sem a força da iniciativa privada, que oferta, hoje, no mercado, segundo dados do MEC, 70% dos médicos que chegam a atender a população, quantos menos brasileiro seríamos, Doutor Lucas?

Parafraseando um célebre discurso de um Deputado chamado Alcídes Carneiro, falecido em 1976, médicos são profissionais que, por infelicidade, procuramos, mas é por absoluta felicidade que os encontramos.

Escassez, essa sim, é um termo da política econômica que até pode servir de ferramenta para hipervalorizar os preços de vagas em cursos de

ensino superior, como aqui já foi dito pelo Doutor Vitor, mas definitivamente não serve ao intento idealizado pelo legislador constituinte de garantir aos brasileiros amplo acesso a uma saúde e uma educação de qualidade.

Enfrentar a distribuição desigual de médicos do nosso País é, sim, uma finalidade da Lei do Mais Médicos. Não faz sentido, entretanto, combater essa desigualdade através de uma política restritiva de vagas para formação de profissionais escassos em todo o território nacional. Menos médicos não gera melhor distribuição de médicos; menos médicos gera maior escassez de médicos. E só isso.

Mais cedo, o ilustríssimo Ministro da Saúde, Doutor Marcelo Queiroga, meu conterrâneo, ao citar o caso da nossa Paraíba, foi contundente em dizer: As vagas nas escolas existentes não descentralizaram os médicos.

Fundamental lembrarmos que, ainda hoje, estamos muito distantes de atingir os 3,5 médicos por cada mil habitantes recomendados pela OCDE. Com a Lei do Mais Médicos, o que nós buscávamos era sair de 1,83 médicos por mil habitantes, em 2012, para pelo menos 2,24 médicos por cada mil habitantes em 2022. E quer saber? Nós falhamos. Nós não alcançamos esse número. E, ao falharmos, ajudamos a perpetuar a desigualdade da distribuição de médicos e a necessidade daqueles que não podem esperar por mais tempo que nós acertemos.

A louvável finalidade de redistribuição não será atingida simplesmente remanejando cursos e vagas para regiões mais necessitadas. E sabem como eu posso dizer isso, não obstante seja verdade que ainda tendo o curso de Medicina 6 anos, esses médicos não tenham chegado ao mercado? Pelos índices do próprio MEC.

No já aludido estudo apresentado, como disse, muito recentemente, na última quarta-feira, dia 12, lê-se, já na página 2, que 73,3% dos cursos de Medicina autorizados no Brasil estão alocados no interior do país, contra apenas 26,8 alocados nas capitais.

Se a realocação de vagas fosse, de fato, determinante e eficaz em redistribuir médicos, seriam as capitais, neste momento, a enfrentar o maior problema da falta desses profissionais de saúde.

Hoje, 17 de outubro, Dia Nacional da Vacinação, é provavelmente um dia adequado para lembrarmos de uma outra dura, mas necessária lição, que a pandemia do covid-19 nos deixou: não é possível vencer uma doença atacando-a com remédio ineficaz. Como também não será eficaz atacar o problema da distribuição desigual de médicos no Brasil por meio de uma política que restrinja a formação dos novos médicos dos quais precisamos.

Eu já me encaminho para o meu último tópico, dado o adiantar do tempo, para dizer que o que se vê, diante da controvérsia que se estabelece nesta

Casa, é que ela transita entre o reconhecimento da constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871 e a interpretação do seu alcance.

A inconstitucionalidade da interpretação proposta nesta ADC, Doutor Lucas, não precisa redundar na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo em análise.

O tema encontra solução no uso de interpretação conforme a Constituição, de modo a esclarecer a coexistência entre a sistemática geral de autorização de cursos - o chamado credenciamento - e a sistemática de chamamento público.

Se a política implementada pelo Programa Mais Médicos foi de ampliação, o chamamento público previsto pela lei só pode ter função de atrair, e não de restringir, o acesso à população a mais médicos, o que gera o nome da lei.

Interpretar a Lei nº 12.871 de outra maneira é esvaziar a sua finalidade, é conferir à norma uma interpretação ab-rogante da própria norma.

A questão se resolve pela compreensão de que há dois regimes relativos à autorização para o funcionamento de cursos de Medicina neste país, que são, de fato, complementares: o pedido convencional - como prefiram chamar - e a participação em um edital de chamamento público.

Eu encerro, aqui, a minha participação, nesse exíguo tempo que o SINEPE do Ceará tem para se manifestar, na esperança de que tenha contribuído

ou trazido algum subsídio para que achemos uma solução justa, condizente com a vontade do legislador, mas, acima de tudo, constitucional ao tema desta audiência pública.

Finalizo citando, como não poderia deixar de ser, uma vez que representante, como diversas vezes mencionei, de um sindicato do Ceará, a frase de um cearense célebre que muito orgulha o nosso país. Clóvis Beviláqua, certa vez, disse que quando um país está atrasado por falta da atividade intelectual, é impossível que esse país se eleve.

Muito obrigado, Senhoras e Senhores!

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor Rafael Carneiro e passo a palavra ao Doutor José Roberto Kovac, que falará, virtualmente, pelo Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior do Estado de Pernambuco.

O SENHOR JOSÉ ROBERTO KOVAC (SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E DE PERNAMBUCO) - Quero cumprimentar a todos, também principalmente o Ministro-Relator Gilmar Mendes, o juiz instrutor, o representante da Procuradoria-Geral da República, o da AGU e todos que estão participando deste momento especial que é essa audiência pública.

Eu estou aqui representando o SEMESP, que é o Sindicato de Ensino Particular Superior de São Paulo, e também o Sindicato de Ensino Superior de Pernambuco. E quero louvar, quero agradecer essa oportunidade de participar desta audiência pública, pois o tema, realmente, é de extrema relevância, e talvez não seja de tanta controvérsia como se possa imaginar.

Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui uma provocação. Vamos imaginar que saísse, agora, uma chamada "Lei do Ensino Superior". E a lei determinasse o seguinte: que todas as instituições teriam que, para credenciar instituições ou autorizar cursos, se submeter a um chamamento público definido, inclusive, pelo processo de licitação através de um certame.

Eu pergunto o seguinte: se essa lei surgisse, todos nós, todas as instituições de ensino superior estariam, aqui, defendendo o óbvio, dizendo o seguinte: não pode ter esse meio como único. Afinal de contas, a Constituição, no art. 209, estabeleceu as condições administrativas de acesso do ensino. Isso para mim é muito claro.

E o segundo ponto é que essa lei, ainda que viesse a existir, ela não está revogando todas as leis que estão vinculadas à educação superior no Brasil, em especial a LDB, denominada Lei Darcy Ribeiro, como também a própria Lei de Sinaes e o conjunto de sistema de avaliação que existe no país.

Mas eu queria contextualizar um pouco a Lei do Mais Médicos.

Antes da Lei do Mais Médicos, já em 2011, o Ipea já dizia que estava faltando médicos. Assim também como o Conselho Federal de Medicina elaborou um estudo sobre demografia médica ao Ministério da Saúde, que revelava a distribuição desigual dos médicos no território nacional brasileiro e também entre o sistema público e privado.

Curiosamente, da mesma forma como o Ministro Gilmar Mendes fez este chamamento para uma audiência pública, o Ministério da Educação, naquela oportunidade, também o fez: chamou todas as entidades representativas. E, de forma unânime, todas disseram uma coisa óbvia: o Ministério pode - e até deve - criar, por intermédio de políticas públicas, fomento para que localidades onde não existam médicos, onde não exista o curso de Medicina, o façam por intermédio de uma provocação de chamamento público.

O exemplo mais claro que nós tínhamos é o Município de Guarulhos. O segundo município do Estado de São Paulo não tinha um curso de medicina. O que cabe ao Estado fazer? Estimular que as instituições venham requerer o curso por intermédio de um procedimento diversificado. E o que se defendia naquele momento, o que as instituições defendiam, todas as entidades representativas, era que o chamamento público não poderia eliminar o processo de autorização de cursos, como são em todos os cursos, não é só Medicina. Não existe,

hoje, no nosso sistema legal e, principalmente, constitucional, excetuando a condição de Medicina.

Os cursos nas áreas de saúde, sim, têm um tratamento diferenciado, inclusive retirando a autonomia das instituições, pois elas têm que pedir, solicitar efetivamente, junto ao Ministério da Educação, o curso. Então isso realmente faz sentido.

A própria Anup**,** naquela oportunidade, na Folha de São Paulo do dia 13 de setembro de 2003, foi contrária ao edital de chamamento do Mais Médicos.

E é interessante, porque eu entrei no ensino superior em 1988, exatamente na Constituição. E, na época, eu era um servidor público, eu trabalhava no Ministério da Educação, especialmente em relação à alfabetização de adultos. E como eu trabalhava no setor, eu tinha que fazer o acompanhamento do processo que vinha da Constituição.

Naquele momento, vi presentes as entidades representativas lutando por uma coisa especial na Constituição: a introdução do art. 207, que é autonomia universitária, e do art. 209, que é exatamente o acesso da livre iniciativa ao ensino mediante requisitos, que é autorização e avaliação por parte do Poder Público e respeito às normas gerais de educação. Então, essa é uma luta e foi uma

luta do setor, de todo o setor, sem excetuar, porque era importante realmente considerar a importância das instituições privadas.

E nós temos um sistema, hoje, de avaliação que é um sistema complexo, porque ele cuida, no caso dos cursos, de três dimensões, e no caso das instituições, de dez dimensões. Passa pelo Inep, passa pela Seres, dependendo, passa pelo Conselho Nacional de Educação, depende de homologação, depende de portaria. É um sistema extremamente complexo, o que significa dizer que é complexo porque o setor privado precisa ter todo um processo efetivamente de autorização e de avaliação.

E, diga-se de passagem, quando se critica, se fala a respeito de qualidade, *et cetera* e tal, sem dúvida alguma a legislação já estabelece os procedimentos necessários para o processo de supervisão e monitoramento, ao limite do art. 46 da LDB, da intervenção na instituição. Mais ainda: suspensão do processo seletivo e suspensão da prerrogativa das condições de uma universidade.

Veja, o Mais Médicos, sem dúvida alguma, como processo indutor, faz todo sentido - pelo menos inicialmente, a gente poderia dizer, porque esse programa já vai para 10 anos. E é interessante o seguinte, quando se fala em judicialização, ela começou já no Programa Mais Médicos, a judicialização já começou ali. Não é de agora.

Agora, simplesmente está ocorrendo pelo fato de que está praticamente cinco anos sem qualquer possibilidade de a instituição requerer autorização do curso de Medicina. Ah, pode requerer todos os cursos, menos de Medicina. Qual que é a razão disso? Não faz nenhum sentido essa lógica.

Então, o que nós defendemos aqui é a coexistência, realmente, dos dois procedimentos, que são necessários, que são fundamentais e podem conviver.

Como foi bem colocado aqui, a questão não é dizer se é constitucional ou inconstitucional, até porque a constitucionalidade já foi discutida. O que é inconstitucional é não permitir que as instituições exerçam seu mister de requerer um curso superior, no caso, o curso, aqui, de Medicina.

E, diga-se de passagem, precisamos corrigir, porque não é verdadeiro o que foi informado até agora, que é a questão de dizer que o curso é autorizado por intermédio de juiz. E não é desse jeito. O que se pede é para que se abra o e-MEC, e ele passa por todo um processo de avaliação, que foi amplamente esgotado por aqui, por todos aqui presentes.

Por final, devido ao tempo, eu queria fazer algumas colocações em relação à questão do Mais Médicos e, principalmente, à restrição ao pedido de curso pela via regular.

A restrição não resolve o problema existente, hoje, em relação à necessidade de interiorização do Mais Médicos. E aqui foi falado várias vezes sobre isso. Não existe política pública para interiorização. Esse é o problema da política pública. Realmente, do jeito que está, estimula a judicialização.

Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando a política pública é extremamente judicializada, ou é porque ela está vencida, ou é porque ela precisa de correção, ou é porque tem alguma coisa errada. É um sintoma. A judicialização é o sintoma de que alguma coisa não está bem.

Transformar o ato de autorização de curso somente no formato de concessão pública, na realidade, significa dizer que há um erro enorme em relação a isso pelo seguinte: o ato de autorização, se for considerado no mesmo regime de concessão, é um ato precário. E na educação, evidentemente, não pode se ter a precariedade.

Tem que estabelecer, sim. Macula, dessa forma, o princípio da livre concorrência, não resolve o problema da falta de mais médicos em hospitais públicos, mesmo nas grandes cidades. Com os reflexos da pandemia, não foi revisitada a política de autorização de cursos, sendo extremamente necessária. A autorização do curso no modelo Mais Médicos, pelo chamamento público, não contempla cursos de Medicina em locais que necessitam do curso de Medicina. Esse é um outro fator também importante. Impede que instituições de qualidade, hoje,

inclusive que têm trajetória na área de saúde, também não possam fazer o pedido do curso de Medicina.

E quando se fala em barreira de entrada, tem que ter barreira de entrada, sim, e a legislação já tem. Qual que é a barreira de entrada, inclusive nos cursos de Medicina? É a observação do cumprimento da legislação educacional, da avaliação *in loco*, das diretrizes curriculares e normas relativas ao próprio curso indiscutivelmente.

Então o SEMESP, aqui, e o SINEPE apoiam, sim, a coexistência dos dois regimes, com avaliação de qualidade, com respeito à legislação quando a instituição não tiver a qualidade em seu curso, utilizando todos os processos já existentes na legislação, como supervisão e tudo o mais.

E, por fim, eu queria fazer um registro de duas falas que foram colocadas. Primeiro, da Associação dos Pneumologistas, em que se fez uma comparação da França e de Portugal em relação ao Brasil, dizendo que a quantidade de médicos no país, nos dois, resultara em menor número de mortes. Então, ou seja, nós estamos com falta de médicos. Então, é uma outra realidade. E a Doutora Ludhmila também, quando foi chamada, quando foi questionada se era o único meio de chamamento público a autorização, ela foi clara dizendo que não é o único meio, porque pode ter os outros meios, e ela defendeu aquilo que todo mundo defende, a qualidade.

E pode ainda acontecer, porque tem um parecer da PGR a respeito da legitimidade ou não da autora, ainda tem uma questão processual em relação a isso.

E renovo aqui o apoio das entidades que antecederam, como a ABNS, a ABRAFI, a ANACEL, o FENEP. E também, para conseguir atender o tempo, eu não repeti muito do que os meus colegas já falaram, falaram bem sobre o tema, por isso apenas estou reforçando com propriedade aquilo que foi falado aqui. E os nossos agradecimentos do SEMESP, SINEPE de Pernambuco a esta audiência que foi extremamente relevante e importante.

Muito obrigado.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) - Agradeço ao Doutor José Roberto Kovac e passo a palavra ao Doutor Paulo de Assis Ferreira da Luz, que falará virtualmente pelo Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior do Estado da Paraíba.

O SENHOR PAULO DE ASSIS FERREIRA (SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA) - Muito boa noite, Doutor Lucas. Gostaria de cumprimentar o senhor e também gostaria de cumprimentar todos os expositores que me antecederam. Uma das características de ser um dos últimos a falar é talvez ter que procurar o que

mais há a acrescentar quando nós concordamos com boa parte daquilo que ouvimos.

Na percepção do Sindicato das Instituições de Ensino Superior do Estado da Paraíba, compreende-se que não existe qualquer necessidade de retirada de um dos requisitos ou de um dos mecanismos de criação de novos cursos ou de ampliação de vagas ou o que quer que seja, e sim que é possível e completamente necessário que ambos coexistam. Como o Doutor Rafael, meu conterrâneo, que representou o Sindicato do Estado do Ceará, me antecedeu e falou, ele deixou muito claro que boa parte dos cursos de Medicina, boa parte deles particular ou não, eles estão situados no interior do estado. E aí, eu peço licença - e eu tentarei ser muito breve na minha fala em respeito ao avançado da hora - a falar da realidade do meu estado.

Nós temos, no Estado da Paraíba, nove instituições de ensino que atuam no curso de Medicina. Desses nove cursos, três na parte mais interior do estado, no que nós aqui chamamos de sertão nordestino. Outros dois, mais setorizados na região intermediária do nosso estado e os demais na nossa capital. E nós temos hoje 60% de médicos, em torno de 61% na verdade, de médicos situados mais precisamente na região da nossa capital, na capital João Pessoa, capital do nosso Estado da Paraíba. Ora, isso não se deve tão-somente ou exclusivamente em razão do número de cursos, se deve pelo fato de que existe uma

má distribuição de médicos em nosso país. E boa parte disso foi muito bem demonstrado pelo próprio Doutor Rafael, que há poucos instantes antecedeu a nossa fala, onde ele pontuou que, pelo número de cursos que temos de Medicina em nosso país, comparativamente com outros cursos da área de saúde e com a quantidade de profissionais que são lançados ao mercado anualmente, nós percebemos que, de fato, precisamos de mais médicos.

E, de fato, a política pública da legislação do Mais Médicos veio efetivamente para corroborar e trazer uma maior opção, uma maior quantidade e viabilidade de médicos, sobretudo nas regiões mais longínquas do nosso país. Mas, de fato, não é isso que a gente consegue perceber.

Então, não tenho dúvida alguma, Doutor Lucas e cada um de vocês que estão nos assistindo, de que não existe nenhuma necessidade de um dos modos se sobrepor ao outro.

Em nome do Sindicato, o qual estou aqui representando na condição de seu vice-presidente, eu defendo, e nós defendemos o maior grau e o maior número possível de hipóteses de aumento de cursos e de oferta de vagas e, claro, formação de novos profissionais, até porque isso é um aspecto até mesmo de democracia do acesso à educação. A partir do momento que se restringe isso para um método tão somente, onde talvez aquilo esteja circunscrito a um grupo um

pouco mais delimitado de agentes, de atores, nós não podemos entender que isso corrobora com aquilo que a própria Constituição Federal nos assegura, não só no contexto amplo do acesso à educação, da democracia e tudo mais, mas, a partir do momento que se retira essa oportunidade de acesso e de possibilidade de se lutar, inclusive judicialmente para que se tenha um processo analisado para vir ou não a ser autorizado, não se está criando curso novo através de ordens ou determinações judiciais.

Reitero, inclusive o que o Doutor José Roberto Kovac ainda há pouco também falou com total propriedade: não existe nenhuma determinação legal que crie vagas. O que se pleiteia judicialmente, o que vem sendo pleiteado judicialmente, o que vinha ou o que vem ainda a ser pleiteado, é tão somente a oportunidade de se ter o processo de abertura de cursos e vagas sendo analisado.

Então, eu não tenho dúvida alguma de que, para o bem do meu estado, para o bem da minha região, para o bem do Brasil inteiro, que deva ser mantido não apenas o modo tradicional, o meio tradicional, quer seja o modo clássico, considerando que ele indiscutivelmente também traz contribuições positivas e formação de profissionais de competência (isso foi dito no decorrer de toda esta audiência pública), como da mesma forma assim também o seja juntamente com o Programa Mais Médicos. É premente que seja mantida e que seja

preservada de uma maneira equânime, de uma maneira coexistente com critérios, com fiscalização, com o papel do estado sendo muito bem executado nas suas condições, mantendo-se os dois em favor no nosso país.

Eu peço licença, mas encerro aqui a minha fala tentando até ser mais breve em respeito ao avançado da hora, Doutor Lucas, e fico à disposição de todos.

O SENHOR LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA (JUIZ AUXILIAR) – Agradeço as contribuições do Doutor Paulo de Assis Ferreira e passo a palavra à Senhora Samara Agostinho, que falará pela Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina.

A SENHORA SAMARA AGOSTINHO (DIREÇÃO EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA) – Boa noite a todos!

Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, Doutor Lucas, todas autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, minhas saudações estudantis.

Sei que está tarde e todos estamos cansados, mas peço, por favor, atenção e respeito com a escuta da minha fala, pois sou a única representando, neste espaço, hoje, os estudantes de Medicina do Brasil.

A Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina - DNEM, diante desta tribuna, coloca-se a serviço da população brasileira, mantendo seu posicionamento histórico de defesa de um sistema único de saúde e de uma educação universal, gratuita e de qualidade.

Destacamos aqui o papel do SUS no combate à maior pandemia da nossa geração e o papel das universidades públicas no desenvolvimento de estudos e pesquisas para a criação da nossa vacina.

A criação do Sistema Único de Saúde é um marco histórico imprescindível para a análise da educação médica brasileira. Antes do SUS, durante o regime ditatorial, tivemos o desenvolvimento de um amplo mercado do complexo da saúde complementar e uma grande expansão das escolas médicas pagas no eixo sul/sudeste.

Após a conquista social da criação do SUS - na qual a DNEM teve participação ativa, com o seu primeiro coordenador-geral sendo um dos relatores da 8ª Conferência Nacional de Saúde - e das conquistas na área da saúde na Constituição de 1988, tivemos uma alteração significativa nas políticas públicas em saúde no Brasil. A pressão social conseguiu garantir a saúde como direito universal fundamental do ser humano e dever do Estado, além de tornar atribuição do SUS o ordenamento da formação de recursos humanos na área de saúde. Tendo

como princípios a universalidade, a integralidade e a equidade, os serviços de saúde se expandiram, provocando aumento dos postos de trabalho.

Apesar do aumento da demanda de médicos com a expansão dos serviços, o Brasil ainda apresentava, em 2013, um déficit de médicos e má distribuição dos profissionais pelo território nacional, concentrados nas capitais dos estados e nas regiões sul e sudeste. Hoje, quase nove anos após a sanção da Lei nº 12.871/2013 - o Programa Mais Médicos -, aumentamos o número de profissionais formados, mas ainda temos uma enorme disparidade tanto regional quanto entre as capitais e os interiores dos estados brasileiros.

Apesar de, desde 2011, termos aberto mais de 17 mil novas vagas em cursos privados de graduação em Medicina, com grande parte dessas vagas abertas no interior do país, sabemos que, até agora, a mão de obra formada nessas instituições não está sendo fixada nessas localidades após a conclusão da graduação. Há reflexões importantes para tal feito.

As mensalidades exorbitantes das escolas médicas pagas e as políticas insuficientes de concessão de bolsas fazem um recorte de classe de quem entra e de quem se mantém nos cursos de graduação em Medicina. Os estudantes que ingressam nesses cursos privados no interior de estados fora do eixo sul/sudeste não são, em sua maioria, estudantes pertencentes às comunidades dessas localidades e, por isso, retornam, após a sua formação, aos seus estados de

origem. Os programas de residência médica ainda estão concentrados no eixo sul/sudeste, fazendo com que os estudantes que buscam por especializações se desloquem aos grandes centros urbanos. Assim, mesmo com uma possível distribuição equânime das escolas médicas, sem termos uma garantia da fixação dos profissionais formados, não garantiremos essa equanimidade na oferta de médicos onde mais se precisa.

Embora o Programa Mais Médicos apresente falhas, a lei se pauta no tripé educação, infraestrutura e provimento, o que, desde os últimos anos, teve retrocessos, inclusive pelo aparecimento do Médicos pelo Brasil, que nem sequer cita os eixos de infraestrutura e educação. Além disso, temos condições precárias de trabalho, desestruturação da atenção primária à saúde, falta de insumos e de estrutura física das UBSs, fragilidade da estratégia da saúde da família, baixa remuneração na assistência e na docência e oferta de médicos sobrecarregados pela lógica da produtividade imposta por programas como o Previne Brasil. Advindos das cartilhas do FMI e do Banco Mundial, diminuem a qualidade do cuidado oferecido nos interiores do Brasil e desestimulam a escolha de médicos por permanecer nos interiores.

Permito-me utilizar uma frase de um dos maiores intelectuais brasileiros, Milton Santos, que nos alertou que:

> "A educação feita mercadoria reproduz e amplia as desigualdades (...). Educação apenas para a produção setorial, educação apenas profissional, educação apenas consumista, cria, afinal, gente deseducada para a vida."

Ora, então, olhemos para a estruturação da educação médica brasileira e façamos a reflexão: ela hoje prepara os estudantes de Medicina, nós, para o fortalecimento do SUS no interior do Brasil? Nós somos formados com o objetivo de construção da saúde pública brasileira? Nós nos educamos para a vida e para garantir a dignidade de vida da população brasileira nos cantos mais longínquos deste país com dimensões continentais? Infelizmente, os dados nos mostram que não!

A política de subfinanciamento crônico e o desfinanciamento recente do SUS e das universidades públicas, agudizada pela Emenda Constitucional nº 95, precariza os equipamentos e serviços públicos de saúde que são, conforme as DCNs de 2014, o cenário de ensino-aprendizagem que permitem aos estudantes vivenciarem situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho de equipe multiprofissional no próprio SUS.

Portanto, se é por meio da integração ensino-serviço que se pode vincular a formação médico-acadêmica às reais necessidades sociais de saúde da população brasileira, o desmonte do SUS e da educação médica não deveriam ser combatidos como forma de garantir a qualidade da educação médica?

A educação necessária para fornecer trabalhadores para a saúde em um país diverso como o Brasil só é possível através do reflexo dessa diversidade no acesso ao curso, com a priorização do ensino público e do fortalecimento da política de cotas. Da mesma forma, a formação de profissionais para o SUS precisa dar-se no SUS fortalecido.

Some-se a isso a necessidade de uma ampla e coerente fiscalização das instituições de ensino, a fim de saber se os critérios para uma formação de qualidade estão sendo cumpridos, para que não corramos o risco iminente de uma responsabilização exclusiva dos estudantes, a partir da instituição de um exame de ordem na Medicina.

A fiscalização deve ocorrer, portanto, por avaliações seriadas, como pelo teste de progresso, nas quais as escolas médicas se responsabilizam a melhorar e fortalecer a formação em saúde nas áreas em que os estudantes estejam menos qualificados.

A DNEM, por estar capilarizada em todo território nacional, sabe, a partir dos estudantes, a realidade das escolas médicas em nosso país. Muitas das instituições abertas pelos grandes conglomerados de educação médica, cujo capital é de origem estrangeira, a exemplo da Afya Educacional e da Kroton, abertas no interior dos estados, não garantem qualidade na formação médica.

Utilizaremos de exemplo a Afya Educacional, que, em 2020, ao abrir ações na bolsa Nasdaq, alcançou, apenas em especulações, um lucro de mais de 2 bilhões de reais. Segundo o Inep, em 2019, na Afya Educacional, o custo com os docentes por alunos é, em média, trinta e dois por cento da mesma despesa nas universidades federais; o investimento em pesquisa corresponde a 33% da média nas universidades públicas federais.

Em muitas unidades privadas, abertas no interior, em municípios que já existem universidades públicas, os grandes conglomerados conseguem pagar mais pelo cenário de prática, prejudicando o acesso desses outros estudantes.

Existe ainda uma disputa muito grande de campos de prática pela saturação de alunos nos serviços e da mercantilização que as universidades privadas fazem da entrada em serviços hospitalares, que são ainda, majoritariamente, privados ou filantrópicos, uma vez que não foi feita uma reforma hospitalar no Brasil junto com a implantação do SUS, perpetuando a lógica privatista hospitalar.

Principalmente nas escolas da Afya, há grandes investimentos em tecnologias de ponta, substituindo o contato humano, nos cenários de prática no SUS, por laboratórios modernos e centro de simulação realística, o que disfarça

o desvio de um ensino que seja voltado para o fortalecimento da saúde pública no Brasil.

Vou pedir ao Doutor Lucas mais três minutos para encerrar. Muito obrigado!

Crise no cenário de prática, demissão em massa de professores, falta de preceptores qualificados, utilização distorcida e precarizada de metodologias ativas para diminuir o retorno no investimento da formação dos estudantes, cursos públicos esvaziados e falta de carga horária prática desde o início do curso são algumas das realidades da maioria das escolas médicas hoje em nosso país.

Assim, enquanto os conglomerados tentam, a todo modo, agarrar-se à reserva de mercado da graduação em Medicina - tão lucrativa que é apelidada como "joia da coroa do ensino superior" -, as pequenas e médias empresas, que ficaram de fora dessa regulamentação a partir dos chamamentos públicos, também tentam, dentro da lógica neoliberal da livre iniciativa, conseguir suas partes de lucro. A concorrência pelas fatias do lucro da educação médica brasileira deve ser combatida. A regulamentação da educação em formação médica no país deve ter como orientação política única a ampliação do acesso à saúde pública gratuita e universal da população brasileira.

Expansão responsável do ensino superior é ampliar e fortalecer o ensino público. Quando falamos de uma formação em saúde de qualidade, precisamos pensar além da lógica da saúde médico centrada. Precisamos interiorizar não apenas cursos de graduação em Medicina, mas integrar, desde a graduação, toda a rede em saúde que o SUS prevê. Médicos, por si só, não garantem melhor acesso à saúde. É preciso, assim como prevê o SUS, uma equipe multiprofissional.

Faz-se necessário também dizer aqui o óbvio que ainda não foi dito. Se precisamos, para garantir a saúde em todo o território nacional, de médicos atuando em equipes multiprofissionais nos interiores do país, nas aldeias indígenas, nas comunidades quilombolas, nas periferias e nas favelas brasileiras, então precisamos de estudantes de Medicina que pertençam a essas comunidades interioranas, de estudantes de Medicina indígenas, de estudantes de Medicina quilombolas, de estudantes de Medicina periféricos e de estudantes de Medicina das comunidades das favelas. Precisamos, portanto, reorganizar a lógica de quem consegue acessar a graduação em Medicina no nosso país. Se a saúde é para o povo, precisa ser feita pelo povo. É urgente subverter o elitismo e corporativismo que contaminam a categoria médica, que, pelo perfil atual, recusa-se a trabalhar nesses postos de trabalho e auxiliar no cuidado em saúde dessas populações.

Se a crise da educação no Brasil, Excelentíssimo, não é uma crise, mas um projeto, e vivemos uma crise na formação em saúde brasileira, então faz-se imprescindível a reformulação do projeto.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado, Doutora Samara!

Senhoras e Senhores aqui presentes, caros Juízes, Juiz Auxiliar Doutor Lucas, caro Doutor Paulo Sávio.

Creio que tínhamos projetado produzir uma discussão bastante plural. Tenho a impressão - acho que os senhores hão de concordar - de que logramos ter essa visão nesta assentada da audiência pública, visões bastante abrangentes, com várias impressões e experiências coletadas no plano do estado, no plano dos municípios, sobre a realidade multifacetada do Brasil.

Certamente as comparações que fazemos - e somos obrigados a fazer - com vários países têm que também levar em conta um elemento de ponderação sobre a dimensão continental do Brasil e das assimetrias que existem.

Acho que todos nós, independentemente do seguimento do processo decisório, saímos bastante enriquecidos com as informações trazidas. Como disse também, em minha fala ao encerrar o bloco da tarde, nós, de alguma forma, teremos subsídios não só para a decisão desses dois casos que estamos a

examinar, mas certamente também para projetar e discutir a consistência de políticas públicas no campo que estamos a lidar. De fato, serão extremamente importantes, porque dizem, em última *ratio*, com a própria saúde das pessoas.

Agradeço a todos e a cada um pela participação e contribuição.

Muito obrigado a todos!

Declaro encerrada esta audiência pública.

****